FUTURE SECURE PROVIDERS

ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கலாம்

A Practical Guide in Conversational Tamil



எளிய பேச்சுத் தமிழில்
முழுமையான **Advisor** பயிற்சி நூல்

பேச்சுத் தமிழ் பதிப்பு • அக்டோபர் 2026

Future Secure Providers : Call 9585 905 905, 9363 705 905.
https://futuresecureproviders.com

இந்த நூலைப் பயன்படுத்துவது எப்படி

ஒரு customer உங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து, “எனக்கு எந்த insurance சரியா இருக்கும்?” என்று கேட்கிறார். அவருக்கு புரியுற மாதிரி பதில் சொல்லணும்; அதே நேரத்தில் தவறான வாக்குறுதியும் கொடுக்கக் கூடாது. அதற்கான பயிற்சிதான் இந்தப் புத்தகம். ஒரு அத்தியாயம் படிங்க, அதிலுள்ள கணக்கைப் போட்டுப் பாருங்க, பிறகு customer-கிட்ட பேசுற மாதிரி சொல்லிப் பழகுங்க. இது பயிற்சி நூல் மட்டுமே; அதிகாரப்பூர்வ agent நியமனத்துக்கோ regulatory certificate-க்கோ மாற்று இல்லை.

நூலின் நோக்கம்

Insurance terms எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணுவது மட்டும் நம்ம நோக்கம் இல்லை. ஒரு குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை, policy என்ன தருகிறது, என்ன தராது, claim நேரத்தில் எப்படி உதவலாம் என்பதைத் தெளிவாகப் புரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் விளக்கத்தோடு கணக்கு, customer உரையாடல், பயிற்சி என எல்லாவற்றையும் சேர்த்திருக்கோம்.

Examples-ஐ எப்படி பயன்படுத்துவது

இந்தப் புத்தகத்தில் வரும் customer பெயர்கள், செலவுக் கணக்குகள், சந்திப்புக் காட்சிகள் எல்லாமே பயிற்சிக்கான கற்பனை உதாரணங்கள். அவற்றை உண்மையான premium quote-ஆகவோ உறுதியான claim தொகையாகவோ சொல்லாதீங்க. உண்மையான ஆலோசனைக்கு அந்த customer-ன் policy wording, schedule, CIS, endorsements ஆகியவற்றைப் பார்த்துதான் முடிவு செய்யணும்.

ஆவணங்களின் நிலை

முந்தைய பதிப்புக்காகப் பெறப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள்தான் இந்தப் பதிப்புக்கும் அடிப்படை. அவற்றின் பெறப்பட்ட நாள் 10-10-2026 என்று பழைய ஆய்வுப் பதிவில் உள்ளது. இந்தப் பதிப்பில் மொழிநடை திருத்தப்பட்டுள்ளது; புதிய product அல்லது regulatory ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகக் கருத வேண்டாம். குறிப்பாக 2025–2026 மாற்றங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக உறுதிசெய்யப்படவில்லை என்ற வரம்பு தொடர்கிறது. ஆவணங்களின் பெயர், தேதி, UIN, ஆதார இணைப்புகளை நூலின் கடைசியில் பார்க்கலாம். நடைமுறையில் பயன்படுத்தும் முன் பொருந்தும் தற்போதைய விதியை உறுதி செய்யணும்.

படங்களின் நிலை

குடும்பம், advisor, doctor, hospital காட்சிகள் விளக்கத்துக்காக AI மூலம் உருவாக்கப்பட்டவை. அவை உண்மையான customers-ஐயோ குறிப்பிட்ட hospital-ஐயோ காட்டவில்லை. கணக்குப் படங்களும் கற்றுக்கொள்வதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்டவை. எந்த insurer-ன் அங்கீகாரமாகவும் இந்தப் படங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

பொருளடக்கம்

01 Health Insurance ஏன் தேவை....4

02 எந்த வகை Insurance யாருக்கு....11

03 Customer-க்கு உண்மையில் என்ன தேவை....18

04 Insurance Terms கணக்குடன் புரிஞ்சுக்கலாம்....25

05 Waiting Period எப்போது என்ன Cover கிடைக்கும்....33

06 Medical Underwriting Company என்ன பார்க்கிறது....39

07 நான்கு Star Health Plans எப்படி ஒப்பிடுவது....46

08 ₹5 லட்சமா ₹10 லட்சமா ₹20 லட்சமா....57

09 Super Top-Up கணக்கு எப்படி வேலை செய்கிறது....62

10 Cashless Claim Hospital-ல் என்ன நடக்கும்....67

11 Reimbursement கட்டிய பணத்தை Claim செய்வது....72

12 Claim மறுத்தால் அடுத்து என்ன செய்யலாம்....77

13 IRDAI விதிகள் Customer-க்கு என்ன பாதுகாப்பு....81

14 Renewal Portability பழைய பலன்களைப் பாதுகாப்பது....86

15 Customer-கிட்ட இயல்பாகப் பேசலாம்....91

16 Customer தயங்கினால் எப்படி பேசுவது....98

17 15 Customer கதைகள் நீங்க என்ன செய்வீங்க....102

18 நம்பிக்கையைப் பாதுகாக்கும் Advisor பழக்கங்கள்....109

19 முதல் Enquiry முதல் Renewal வரை....113

20 30 நாளில் படித்து பேசிப் பயிற்சி செய்யலாம்....117

20 அத்தியாயங்கள் • 30 Customer கேள்வி–பதில்கள் • 15 வழக்குகள் • 30 நாள் பயிற்சி

அத்தியாயம் 01

Health Insurance ஏன் தேவை

Health Insurance Fundamentals



மருத்துவச் செலவுக்கான குடும்பப் பாதுகாப்பு. கருத்து விளக்கம்; AI உருவாக்கிய படம்.

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

இந்த அத்தியாயம் முடிந்ததும் மூன்று விஷயங்களை எளிதாகச் சொல்லத் தெரியணும்: Insurance எதற்கு உதவுகிறது? Premium-க்கும் Sum Insured-க்கும் என்ன வித்தியாசம்? Hospital bill-க்கும் கிடைக்கும் claim-க்கும் ஏன் வேறுபாடு வரலாம்? கூடவே, ஒரு policy-யைப் புரிஞ்சுக்க எந்த documents பார்க்கணும் என்பதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம்.

1.1 நம்ம சேமிப்புக்கு என்ன உதவி

சம்பளம் வந்ததும் வீட்டுச் செலவு, பிள்ளைகளின் படிப்பு, EMI, சேமிப்பு என்று பிரித்து வைப்போம் இல்லையா? திடீரென ஒரு பெரிய hospital bill வந்தால் அந்தக் கணக்கு மாறிடும். Policy ஏற்றுக்கொள்ளும் மருத்துவச் செலவுகளை, அதன் வரம்புக்குள் insurance company பகிர்ந்துகொள்ள உதவுவதுதான் Health Insurance. “நோயே வராது” என்றோ “குடும்பத்தின் எல்லாச் செலவையும் company பார்த்துக்கும்” என்றோ இதைச் சொல்ல முடியாது.

இங்கே ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன treatment தேவை என்பதை doctor முடிவு செய்வார். அந்த treatment-க்கு policy-ல் எவ்வளவு claim கிடைக்கும் என்பதை insurer documents பார்த்து முடிவு செய்வார். Doctor சொன்ன treatment என்பதால் bill முழுவதும் வந்துவிடும் என்று நினைக்காதீங்க. Claim கிடைக்குமா

என்ற காரணத்துக்காக doctor-ன் treatment advice-ஐ மாற்றுவதும் advisor வேலை இல்லை.

“Insurance இருக்கு; emergency savings வேண்டாமா?” என்றால், வேண்டும். Co-pay, deductible, cover ஆகாத செலவுகள், போக்குவரத்து, வேலைக்குப் போக முடியாத நாட்களின் வருமானக் குறைவு என நம்ம கையிலிருந்து செலவு வரலாம். அதனால்தான் insurance-உம் உடனே பயன்படுத்தக்கூடிய சேமிப்பும் சேர்ந்து இருந்தால் குடும்பத்துக்கு உதவியாக இருக்கும்.

சிம்பிளாகச் சொன்னால்

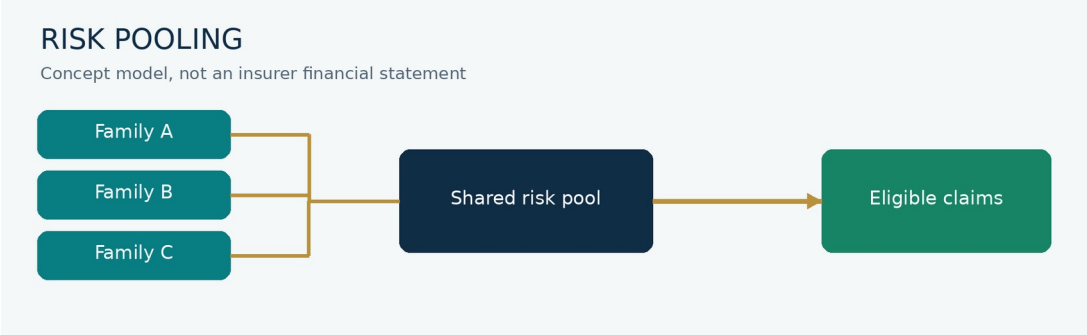
Customer-கிட்ட ஆரம்பத்திலேயே எல்லா terms-ஐயும் சொல்ல வேண்டாம். “Hospital-ல் சிகிச்சை எடுக்கும்போது, உங்க policy ஏற்றுக்கொள்ளும் செலவுகளுக்கு company உதவும். எந்தச் செலவு, எவ்வளவு வரை, எப்போதிலிருந்து cover ஆகும்னு நாம முன்னாடியே பார்த்துக்கலாம்” என்று ஆரம்பிக்கலாம். முதலில் நோக்கம் புரியட்டும்; அடுத்ததாக details பேசலாம்.

1.2 பலர் செலுத்தும் Premium எப்படி உதவுகிறது

எல்லாருக்கும் ஒரே வருடத்தில் பெரிய medical expense வருவதில்லை. சிலருக்கு claim தேவைப்படாது; சிலருக்கு அதிக செலவு வரலாம். பலர் செலுத்தும் premium மூலம் இந்த risk-ஐப் பகிர்ந்துகொள்வதுதான் Risk Pooling. Premium எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பதில் எதிர்பார்க்கும் claims, நிர்வாகச் செலவு, risk assessment, பொருந்தும் விதிகள் என பல விஷயங்கள் இருக்கு.

ஒரு கற்பனைக் கணக்கு பார்க்கலாம். 1,000 குடும்பங்கள் தலா ₹10,000 செலுத்தினால் ₹1 கோடி சேரும். பலருடைய பங்களிப்பு எப்படி ஒன்றாகிறது என்பதைப் புரிஞ்சுக்க மட்டும்தான் இந்த உதாரணம். இது actual premium quote-ம் இல்லை; company-ன் உண்மையான வரவு–செலவுக் கணக்கும் இல்லை. இந்தப் பணம் முழுவதுமே claims-க்குச் செலவாகும் என்றும் சொல்லக் கூடாது.

“இந்த வருஷம் claim பண்ணலையே; premium வீணா?” என்று customer கேட்கலாம். அந்த வருடம் policy நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட பாதுகாப்பு இருந்தது என்பதுதான் பதில். வழக்கமான medical indemnity policy ஒரு savings account இல்லை. Claim செய்யவில்லை என்பதற்காக premium முழுவதும் திரும்ப வராது. Bonus அல்லது renewal discount இருந்தால், அது எப்போது கிடைக்கும் என்று தனியாகப் பார்க்கணும்.



படம் 1.1 • பலரின் அபாயத்தைப் பகிரும் கருத்து மாதிரி.

1.3 அடிப்படை விதிகளை ஒரு முறை புரிஞ்சுக்கலாம்

Medical details-ஐ மறைக்காமல் சொல்வது: Proposal form-ல் கேட்கும் உடல்நிலை, மருந்து, பழைய treatment விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்யணும். “இது சின்ன விஷயம்தானே” என்று நாமே விட்டுவிட வேண்டாம். கேள்வி என்ன கேட்கிறது என்று முழுவதும் படிங்க. சந்தேகம் இருந்தால் எழுத்தில் clarification வாங்குங்க.

Indemnity என்றால் என்ன? Policy ஏற்றுக்கொள்ளும் உண்மையான செலவுக்கு, அதன் limit-க்குள் பணம் கிடைக்கும் முறை. ₹10 லட்சம் Sum Insured இருப்பதால் ஒவ்வொரு admission-க்கும் ₹10 லட்சம் கிடைக்காது. ஏற்கப்படும் செலவு ₹80,000 என்றால், அந்த claim-க்கு அதைவிட அதிகமாக வாங்கும் உரிமை வராது.

Benefit policy கொஞ்சம் வேறு. Policy குறிப்பிடும் நிகழ்வு அல்லது நோயின் வரையறை பூர்த்தியானால், முன்பே நிர்ணயித்த தொகை கிடைக்கலாம். Critical Illness-ல் நோயின் பெயர் மட்டும் போதுமா, குறிப்பிட்ட தீவிரம் வேண்டுமா, survival period இருக்கிறதா என்று பார்க்கணும். இதையும் hospital bill அடிப்படையிலான indemnity claim-ஐயும் ஒன்றாகக் குழப்பாதீங்க.

Hospital-ல் admit ஆனது மட்டும் claim-க்கு போதாது. Policy-ல் அவருடைய பெயர் இருக்கிறதா? Policy நடைமுறையில் இருந்த நாளில்தான் treatment நடந்ததா? Treatment cover ஆகிறதா? Waiting Period முடிந்ததா? இவற்றையும் பார்க்கணும். Cover ஆகாத செலவை bill-ல் சேர்த்துவிட்டால் அது தானாக cover ஆகிவிடாது.

இரண்டு indemnity policies இருந்தாலும் ஒரே செலவுக்கு இருமுறை முழுப் பணம் வாங்க முடியாது. அவற்றின் விதிப்படி claims-ஐ ஒருங்கிணைக்கலாம். Fixed benefit policy-ன் விதம் வேறாக இருக்கலாம்; அதைத் தனியாக விளக்கணும். [R01, அத்தியாயம் I, பத்தி 18]

1.4 எந்த Document எதற்கு

Brochure பார்த்தாலே policy முழுவதும் தெரிந்துவிடுமா? இல்லை. Brochure ஒரு அறிமுகம். Policy wording-ல்தான் விரிவான benefits, definitions, exclusions, conditions இருக்கும். Schedule-ல் அந்த customer யார், எவ்வளவு cover எடுத்திருக்கிறார், எந்த

option தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார், எந்தத் தேதிவரை policy இருக்கிறது என்பவை இருக்கும். பிறகு மாற்றம் செய்திருந்தால் endorsement-ஐயும் சேர்த்துப் படிக்கணும்.

ஆவணம்	ஆலோசகர் பார்க்க வேண்டியது	தவிர்க்க வேண்டிய முடிவு
Proposal form	மருத்துவ பதில்கள், குடும்ப விவரங்கள், declaration	வாயில் சொன்னது எல்லாம் பதிவாகிவிட்டது
Policy schedule	பெயர், வயது, SI, தேதிகள், தேர்ந்தெடுத்த விருப்பங்கள்	brochure-ல் உள்ள எல்லா விருப்பங்களும் வாங்கப்பட்டுள்ளன
Policy விதிகள்	Definitions, பலன்கள், வரம்புகள், exclusions	தலைப்பைப் பார்த்தாலே முழு பாதுகாப்பு புரியும்
Customer தகவல் Sheet	முக்கிய நிபந்தனைகளின் சுருக்கம்	சுருக்கம் மட்டும் படித்தால் போதும்
Endorsement	கூடுதல் உறுப்பினர் அல்லது மாற்றப்பட்ட நிபந்தனை	முதல் PDF மட்டுமே இறுதி ஒப்பந்தம்
Premium receipt	தொகை மற்றும் பணம் பெற்றதற்கான பதிவு	receipt இருந்தால் எந்தத் தேதியிலும் risk தொடங்கிவிட்டது

Product name-உடன் UIN-ஐயும் குறித்துக்கொள்ளுங்க. அதே பெயரில் புதிய version இருக்கலாம். பழைய customer-ன் renewal policy-க்கும் இன்று புதிதாக வாங்கும் policy-க்கும் ஒரே நிபந்தனைதான் என்று நினைக்காதீங்க. Document date, effective date, schedule version ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பாருங்க.

1.5 Premium மற்றும் Sum Insured

Premium என்பது insurance-க்காக நாம செலுத்தும் கட்டணம். Sum Insured என்பது policy-ல் தேர்ந்தெடுத்த cover தொகை. இரண்டும் வேறு. வருட premium-ஐ 12-ஆல் வகுத்து “மாதம் சராசரியாக இவ்வளவு” என்று விளக்கலாம். ஆனால் அது company தரும் actual monthly instalment quote என்று சொல்லக் கூடாது.

Sum Insured-ஐப் பார்க்கும்போது முதலில் “இது ஒருத்தருக்கா, குடும்பம் மொத்தமாகப் பகிர்ந்துகொள்ளவா?” என்று பாருங்க. அடுத்து வருட limit, ஒரு claim-க்கான limit, sub-limit, bonus, restoration எல்லாத்தையும் தனித்தனியாகப்

புரிஞ்சுக்கணும். “₹10 லட்சம் + restoration” என்று இருந்தால், நிபந்தனையே இல்லாமல் ₹20 லட்சம் கையில் இருப்பதுபோலச் சொல்ல முடியாது.

ஒரு கணக்குப் பார்க்கலாம்

ஒரு கற்பனை policy-ல் வருடத்துக்கு ₹5 லட்சம் SI இருக்கிறது. முதல் hospital bill ₹2,40,000. அதில் ₹20,000 cover ஆகவில்லை; வேறு deduction இல்லை என்று வைத்துக்கலாம். அப்படியானால் claim ₹2,20,000. அதை company கொடுத்த பிறகு base SI-ல் ₹2,80,000 மீதி இருக்கும். இந்தக் கணக்கில் bonus அல்லது restoration சேர்க்கவில்லை.

கணக்கின் படி	தொகை
Hospital-ன் மொத்த Bill	₹2,40,000
உதாரணத்தில் ஏற்கப்படாத பகுதி	₹20,000
அனுமதிக்கப்பட்ட Claim	₹2,20,000
ஆரம்ப அடிப்படை SI	₹5,00,000
எளிய மாதிரியில் மீதமுள்ள SI	₹2,80,000

Hospital bill எவ்வளவு என்பதும் payable claim எவ்வளவு என்பதும் வேறு. Bill தொகையை மட்டும் கேட்டுவிட்டு “முழுசா கிடைக்கும்” என்று சொல்லாதீங்க. Settlement letter வந்ததும் எந்தச் செலவு ஏன் குறைக்கப்பட்டது, எந்த clause பொருந்துகிறது என்பதைப் பார்த்து விளக்குங்க. அப்போதுதான் customer-க்கு கணக்கு புரியும்.

1.6 Coverage மற்றும் Exclusion இடையிலான வேறுபாடு

ஒரு treatment cover ஆகிறது என்று policy-ல் இருந்தாலும், அதற்கான conditions-ஐப் பார்க்கணும். உதாரணமாக, admission-க்கு முன்னால் வாங்கிய எல்லா மருந்துகளும் pre-hospitalisation cover-ல் வந்துவிடாது. அதே நோயுடன் தொடர்பு, தகுதியான admission, அனுமதிக்கும் நாட்கள் போன்ற விதிகள் இருக்கலாம். Day care treatment-உம் சாதாரண OPD consultation-உம் ஒன்றல்ல.

Exclusion என்றால் policy ஏற்காத செலவு அல்லது சூழல். Waiting Period என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட cover கிடைக்கக் காத்திருக்க வேண்டிய காலம். இரண்டையும் “இப்போ கிடைக்காது” என்று ஒன்றாகச் சொல்லாதீங்க. காலம் போனதால் permanent exclusion தானாக நீங்காது. Waiting Period முடிந்தாலும் மற்ற policy conditions தொடர்ந்து பொருந்தும்.

ஒரு benefit சொன்ன உடனே அதன் முக்கிய limit-ஐயும் சொல்லுங்க. “PDF அனுப்பிட்டேனே” என்பதாலேயே customer புரிந்துகொண்டார் என்று ஆகாது. “நாம பேசினதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க?” என்று அவரையே சொல்லச் சொல்லுங்க. எங்கே குழப்பம் இருக்கிறது என்று உடனே தெரியும்.

1.7 Customer-கிட்ட இப்படிப் பேசலாம்

Customer: “₹10 லட்சம் Policy எடுத்தால் Hospital Bill எல்லாமே கிடைக்குமா?”

Advisor: “₹10 லட்சம் cover இருக்கு சார். ஆனா bill-ல் எந்தச் செலவு cover ஆகுது, room limit அல்லது co-pay இருக்கா, Waiting Period முடிஞ்சதா என்பதைப் பார்த்துதான் payable amount தெரியும். ஒரு sample bill வைத்து விளக்குறேன்.”

Customer: “அப்படியென்றால் insurance எடுத்தும் என் கையிலிருந்து செலவாகுமா?”

Advisor: “சில நேரங்களில் உங்க கையிலிருந்தும் செலவு வரும். அதனால்தான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே உங்க பங்கு எவ்வளவு இருக்கலாம்னு பேசணும். Premium குறைவா இருக்கிறதோடு, இந்த conditions-ஐயும் சேர்த்துப் பார்ப்போம்.”

Customer: “Claim செய்யாவிட்டால் அடுத்த வருடம் வேண்டாமே?”

Advisor: “இந்த வருஷம் claim இல்லைன்னா medical expense வரலைன்னு அர்த்தம். அடுத்த வருஷத்துக்கான தேவையைத் தனியாகப் பார்க்கணும். Renewal நிறுத்தினால் continuity-க்கும் அடுத்த cover-க்கும் என்ன ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு முடிவு பண்ணலாம்.”

1.8 இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

“எல்லா நோயும் cover”, “Cashless என்றால் ஒரு ரூபாய்கூட வேண்டாம்”, “ஒருமுறை கட்டினால் lifetime free” என்று சொல்லாதீங்க. Policy என்ன சொல்கிறது என்பதையே சொல்லணும். நினைவில் இருக்கும் product details மட்டும் வைத்து உறுதி தர வேண்டாம். Medical disclosure, policy தொடங்கும் நாள், premium payment, insurer acceptance எல்லாவற்றையும் சரிபார்க்கணும்.

சின்ன எழுத்தில் இருக்கும் condition தெரியவில்லையா? Zoom செய்து காட்டி விளக்குங்க. காலியான proposal-ல் கையெழுத்து வாங்காதீங்க. Customer பதில்களைப் பார்த்து ஒப்புக்கொண்ட பிறகுதான் submit செய்யணும். பிறகு ஏதாவது மாற்றினால் அவரிடம் சொல்லி, திருத்திய document-ஐ மீண்டும் பகிருங்க.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

இந்த அத்தியாயத்தில் நினைவில் வைக்க வேண்டியது இதுதான்: Premium, Sum Insured, Claim மூன்றும் வேறு. Insurance என்ன தருகிறது என்பதோடு, எவ்வளவு வரை தருகிறது, எப்போதிலிருந்து தருகிறது, customer எவ்வளவு செலுத்த

வேண்டியிருக்கும் என்பதையும் விளக்கணும். Brochure மட்டும் போதாது; wording, schedule, CIS, endorsements எல்லாம் சேர்த்துதான் முழுப் படம் தெரியும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. Claim இல்லாத ஆண்டில் premium வீணாகிவிட்டது என்ற வாதத்திற்கு மூன்று வாக்கியங்களில் பதில் எழுதுங்க.

2. ₹3,00,000 Bill-ல் ₹25,000 Cover ஆகாத செலவு உள்ளது. மற்ற deduction இல்லை என்றால் Admissible amount என்ன?

3. ஒரு brochure-ல் optional பாதுகாப்பு உள்ளது. Customer schedule-ல் அது இல்லை. அந்தப் பலனை உறுதி செய்ய முடியுமா? ஏன்?

4. Waiting Period மற்றும் permanent exclusion வேறுபாட்டை ஒரு குடும்ப உதாரணத்துடன் விளக்குங்க.

5. “எல்லாம் காப்பீட்டில் இடம்பெற்ற” என்று சொன்ன பழைய WhatsApp செய்தியை எப்படி திருத்துவீர்கள்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்

இரண்டாவது கேள்வியின் விடை ₹2,75,000. மூன்றாவது கேள்வியில் brochure-ல் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது மட்டும் போதாது; வாங்கிய பாதுகாப்பு மற்றும் schedule உறுதி தேவை. ஐந்தாவது கேள்வியில் முந்தைய தவறைத் தெளிவாகத் திருத்தி, சரியான நிபந்தனைகளை எழுத்தில் தெரிவித்து, Customer புரிந்துகொண்டதைக் கேட்கணும். தவறான வாக்குறுதியை மறைப்பது திருத்தமல்ல.

Advisor Checklist

• Customer-ன் பாதுகாப்புத் தேவையை முதலில் கேட்டுள்ளேனா?

• SI தனிநபருக்கா அல்லது குடும்பத்திற்கா என்று விளக்கியுள்ளேனா?

• பலன் மற்றும் limitation இரண்டையும் ஒரே சந்திப்பில் பேசியுள்ளேனா?

• சரியான UIN, wording மற்றும் schedule ஆகியவற்றைப் பார்த்துள்ளேனா?

• Premium receipt மற்றும் Policy commencement வேறுபாட்டைச் சரிபார்த்துள்ளேனா?

• Customer புரிதலை அவரது சொற்களில் கேட்டுள்ளேனா?

• அடுத்த செயலும் பொறுப்பாளரும் தேதியும் பதிவாகியுள்ளதா?

ஆதாரம்: R01 அத்தியாயம் I பத்திகள் 4, 17, 18; P01 முதல் P04 வரை உள்ள Definitions மற்றும் பொதுவான நிபந்தனைகள். இந்த அத்தியாயத்தின் கணக்கு examples ஆசிரியர் உருவாக்கிய கற்பனைக் கணக்குகள்.

அத்தியாயம் 02

எந்த வகை Insurance யாருக்கு

Types of Health Insurance

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Individual, Family Floater, Senior Citizen, Top-Up, Super Top-Up, Group, Critical Illness என பல வகைகள் இருக்கு. பெயர்களை மனப்பாடம் செய்வதற்கு பதிலாக, ஒவ்வொன்றிலும் claim எப்படி வேலை செய்கிறது என்று புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு குடும்பத்துக்கு shared cover சரியா, தனித்தனி cover தேவையா என்று முடிவு செய்ய உதவும் கேள்விகளையும் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம்.

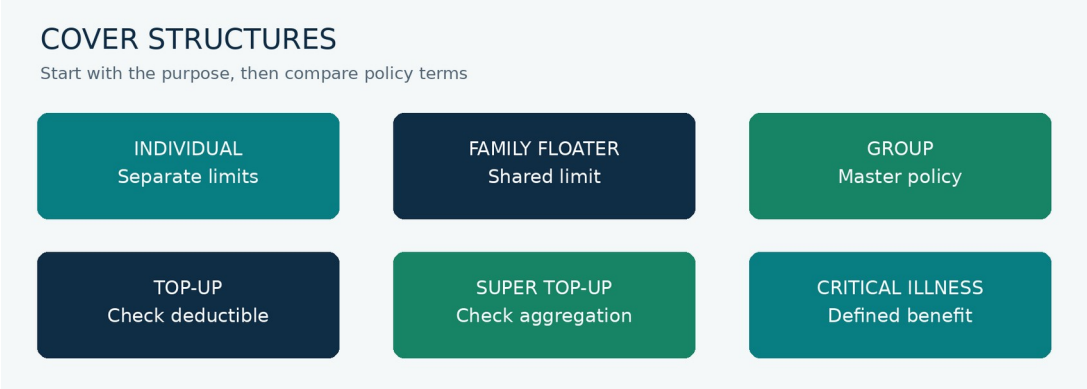
2.1 வகையைத் தேர்வு செய்வதற்கு முன் கேட்கும் கேள்வி

Customer “எந்த company நல்லது?” என்று கேட்கலாம். அதற்கு முன் “உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பாதுகாப்பு தேவை?” என்று புரிஞ்சுக்கணும். Hospital bill-க்கு உதவி வேண்டுமா? பெரிய நோயால் வேலை செய்ய முடியாத காலத்துக்கான பணம் வேண்டுமா? Office insurance-க்கு மேலே கூடுதல் cover வேண்டுமா? தேவை மாறும்போது insurance வகையும் மாறும்.

ஒரே குடும்பத்துக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட cover உதவலாம். Base medical policy hospital செலவுக்கு, Super Top-Up பெரிய செலவுக்கு, பொருந்தும் Critical Illness benefit வருமான இடைவெளிக்கு உதவலாம். ஆனால் எல்லாரும் எல்லாவற்றையும் வாங்கணும் என்று அர்த்தம் இல்லை. தேவையும் தொடர்ந்து premium கட்டும் வசதியும் பார்த்துதான் தேர்வு செய்யணும்.

சிம்பிளாகச் சொன்னால்

“ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி cover வேண்டுமா? குடும்பம் சேர்ந்து பயன்படுத்தும் cover வேண்டுமா? ஒரு அளவுக்கு மேல் வரும் பெரிய செலவுக்கு மட்டும் கூடுதல் cover வேண்டுமா?” என்று கேளுங்க. இந்த மூன்று கேள்விகளே பலருக்கு அடிப்படை வித்தியாசத்தைப் புரியவைக்கும். அதற்குப் பிறகு product names பேசலாம்.



படம் 2.1 • காப்பீட்டு அமைப்புகளின் வேறுபாடு.

2.2 Individual Policy

Individual policy-ல் ஒவ்வொருவருக்கும் தனி Sum Insured இருக்கும். ஒரே document-ல் இரண்டு பேர் பெயர் இருந்தாலும், இருவருடைய limits தனித்தனியாக இருக்கலாம். அதனால “ஒரே policy” என்பதும் “ஒரே தொகையைப் பகிர்வது” என்பதும் ஒன்றல்ல.

அருணுக்கும் மீனாவுக்கும் தலா ₹5 லட்சம் Individual cover இருக்கிறது என்று வைத்துக்கலாம். அருணுக்கு ₹4 லட்சம் admissible claim வந்தால், அவருக்கு ₹1 லட்சம் மீதி. மீனாவின் ₹5 லட்சம் அப்படியே இருக்கும். பிறகு அருணுக்கு ₹2 லட்சம் செலவு வந்தால் மீனாவின் பயன்படுத்தாத cover-ஐ தானாக எடுத்துப் பயன்படுத்த முடியாது. Restoration இருந்தால் அதற்கான விதியைப் பார்க்கணும். இது எளிமைப்படுத்திய கற்பனைக் கணக்கு.

ஒவ்வொருவருக்கும் தனி limit வேண்டும் என்றால் இந்த அமைப்பைப் பரிசீலிக்கலாம். “Individual எப்போதும் அதிக premium; Floater எப்போதும் cheap” என்று முடிவு செய்யாதீங்க. வயது, உறுப்பினர்கள், plan, options எல்லாம் வைத்து actual quote பார்த்துதான் ஒப்பிடணும்.

2.3 Family Floater

Family Floater-ல் schedule-ல் உள்ளவர்கள் ஒரே Sum Insured-ஐப் பகிர்ந்துகொள்கிறார்கள். நால்வருக்கு ₹10 லட்சம் Floater என்றால், ஆளுக்கு ₹10 லட்சம் என்று அர்த்தம் இல்லை. அந்த வருடத்தில் குடும்பத்தின் மொத்த செலவையும் மனதில் வைத்து cover தேர்வு செய்யணும்.

₹10 லட்சம் Floater-ல் முதல் claim ₹3 லட்சம், அடுத்த claim ₹4 லட்சம் என்று வைத்துக்கலாம். Bonus, restoration, வேறு deductions இல்லாத இந்த உதாரணத்தில் ₹7 லட்சம் பயன்படுத்தியதால் ₹3 லட்சம் மீதி. ஒருத்தர் அதிகம் பயன்படுத்தினால் மற்றவர்களுக்கும் மீதி இருக்கும் தொகைதான் கிடைக்கும். அதனால ஒரே வருடத்தில் இரண்டு admissions வந்தால் என்ன ஆகும் என்று விளக்கிப் பாருங்க.

கற்பனை குடும்ப அமைப்பு	முதல் **Claim**	அடுத்த **Claim**	எளிய மாதிரியில் மீதம்
₹10 லட்சம் shared floater	₹3 லட்சம்	₹4 லட்சம்	₹3 லட்சம்
தலா ₹5 லட்சம் individual	அருண் ₹3 லட்சம்	மீனா ₹4 லட்சம்	அருண் ₹2 லட்சம்; மீனா ₹1 லட்சம்

Floater-ல் யாரையெல்லாம் சேர்க்கலாம், குழந்தை வயது எவ்வளவு வரை, அதிகபட்சம் எத்தனை பேர், dependent என்றால் யார் என்பதெல்லாம் plan-க்கு plan மாறும். பெற்றோரை எப்போதும் தனியாகவே வைக்கணும் என்று பொதுவாக முடிவு செய்ய வேண்டாம். அவர்களின் வயது, உடல்நிலை, shared cover-ன் தேவை, budget ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பாருங்க.

2.4 Senior Citizen பாதுகாப்பு

Senior Citizen plan என்ற பெயரைப் பார்த்ததும் “பழைய நோய்கள் எல்லாம் உடனே cover” என்று நினைக்காதீங்க. Entry age, co-pay, room category, disease sub-limits, medical tests ஆகியவற்றைப் பார்க்கணும். வயதானவர் என்பதால் வழக்கமான health plan-க்கு apply செய்யவே முடியாது என்றும் சொல்லாதீங்க. Eligibility-யும் underwriting முடிவும் முக்கியம்.

67 வயது குமாருக்கு 20% co-pay உள்ள ஒரு கற்பனை plan பார்க்கிறோம். Admissible claim ₹3 லட்சம் என்றால், co-pay மட்டும் ₹60,000 வரும். அந்தப் பணத்தை குடும்பம் சமாளிக்க முடியுமா? Premium பேசும்போதே இதையும் கேட்கணும். “Premium குறைவு” என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு customer செலுத்தும் பங்கை மறைக்கக் கூடாது.

மகன் premium கட்டுகிறார் என்பதால் அப்பா அல்லது அம்மாவின் medical history முழுவதும் அவருக்குத் தெரியும் என்று நினைக்க வேண்டாம். பெற்றோரிடம் கேட்டோ, அவர்களின் சம்மதத்துடன் medical documents பார்த்தோதான் பதிவு செய்யணும். படித்துப் புரிந்துகொள்ளவும் online steps செய்யவும் உதவி தேவையா என்பதையும் கவனிங்க.

2.5 Top-Up மற்றும் Super Top-Up

Top-Up, Super Top-Up இரண்டிலும் முக்கியமான சொல் Deductible. பொதுவாக Top-Up ஒவ்வொரு claim-ஐத் தனியாகப் பார்க்கும் அமைப்பாக இருக்கலாம். Super Top-Up ஒரு policy year-ல் சேரும் eligible செலவுகளை மொத்தமாகப் பார்க்கலாம். ஆனால் பெயரை மட்டும் நம்பாதீங்க; அந்த wording-ல் deductible எப்படி வேலை செய்கிறது என்று உறுதி செய்யணும்.

Deductible ₹5 லட்சம். ஒரே policy year-ல் admissible claims ₹3 லட்சம், ₹4 லட்சம் என்று வைத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு claim-க்கும் தனி ₹5 லட்சம் threshold என்றால், இரண்டுமே அதற்குக் கீழே இருப்பதால் Top-Up payment இல்லாமல் போகலாம். Aggregate முறையில் மொத்தம் ₹7 லட்சம்; threshold-க்கு மேலான ₹2 லட்சம் Super Top-Up-ல் பரிசீலிக்கப்படலாம். இது விளக்கத்துக்கான கணக்கு; exclusions, மீதமுள்ள limit, aggregation rules தொடர்ந்து பொருந்தும்.

Base cover-உம் deductible-உம் ஒரே தொகையாக இருந்தால் எல்லா gap-மும் முடிந்துவிடுமா? இல்லை. Base policy co-pay அல்லது room restriction காரணமாக நம்ம செலவு அதிகமாகலாம். Super Top-Up ஏற்றுக்கொள்ளும் expense-உம் base insurer கொடுத்த amount-உம் ஒன்றாகவே இருக்க வேண்டியதில்லை. இரண்டு policies-ஐயும் தனித்தனியாகப் படிக்கணும். அத்தியாயம் 09-ல் இதை இன்னும் கணக்குடன் பார்க்கலாம்.

2.6 Group Health Insurance

Office வழியாக insurance இருந்தால் HR அனுப்பும் ஒரு message மட்டும் போதாது. Master policy, member certificate வாங்கிப் பாருங்க. யார் cover ஆகிறார்கள், maternity rules என்ன, எந்த room எடுக்கலாம், claim எப்படி செய்யணும், வேலைவிட்டால் cover எப்போது முடியும் என்பதெல்லாம் தெரிந்திருக்கணும்.

சில Group policies-ல் சில Waiting Periods விலக்கப்பட்டிருக்கலாம். எல்லா Group policies-லும் அப்படித்தான் என்று சொல்லக் கூடாது. அடுத்த renewal-ல் employer insurer-ஐயோ conditions-ஐயோ மாற்றலாம். வேலைவிடும்போது migration வாய்ப்பு இருக்கிறதா, யாருக்கு கிடைக்கும், எப்படி apply செய்யணும் என்பதை முன்பே கேட்டுத் தெரிஞ்சுக்குங்க.

வித்யாவுக்கு office மூலம் ₹5 லட்சம் cover; கணவரும் குழந்தையும் உள்ளனர். ஆறு மாதத்தில் வேலை மாற நினைக்கிறார். “ஏற்கெனவே insurance இருக்கே” என்று அங்கேயே பேச்சை முடிக்க வேண்டாம். பழைய வேலை முடியும் நாள், புதிய cover தொடங்கும் நாள், நடுவில் gap வருமா என்பதைக் கேளுங்க. தனிப்பட்ட policy பார்க்கும்போது அதற்கு புதிய Waiting Period இருக்கலாம் என்பதையும் சொல்லணும்.

2.7 Critical Illness பலன்

Critical Illness plan-ல் குறிப்பிட்ட கடுமையான நோய் அல்லது நிகழ்வுக்கு முன்பே நிர்ணயித்த benefit கிடைக்கலாம். ஆனால் நோயின் நிலை, தீவிரம், diagnosis முறை, survival period, exclusions எல்லாம் plan-க்கு plan மாறும். Doctor ஒரு நோயின் பெயர் சொன்னதும் policy definition பூர்த்தியாகிவிட்டது என்று எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது.

ஒரு கற்பனை plan-ல் தகுதியான நிகழ்வுக்கு ₹10 லட்சம் fixed benefit என்று வைத்துக்கலாம். Hospital bill ₹4 லட்சம் என்பதால் benefit-மும் ₹4 லட்சம்தான் என்று

சொல்ல முடியாது; இது indemnity முறை இல்லை. அதே நேரத்தில் “இந்த நோய் வந்தாலே ₹10 லட்சம் உறுதி” என்றும் சொல்ல முடியாது. Policy definition-உம் conditions-உம் பூர்த்தியாகணும்.

Critical Illness cover-ஐ சாதாரண hospital insurance-க்கு முழு மாற்றாகச் சொல்லாதீங்க. அதில் பட்டியலிடாத நோய்களுக்கும் hospital admission வரலாம். வருமான இடைவெளி, EMI, வீட்டுச் செலவு போன்ற தேவைகளைப் பார்த்து, பொருத்தமான இடத்தில் கூடுதல் cover-ஆகப் பேசலாம்.

2.8 ஒரே பார்வையில் ஒப்பீடு

வகை	முதன்மை அமைப்பு	**Customer**-கிட்ட கேட்க வேண்டியது
Individual	ஒவ்வொருவருக்கும் தனி SI	தனி வரம்பு எவ்வளவு தேவை?
Family Floater	குடும்பம் பகிரும் SI	ஒரே ஆண்டில் பல Claims வந்தால் போதுமா?
Senior Citizen	வயதுக்கேற்ற திட்டம் நிபந்தனைகள்	co-pay மற்றும் sub-வரம்பை ஏற்க முடியுமா?
Top-Up	wording-ல் வரையறுக்கப்பட்ட deductible	ஒவ்வொரு Claim threshold எப்படி இயங்குகிறது?
Super Top-Up	aggregate deductible இருக்கலாம்	Policy ஆண்டு மற்றும் aggregation எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது?
Group	master Policy வழி பாதுகாப்பு	உறுப்பினர் நிலை மாறினால் என்ன நடக்கும்?
Critical Illness	வரையறுக்கப்பட்ட நிகழ்வுக்கு பலன்	நோய் வரையறை மற்றும் survival நிபந்தனை என்ன?

2.9 Customer-கிட்ட இப்படிப் பேசலாம்

Customer: “என் company-ல் ₹5 லட்சம் இருக்கு. இன்னொரு insurance எடுத்தால் இரண்டிலும் ₹5 லட்சம் வாங்கலாமா?”

Advisor: “ரெண்டும் hospital செலவுக்கான indemnity policies என்றால் ஒரே செலவுக்கு இரண்டு முறை full amount வாங்க முடியாது. ஒரு policy limit போதாவிட்டால், அடுத்த policy விதிப்படி மீதமுள்ள eligible expense-க்கு coordination செய்யலாம். முதலில் இரண்டு schedules-உம் பார்ப்போம்.”

Customer: “Floater என்றால் என் மனைவிக்கும் எனக்கும் தனித்தனியா?”

Advisor: “Floater-ல் ஒரே amount-ஐ family share பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் அதிகம் use செய்தால் மற்றவர்களுக்கு மீதி என்ன, restoration எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்க்கணும். தனித்தனி limit வேணும்னா Individual option-உம் compare செய்யலாம்.”

Customer: “Super top-up மட்டும் வாங்கினால் போதாதா?”

Advisor: “Deductible வரை eligible expense-ஐ யார் சமாளிப்பாங்க என்று முதலில் பார்க்கணும். Base policy அல்லது savings உதவலாம். Threshold-க்குக் கீழே Super Top-Up என்ன செய்யும்னு wording பார்த்து விளக்குறேன்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

Amounts சேர்த்து “மொத்தம் ₹25 லட்சம்” என்று மட்டும் சொன்னால் ஒவ்வொரு cover-ன் conditions தெரியாமல் போகலாம். Office cover நிரந்தர தனி cover இல்லை. Group waiting waiver புதிய Individual policy-க்கும் தானாக வராது. Parents வயது சொல்லாமல் quote வாங்காதீங்க. Policy years மாறினால் aggregate claims கணக்கும் மாறலாம்.

Comparison-ல் “ஏன் இந்த அமைப்பு பொருந்தும்?” என்று ஒரு paragraph எழுதுங்க. “எல்லாருக்கும் இதுதான் கொடுக்கிறோம்” என்பது காரணம் இல்லை. Premium குறைவாக இருந்தாலும் deductible-ஐ customer சமாளிக்க முடியாவிட்டால் அது அவருக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

ஒவ்வொரு insurance வகையும் பயன்பாட்டிலும் claim calculation-லும் வேறுபடும். Individual-க்கும் Floater-க்கும் SI தனியா, shared-ஆ என்பதே முக்கியம். Top-Up-ல் deductible method, Group-ல் membership status, Critical Illness-ல் defined event முக்கியம். Family need-உம் policy structure-உம் சேர்ந்துதான் plan தேர்வு செய்யணும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. தலா ₹5 லட்சம் individual பாதுகாப்பு மற்றும் ₹10 லட்சம் floater இரண்டும் எப்போதும் சமமா? இரண்டு Claims உதாரணம் உருவாக்குங்க.

2. ₹5 லட்சம் aggregate deductible-க்கு எதிராக ₹2 லட்சம், ₹2 லட்சம், ₹3 லட்சம் தகுதியான Claims வந்தால் threshold-க்கு மேலான தொகை என்ன?

3. Employer பாதுகாப்பு உள்ளவரிடம் கேட்க வேண்டிய ஐந்து கேள்விகளை எழுதுங்க.

4. Senior citizen திட்டத்தில் premium-க்கு அடுத்ததாக எந்த மூன்று நிபந்தனைகளை விளக்குவீங்க?

5. Critical illness பலன் ஏன் எல்லா hospitalization-க்கும் மாற்றாகாது?

பதில் சரியா பார்ப்போம்

இரண்டாவது கேள்வியின் எளிய மாதிரி விடை ₹2 லட்சம்; aggregate ₹7 லட்சம், threshold ₹5 லட்சம். முதல் கேள்வியில் ஒருவருக்கு ₹7 லட்சம் செலவு ஏற்பட்டால் தனி ₹5 லட்சம் வரம்பு மற்றும் பகிரும் ₹10 லட்சம் வரம்பு வேறுபடுகின்றன; மற்ற உறுப்பினரின் செலவையும் சேர்த்து பாருங்க. உண்மையான Policy-ல் restoration மற்றும் பிற வரம்புகள் முடிவை மாற்றலாம்.

Advisor Checklist

• Claim indemnity-ஆ அல்லது fixed பலனா என்று பிரித்துள்ளேனா?

• SI தனியா, shared-ஆ என்று schedule-ல் பார்த்துள்ளேனா?

• தகுதியான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் வயது விதிகளை உறுதி செய்துள்ளேனா?

• Deductible per Claim-யா அல்லது aggregate-ஆ என்று பதிவு செய்துள்ளேனா?

• Group பாதுகாப்பு முடிவடையும் சூழல்களைப் பேசியுள்ளேனா?

• Co-pay மற்றும் deductible செலவிற்கான குடும்ப நிதியைப் புரிந்துகொண்டேனா?

• பரிந்துரைக்கான காரணத்தையும் ஏற்காத மாற்று விருப்பத்தின் காரணத்தையும் எழுதியுள்ளேனா?

ஆதாரம்: R01 அத்தியாயம் I பத்திகள் 11, 12, 18; தனிப்பட்ட வகைகளுக்கான இறுதி முடிவிற்கு சம்பந்தப்பட்ட Policy விதிகள் அவசியம். இந்த அத்தியாயத்தில் திட்டத்திற்குரிய premium அல்லது உறுதியான Claim வாக்குறுதி தரப்படவில்லை.

அத்தியாயம் 03

Customer-க்கு உண்மையில் என்ன தேவை

Customer Needs Analysis



ஆலோசனை முதலில் தேவையைப் புரிந்துகொள்வதில் தொடங்குகிறது. AI உருவாக்கிய காட்சி.

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Plan சொல்வதற்கு முன் குடும்பத்தைப் புரிஞ்சுக்கணும். யாருக்கு cover, வயது என்ன, regular medicine இருக்கிறதா, ஏற்கெனவே insurance இருக்கிறதா, எந்த hospital விருப்பம், எவ்வளவு premium தொடர்ந்து கட்ட முடியும் என்பதை இந்த அத்தியாயத்தில் கேட்கப் பழகலாம். தெரியாததை ஊகிக்காமல், இன்னும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்று குறித்துவைப்பதும் முக்கியம்.

3.1 முதல் சந்திப்பின் நோக்கம்

முதல் சந்திப்பிலேயே ஒரு plan-ஐ விற்று முடிப்பதுதான் இலக்கு என்று நினைக்க வேண்டாம். Customer-க்கு என்ன தேவை என்று புரிஞ்சுக்கிறதுதான் முதல் வேலை. “யாருக்கெல்லாம் cover பார்க்கிறீங்க?” என்று ஆரம்பித்து, குடும்பம், உடல்நிலை, ஏற்கெனவே இருக்கும் policy, budget என ஒவ்வொன்றாகப் பேசலாம்.

“நல்ல policy வேண்டும்” என்று customer சொன்னால் இன்னும் சில கேள்விகள் தேவை. யாருக்கு cover? ஏற்கெனவே என்ன இருக்கு? எந்த hospital? மாதம் அல்லது வருடம் எவ்வளவு budget? புதிய குழந்தை, திருமணம், job change, retirement திட்டம் இருக்கா? ஒவ்வொரு பதிலும் recommendation-ஐ மாற்றலாம்.

சிம்பிளாகச் சொன்னால்

“உங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்ற plan சொல்லணும்னா, முதலில் சில details தெரிஞ்சுக்கணும். யாரெல்லாம் இருக்காங்க, வயது என்ன, regular treatment இருக்கா, ஏற்கெனவே cover இருக்கா என்று பார்க்கலாம். அதற்குப் பிறகு உங்க budget-க்கு ஏற்ற options-ஐ conditions-உடன் ஒப்பிடலாம்.”

3.2 குடும்ப வரைபடம்

Name, DOB அல்லது சரியான age, relationship, dependent status பதிவு செய்யுங்க. “2 adults, 2 children” என்பது quote-க்கான ஆரம்ப detail மட்டுமே. ஒவ்வொருவரின் வயதும் medical history-யும் தெரிந்தால்தான் முழு need புரியும்.

Parents அதே ஊரில் இருக்கிறார்களா, வேறு ஊரில் treatment எடுக்கிறார்களா என்று கேளுங்க. College-க்காக வேறு மாநிலத்தில் இருக்கும் பிள்ளை, அடிக்கடி பயணம் செய்பவர் ஆகியோருக்கு hospital access வேறாக இருக்கலாம். ஆனால் policy-ல் இல்லாத geographical benefit-ஐ நாம உருவாக்கிச் சொல்லக் கூடாது.

பதிவு செய்யும் விவரம்	ஏன் தேவை	பதிவின் தரச் சோதனை
பிறந்த தேதி	eligibility மற்றும் Quote	ஆவணத்துடன் பொருந்துகிறதா?
உறவு	family வரையறை	திட்டம் ஏற்றுக்கொள்கிறதா?
வசிக்கும் நகரம்	நடைமுறை Hospital access	சிகிச்சை பெறும் நகரமும் இதுதானா?
ஏற்கெனவே உள்ள Policy	continuity மற்றும் gap	முழு schedule கிடைத்துள்ளதா?
Renewal தேதி	நேரத்தில் முடிவு	நினைவில் சொன்ன தேதியா, ஆவணத் தேதியா?
தொடர்பு விருப்பம்	Follow-up திட்டம்	நேரம் மற்றும் channel ஒப்புதல் உள்ளதா?

3.3 மருத்துவ வரலாற்றை மரியாதையுடன் கேட்பது

“நோய் இருக்கா?” என்று கேட்டால் “இல்லை” என்று சொல்லலாம். ஆனா regular tablets, old surgery, admission history இருக்கலாம். “தொடர்ந்து medicine

எடுக்கிறீங்களா?", "முன்னாடி hospital admission அல்லது operation இருந்ததா?", "Doctor follow-up அல்லது test சொல்லியிருக்காரா?" என்று தெளிவாகக் கேளுங்க.

Diabetes, BP, thyroid, asthma, heart/kidney problems, cancer history, surgery ஆகியவற்றுக்கு diagnosis date, treatment, current medicines, available reports பதிவு செய்யலாம். Report-ஐ வைத்து advisor medical judgement சொல்லக் கூடாது. "Value நல்லா இருக்கு; நோய் இல்லை" என்று disclosure-ஐ நீக்க வேண்டாம்.

Pending tests-உம் முக்கியம். Diagnosis இன்னும் வரவில்லை என்பதால் "எதுவும் இல்லை" என்று பதிவு செய்யாதீங்க. Proposal கேட்கும் symptoms, doctor advice, scheduled tests, pending reports எல்லாம் disclose செய்யணும். தெரியாததை No போடாமல், "உறுதி செய்யணும்" என்று note செய்து submit செய்வதற்கு முன் clarify செய்யுங்க.

யாருடைய detail-ஐ யார் share செய்கிறார்கள் என்று தெளிவு வேண்டும். Family medical report-ஐ marketing group-க்கு forward செய்யாதீங்க.
தேவையானவர்களுக்கு மட்டுமே safe access கொடுங்க. CRM-ல் எல்லாரும் full report பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

3.4 தற்போதைய பாதுகாப்பை உண்மையாக வாசித்தல்

"₹5 லட்சம் insurance இருக்கு" என்ற பதில் மட்டும் போதாது. அது office cover-ஆ, Individual-ஆ, Floater-ஆ என்று கேளுங்க. Start date, தொடர்ந்து renew செய்த விவரம், SI மாற்றங்கள், bonus, பழைய claims, endorsements எல்லாம் பாருங்க. Premium மட்டும் தெரியும் screenshot-ல் இந்த விவரங்கள் கிடைக்காது.

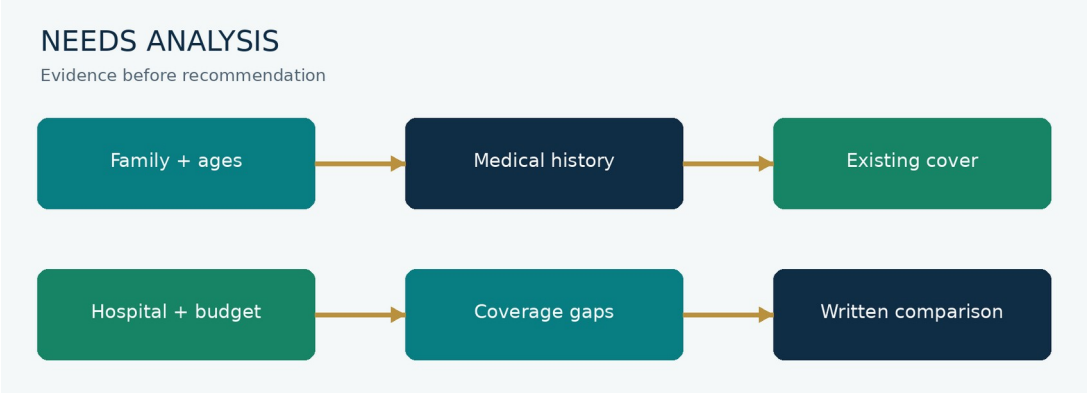
பழைய policy-ல் நல்ல continuity benefits இருக்கலாம். புதிய policy விற்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை உடனே நிறுத்தச் சொல்லாதீங்க. Waiting Period credits, underwriting, புதிய conditions ஆகியவற்றை ஒப்பிடணும். புதிய insurer ஏற்றுக்கொண்டதையும் cover dates பொருந்துவதையும் உறுதி செய்த பிறகுதான் மாற்றத்தை முடிவு செய்யணும்.

3.5 Hospital விருப்பமும் நிதித் திறனும்

குடும்பம் வழக்கமாகச் செல்ல விரும்பும் இரண்டு அல்லது மூன்று hospitals பெயர்களைக் கேளுங்க. Network list மாறலாம். இன்று பார்த்ததற்கான தேதியைக் குறித்துவையுங்க; admission நேரத்திலும் மீண்டும் check செய்யணும். Network hospital என்பதற்காக அந்த bill முழுவதும் approve ஆகும் என்று அர்த்தம் இல்லை.

Budget என்றால் இந்த வருட premium மட்டும் இல்லை. அடுத்த வருடங்களிலும் கட்ட முடியுமா? வயது அல்லது plan revision காரணமாக premium மாறினால் சமாளிக்க முடியுமா? Co-pay வந்தால் பணம் எங்கிருந்து வரும்? இதையும் பேசணும். மொத்த வருமானத்தைச் சொல்லச் சொல்லி வற்புறுத்தாமல், அவர்களுக்கு வசதியான premium range-ஐக் கேட்கலாம்.

மிகப் பெரிய SI சொன்னாலே நல்ல advice ஆகிவிடாது. Premium தொடர முடியாமல் அடுத்த வருடம் policy lapse ஆனால் பயன் குறையும். அதே நேரத்தில் budget குறைவு என்பதற்காக முக்கிய exclusions-ஐ மறைக்கக் கூடாது. Cover, சொந்தச் செலவு, தொடர்ந்து கட்டக்கூடிய premium மூன்றையும் சேர்த்துப் பாருங்க.



படம் 3.1 • தேவையாய்வில் இணைக்கப்படும் தகவல்கள்.

3.6 ஒரு முழுமையான Needs analysis உதாரணம்

ஒரு கற்பனைக் குடும்பத்தைப் பார்க்கலாம். செந்தில் 38, லதா 34; குழந்தைகள் 8, 4 வயது. கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறார்கள். செந்திலுக்கு office மூலம் ₹3 லட்சம் Floater உள்ளது; அது வேலை தொடர்வதைச் சார்ந்தது. லதா thyroid medicine எடுத்துக்கொள்கிறார். வேலைக்கு வெளியே தனியாக family cover வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். Premium-க்கு வசதியான budget range-ஐ செந்தில் சொல்கிறார். இது actual quote இல்லை.

இங்கே மூன்று தவறுகளைச் செய்யாதீங்க. “Thyroid சின்ன விஷயம்” என்று விட்டுவிடுவது ஒன்று. Office ₹3 லட்சம் + புதிய ₹10 லட்சம் என்றால் நிபந்தனையில்லாத ₹13 லட்சம் cover என்று சொல்வது அடுத்தது. பிள்ளைகளின் பெயர், பிறந்த தேதியைச் சரிபார்க்காமல் proposal அனுப்புவது மூன்றாவது.

இந்தக் குடும்பத்தின் தேவையை இப்படி எழுதலாம்: “வேலை மாறினாலும் தொடரக்கூடிய தனி family cover வேண்டும். நால்வரும் சேரணும். Thyroid details முழுமையாக disclose செய்யணும். விருப்பமான hospitals-ன் network status பார்க்கணும். ₹5, ₹10, ₹20 லட்சம் options-ல் premium, room, co-pay, Waiting Period ஆகியவற்றை ஒப்பிடணும்.”

கவனிச்சீங்களா? இங்கே இன்னும் product name சொல்லவே இல்லை. முதலில் தேவை தெளிவாகிறது; பிறகுதான் plans shortlist செய்கிறோம். Quotes வந்ததும் ஒரே வயது, family combination, health details, options வைத்துத்தான் ஒப்பிடுகிறோமா என்று பாருங்க. Quote date, validity-யையும் சேர்த்துக் குறிக்கணும்.

மாற்று சூழலைச் சோதித்தல்

“ஒரே வருடத்தில் இரண்டு admissions வந்தால்?”, “செந்தில் வேலை மாறினால்?”, “பெற்றோரைச் சேர்க்க நினைத்தால்?”, “அடுத்த வருட budget குறைந்தால்?” என்று பேசிப் பாருங்க. பயமுறுத்துவதற்காக இல்லை; நம்ம பரிந்துரை எந்த விஷயங்களைச் சார்ந்திருக்கிறது என்று புரியவைக்கத்தான். எதிர்கால medical expense நமக்குத் துல்லியமாகத் தெரியும் என்று சொல்ல வேண்டாம்.

3.7 ஆலோசகர் முடிவுப் பதிவு

சந்திப்பு முடிந்ததும் மூன்று விஷயங்களை எழுதுங்க: என்ன உறுதியானது, இன்னும் என்ன தகவல் வேண்டும், அடுத்து என்ன செய்யணும். CRM-ல் “Interested” என்று மட்டும் எழுதாதீங்க. “Existing schedule வாங்கணும்; சம்மதத்துடன் thyroid prescription பெறணும்; வெள்ளி இரவு 7 மணிக்கு quote பேசணும்” என்று எழுதினால் அடுத்த வேலை தெளிவாக இருக்கும்.

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது	இன்னும் தேவை	அடுத்த செயல்
நால்வருக்கு பாதுகாப்பு தேவை	சரியான DOB	Customer ஆவணம் பகிர வேண்டும்
Employer பாதுகாப்பு உள்ளது	master நிபந்தனைகள் அல்லது certificate	HR copy பெறுதல்
Thyroid மருந்து உள்ளது	prescription மற்றும் வரலாறு	proposal disclosure தயாரித்தல்
மூன்று SI விருப்பங்கள் பார்க்க விருப்பம்	official Quote	ஒரே அனுமானங்களில் ஒப்பீடு

“இந்த option-ஐப் பார்க்கச் சொல்வதற்குக் காரணம்...” என்று விளக்கிப் பரிந்துரையுங்க. Underwriting முடிந்திருக்கவில்லை என்றால் அதையும் சொல்லுங்க. ஒரு premium estimate, insurer-ன் final offer, issued policy மூன்றும் ஒரே நிலை இல்லை.

3.8 Customer-கிட்ட இப்படிப் பேசலாம்

Customer: “எனக்கு cheapest plan மட்டும் சொல்லுங்க.”

Advisor: “உங்க budget-க்குள் பார்க்கலாம். முதலில் யாருக்கெல்லாம் cover வேணும், ஏற்கெனவே policy இருக்கா, regular medicine எடுக்கிறீங்களா என்று தெரிஞ்சுக்கிறேன். Premium குறைவா இருக்கும் option-ல் என்ன conditions இருக்குன்னும் சேர்த்துக் காட்டுறேன்.”

Customer: “என் மனைவிக்கு thyroid மட்டும். அதை எழுத வேண்டுமா?”

Advisor: “ஆமாம், proposal-ல் கேட்கும் medical details-ஐ முழுசாகச் சொல்லணும். Medicine பெயர், diagnosis, கிடைக்கும் reports எல்லாம் சரியாகப் பதிவு செய்வோம். Company பார்த்து என்ன conditions-ல் ஏற்க முடியும்னு சொல்லும்.”

Customer: “என்னோட மருத்துவ அறிக்கை எல்லாருக்கும் போயிடுமா?”

Advisor: “உங்க சம்மதத்துடன், இந்த application-க்கு தேவையான team-க்கு மட்டும்தான் பகிரணும். என்ன report எதற்குத் தேவைன்னு சொல்லுறேன். பொதுவான WhatsApp group-ல் medical report போட வேண்டாம்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

Age-ஐ round off செய்வது, இன்னொருவர் சொன்னதால் medicines-க்கு No போடுவது, old quote-ஐ current quote போல அனுப்புவது தவறு. Medical history வரும்முன் final premium உறுதி கொடுக்காதீங்க. Field காலியாக இருக்கிறது என்பதற்காக zero அல்லது No நிரப்புவது சரியான data entry இல்லை.

அதே mobile number-ல் புதிய enquiry வந்தால் duplicate contact இருக்கலாம். ஆனால் புதிய need-ஐ தனி enquiry-ஆக பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். CRM எப்படி இருந்தாலும் medical history, decision trail அழியக் கூடாது. Marketing follow-up-உம் customer ஏற்றுக்கொண்ட service follow-up-உம் தெளிவாக நிர்வகிக்கணும்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Needs analysis என்றால் form நிரப்புவது மட்டும் இல்லை. குடும்பம், medical details, ஏற்கெனவே இருக்கும் cover, hospital விருப்பம், budget எல்லாம் இணைத்துப் பார்க்கணும். தெரியாததற்கு நாமே பதில் எழுதிவிடாமல், “உறுதி செய்யணும்” என்று வைத்துக்கொள்வதுதான் சரியான அணுகுமுறை.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. “Company பாதுகாப்பு இருக்கு” என்ற பதிலுக்குப் பிறகு கேட்க வேண்டிய ஐந்து கேள்விகளை எழுதுங்க.

2. வழக்கமான medicine இருப்பவர் “எனக்கு நோய் இல்லை” என்றால் அடுத்த கேள்வியை எப்படி கேட்பீங்க?

3. செந்தில் குடும்பத்திற்கான பரிந்துரைக்கு முன் பெற வேண்டிய ஆவணங்களைப் பட்டியலிடுங்கள்.

4. Customer Budget குறைவாக இருந்தால் எந்தத் தகவல்களை மறைக்காமல் விளக்கணும்?

5. “Follow up later” என்ற CRM note-ஐச் செயல் தெளிவான note-ஆக மாற்றுங்க.

6. Customer கேட்காத குடும்ப உறுப்பினரின் அறிக்கை வந்தால் அதன் பயன்பாட்டை எப்படி கட்டுப்படுத்துவீர்கள்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்

முதல் கேள்வியில் type, SI, காப்பீட்டில் இடம்பெற்ற members, employment-end நிபந்தனை மற்றும் renewal/continuity முக்கியம். நான்காவது கேள்வியில் co-pay, deductible, Waiting Periods, room வரம்புகள் மற்றும் Renewal-க் கட்டணத் திறன் இடம்பெறணும். ஐந்தாவது கேள்வியில் செயல், பொறுப்பாளர், தேதி, நேரம் மற்றும் நிலுவை ஆவணம் தெளிவாக இருக்கணும்.

Advisor Checklist

• பெயர், DOB மற்றும் உறவை உறுதி செய்துள்ளேனா?

• ஒவ்வொருவரின் மருத்துவ வரலாறு தனியாகப் பதிவாகியுள்ளதா?

• Existing Policy-ன் முழு schedule கிடைத்துள்ளதா?

• Customer ஒப்புதல் மற்றும் தொடர்பு விருப்பம் பதிவாகியுள்ளதா?

• Hospital விருப்பம் மற்றும் Hospital இணைப்புச் சரிபார்ப்பு தேதி உள்ளதா?

• செலவுத் திட்டத்திற்கும் சொந்தச் செலவுப் பங்குப் பொறுப்பு-க்கும் இடையிலான தொடர்பை விளக்கியுள்ளேனா?

• உறுதியான தகவலையும் நிலுவை தகவலையும் பிரித்துள்ளேனா?

• தேவை விளக்கத்தை Customer-உடன் சரிபார்த்துள்ளேனா?

ஆதாரம்: P01 முதல் P04 proposal மற்றும் disclosure நிபந்தனைகள்; R01 policyholder தகவல் மற்றும் continuity provisions. இந்த அத்தியாயத்தின் ஆலோசனை நடைமுறைகள் ஆசிரியர் உருவாக்கிய பயிற்சி வழிகாட்டுதல்கள்; செந்தில் குடும்பம் கற்பனை உதாரணம்.

அத்தியாயம் 04

Insurance Terms கணக்குடன் புரிஞ்சுக்கலாம்

Insurance Terminology

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

ஒரு term-ன் தமிழ் அர்த்தம் மட்டும் தெரிந்தால் போதாது. அது bill-ல் என்ன மாற்றம் செய்கிறது என்று தெரிஞ்சுக்கணும். SI, Premium, Co-pay, Deductible, Sub-limit, Room Rent, Restoration, Bonus, Consumables, Waiting Period, Exclusions ஆகியவற்றை இந்த அத்தியாயத்தில் கணக்குடன் பார்க்கலாம்.

4.1 சொல் தெரிந்தால் மட்டும் போதாது

Customer-க்கு term தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் “எவ்வளவு பணம் நானே கட்டணும்?” என்ற கேள்வி நிச்சயமாக இருக்கும். அதனால ஒவ்வொரு term-ஐயும் அதன் அர்த்தம், எந்த amount-க்கு பொருந்தும், எப்போது பொருந்தும், என்ன limit என்று இணைத்து விளக்குங்க.

இந்த அத்தியாயத்தின் எண்கள் training-க்கான கற்பனைக் கணக்குகள். Actual company premium அல்லது guaranteed benefit இல்லை. “Term புரிய ஒரு example” என்று சொல்லிவிட்டுக் கணக்கைக் காட்டுங்க. உண்மையான claim-ல் wording, schedule, admissibility, settlement assessment முடிவை மாற்றும்.

4.2 Sum Insured

Sum Insured என்பது policy-ல் இருக்கும் cover தொகை. அது ஒருவருக்குத் தனியா அல்லது குடும்பம் பகிர்ந்துகொள்ளவா என்று முதலில் பார்க்கணும். Base SI, bonus, restoration எல்லாவற்றையும் ஒரே cash balance போலச் சேர்த்துச் சொல்ல வேண்டாம்; ஒவ்வொன்றுக்கும் விதிகள் இருக்கலாம்.

கணக்கு: வருடாந்திர அடிப்படை SI ₹10 லட்சம். முதல் தகுதியான Claim ₹3 லட்சம், இரண்டாவது ₹2 லட்சம். Bonus/restoration மற்றும் பிற கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத எளிய மாதிரியில் மீதம் ₹5 லட்சம். அடுத்த Bill ₹6 லட்சம் வந்தால் அடிப்படை remaining ₹5 லட்சம் என்பதையே முதலில் அறிய வேண்டும்; முழு ₹6 லட்சமும் கிடைக்கும் என்று முடிவு செய்ய முடியாது.

Customer-கிட்ட இப்படி சொல்லலாம்: “இந்தக் காலத்துக்கான முக்கிய cover limit இது. ஆனா இந்த limit-க்குள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு செலவும் policy-ல் eligible-ஆ இருக்கணும்.” SI-ஐ wallet balance போல மட்டும் காட்ட வேண்டாம்; expense cover ஆகிறதா என்பதையும் பார்க்கணும்.

4.3 Premium

Premium insurance cover-க்காகக் கட்டும் amount; claim செய்தால் மட்டும் கட்டும் பணம் இல்லை. Payment mode, period, selected options, underwriting conditions final premium-ஐ மாற்றலாம். பழைய premium chart வைத்து இன்றைய final quote என்று சொல்லாதீங்க.

கணக்கு: பயிற்சிக்காக வருடாந்திர premium ₹18,000 என்று எடுத்துக்கலாம். அதை 12-ஆல் வகுத்தால் மாதத்திற்கு சராசரி Budget ₹1,500. ஆனால் Insurer-ன் monthly instalment ₹1,500 என்ற முடிவை இதிலிருந்து எடுக்க முடியாது. அதிகாரப்பூர்வ payment விருப்பம் மற்றும் Quote தனியாக வேண்டும்.

“ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான்” என்று கணக்குக் காட்டலாம். ஆனால் உண்மையில் எவ்வளவு due, எந்த date-க்குள் கட்டணும் என்று பெரிய எழுத்தில் காட்டணும். சின்ன daily amount சொல்லி actual payment பொறுப்பை மறைக்காதீங்க.

4.4 Co-payment

Co-payment அல்லது co-pay என்றால் admissible claim-ல் customer ஏற்க வேண்டிய சதவீதம். Bill முழுவதற்குமா அல்லது policy ஏற்றுக்கொண்ட amount-க்கா co-pay போடப்படுகிறது என்பதை wording-ல் பாருங்க. சதவீதத்தை மட்டும் சொல்லாமல் ரூபாயிலும் கணக்குப் போட்டுக் காட்டினால் எளிதாகப் புரியும்.

கணக்கு: மொத்த Bill ₹2,40,000; ஏற்கப்படாத செலவு ₹20,000; Admissible amount ₹2,20,000. Co-pay 10% என்றால் Customer co-pay ₹22,000. மற்ற கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத நிலையில் Insurer பங்கு ₹1,98,000. Customer-ன் மொத்தப் பங்கு ₹20,000 + ₹22,000 = ₹42,000.

பகுதி	கணக்கு	தொகை
Admissible amount	₹2,40,000 − ₹20,000	₹2,20,000
Co-pay	₹2,20,000 × 10%	₹22,000
Insurer பங்கு	₹2,20,000 − ₹22,000	₹1,98,000
Customer மொத்தப் பங்கு	₹20,000 + ₹22,000	₹42,000

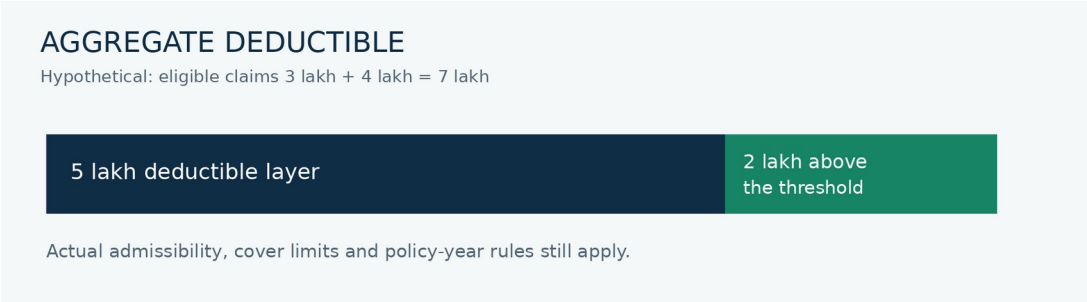
“10% co-pay என்றால் bill-ல் 10% மட்டும் நீங்க கட்டணும்” என்பது தவறாகலாம். Non-payables, deductible, sub-limit இருந்தால் customer செலவு கூடும். எந்த order-ல் கணக்கிடணும் என்பதை wording-ல் பாருங்க.

4.5 Deductible

Deductible insurer pay செய்வதற்கு முன் பொருந்தும் threshold. அது ஒவ்வொரு claim-க்கா, admission-க்கா, ஒரு policy year-ன் aggregate-க்கா என்பது முக்கியம். “₹5 லட்சம் deductible” என்று மட்டும் சொன்னால் முழுமையாகப் புரியாது.

ஒரே Claim மாதிரி: Admissible expense ₹8 லட்சம்; deductible ₹5 லட்சம்; பாதுகாப்பு வரம்பு போதுமானது; வேறு deduction இல்லை. Threshold-க்கு மேலான தொகை ₹3 லட்சம். Deductible பகுதியை Base Policy அல்லது சொந்த நிதி போன்ற வழியில் ஏற்க வேண்டியிருக்கலாம். எந்தச் செலவு threshold-க்கு கணக்கிடப்படும் என்பதற்கும் wording அவசியம்.

பல Claims மாதிரி: அதே ஆண்டு ₹3 லட்சம் மற்றும் ₹4 லட்சம் தகுதியான செலவுகள். Aggregate deductible மாதிரியில் மொத்தம் ₹7 லட்சம்; deductible-க்கு மேல் ₹2 லட்சம். Per-Claim threshold மாதிரியில் இரண்டுமே ₹5 லட்சத்தைத் தாண்டவில்லை. அதனால் ஒரு சொல் கணக்கின் முடிவையே மாற்றுகிறது.



படம் 4.1 • ₹5 லட்சம் aggregate deductible பற்றிய கற்பனைக் கணக்கு.

4.6 Sub-limit

Sub-limit என்றால் பெரிய cover-க்குள் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட செலவுக்கான தனி limit. ₹10 லட்சம் SI இருக்கிறது என்பதால் எல்லா treatment-க்கும் ₹10 லட்சம் கிடைக்காது. ஒரு treatment-க்கு தனி limit இருந்தால் அது பொருந்தும். அந்த limit ஒரு claim-க்கா, ஒரு வருடத்துக்கா என்பதையும் பார்க்கணும்.

கணக்கு: கற்பனை Policy-ல் ஒரு சிகிச்சைமுறைக்கு ₹50,000 Sub-limit. அதற்கான தகுதியான செலவு ₹80,000. மற்ற deduction இல்லை என்றால் அந்தப் பிரிவின் அதிகபட்சப் பரிசீலனை ₹50,000; மீதி ₹30,000 Customer-ன் செலவுப் பொறுப்பு. ஆனால் உண்மையான கணக்கில் packaged expenses மற்றும் பொருந்தும் clause-ஐப் பார்த்தே இறுதி முடிவு செய்யணும்.

எளிய விளக்கம்: “மொத்த பாதுகாப்பு பெரியதாக இருந்தாலும் சில செலவுகளுக்கு தனி உச்சவரம்பு இருக்கலாம்.” ஒப்பீட்டில் Sub-limit உள்ள பலனை மறைத்து SI மட்டும் bold-ஆகக் காட்டாதீர்கள். Customer-க்கு முக்கியமான சிகிச்சை category இருந்தால் அந்த row-ஐப் பிரத்தியேகமாக விளக்குங்க.

4.7 Room Rent மற்றும் Room Category

Room eligibility ஒரு நாளுக்கான தொகையாகவோ, SI-யின் சதவீதமாகவோ, குறிப்பிட்ட category-ஆகவோ இருக்கலாம். “Single private room” மற்றும் “any room”

ஒன்றல்ல. Suite, deluxe அல்லது Hospital-ன் category பெயர் Insurer-ன் wording-க்கு எப்படி பொருந்துகிறது என்பதை அனுமதிக்கு முன் உறுதி செய்யணும்.

Room eligibility-ஐ மீறினால் room Bill வித்தியாசம் மட்டுமே Customer செலவாகும் என்று எல்லா Policies-க்கும் சொல்ல முடியாது. சில contracts-ல் associated expenses-க்கும் proportionate deduction இருக்கலாம்; எந்த items-க்கு அது பொருந்தாது என்பதற்கும் விதிகள் இருக்கலாம். எல்லா Bill items-க்கும் ஒரே விகிதத்தைத் தானாகப் பயன்படுத்துவது தவறு.

விளக்கக் கணக்கு: தகுதியான room ₹5,000/day; தேர்ந்தெடுத்த room ₹8,000/day; stay 4 days. Room charge வித்தியாசம் மட்டும் ₹12,000. இந்த எளிய எண்ணை உண்மையான மொத்தம் deduction என்று சொல்ல முடியாது. தொடர்புடைய charges-க்கு deduction clause உள்ளதா என்பது அடுத்த சோதனை. ₹5,000 ÷ ₹8,000 = 62.5% என்ற விகிதம் கணக்குப் பயிற்சிக்கே; முழு Bill-க்கு பொதுவாகப் பொருந்தும் விதி அல்ல.

ஆலோசகர் வழிகாட்டல்: Customer விரும்பும் Hospital-ல் தகுதியான room கிடைக்குமா, room category unavailable என்றால் Insurer-ன் நடைமுறை என்ன என்பதை முன்பே கேட்க உதவுங்கள். Hospital சொல்லும் வாய்மொழித் தகவல் மட்டுமே Policy amendment ஆகாது.

4.8 Restoration

Restoration என்றால் policy விதிப்படி cover தொகை மீண்டும் கிடைக்கும் வசதி. ஆனால் எப்போது restore ஆகும்? முழுவதும் பயன்படுத்திய பிறகா, ஒரு பகுதி பயன்படுத்திய பிறகா? அதே claim-க்கா, அடுத்த claim-க்கா? அதே நோய்க்கும் கிடைக்குமா? எத்தனை முறை? இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதில் இல்லாமல் “cover திரும்ப வந்துடும்” என்று மட்டும் சொல்லாதீங்க.

கற்பனை விதியுடன் கணக்கு: ₹10 லட்சம் அடிப்படை பாதுகாப்பு கொண்ட ஒரு மாதிரி Policy, utilisation-க்கு பிறகு subsequent அனுமதிகளுக்காக ₹10 லட்சம் restore செய்கிறது என்று வெளிப்படையாகக் கருதுவோம். முதல் அனுமதிக்கப்படும் Claim ₹12 லட்சம் என்றால் அதே Claim-ஐ restoration முழுமையாக நிரப்பும் என்று சொல்ல முடியாது; நமது கற்பனை விதி subsequent அனுமதிக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கிறது. முதல் Claim-க்கு பிறகு மீதம், restoration மற்றும் அடுத்த Claim eligibility ஆகியவற்றை தனித்தனியாகக் கணக்கிட வேண்டும்.

“Unlimited restoration” என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு bill வந்தாலும் முழுவதும் கிடைக்கும் என்று அர்த்தம் இல்லை. Restore ஆகும் எண்ணிக்கை வேறு; ஒரு claim-க்கு பயன்படுத்தும் limit வேறு. ஒப்பீட்டில் இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் எழுதிக் காட்டுங்க.

4.9 No Claim Bonus மற்றும் Cumulative Bonus

No Claim Bonus என்பது claim இல்லாதபோது policy விதிப்படி கிடைக்கக்கூடிய benefit. கூடுதல் SI-ஆக இருக்கலாம்; renewal premium discount-ஆகவும் இருக்கலாம். எவ்வளவு சேரும், அதிகபட்சம் எவ்வளவு, claim செய்தால் என்ன ஆகும் என்பவை ஒவ்வொரு policy-க்கும் மாறும். [R01, அத்தியாயம் I, பத்தி 14]

கற்பனை கணக்கு: ₹10 லட்சம் அடிப்படை SI; Claim-free year-க்கு 20% cumulative bonus; அதிகபட்சம் 100% என்று வைத்துக்கலாம். முதல் qualifying renewal-ல் bonus ₹2 லட்சம்; அடிப்படை + bonus ₹12 லட்சம். இரண்டாவது qualifying renewal-ல் மொத்த bonus ₹4 லட்சம்; பாதுகாப்பு ₹14 லட்சம். இது எந்த திட்டத்தின் rate-யும் அல்ல. Claim ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும் என்பதை இந்த Assumptions சொல்லவில்லை; அதன் தனி நிபந்தனை தேவை.

“பிறகு bonus வருமே; இப்போ குறைந்த base cover போதும்” என்று உடனே முடிவு செய்யாதீங்க. Bonus கிடைக்க எதிர்காலத்தில் சில conditions பூர்த்தியாக வேண்டியிருக்கலாம். பெரிய செலவு முதல் வருடத்திலேயே வந்தால்? இப்போது இருக்கும் cover-ஐயும் பின்னால் கிடைக்கக்கூடிய benefit-ஐயும் தனியாகக் காட்டணும்.

4.10 Consumables மற்றும் Non-payable Expenses

Hospital bill-ல் இருக்கும் ஒவ்வொரு item-மும் policy-ல் payable ஆகிவிடாது. Consumables, admin charges, package-ல் சேர்ந்த items, exclusions ஆகியவற்றைத் தனியாகப் பார்க்கணும். Consumables cover இருக்கிறது என்பதால் “ஒரு deduction-மும் வராது” என்று சொல்லக் கூடாது.

கணக்கு: Bill ₹1,50,000; அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டியலின் items ₹8,000. அவை அடிப்படை பாதுகாப்பில் excluded என எடுத்துக்கொண்டால், மற்ற நிபந்தனைகளுக்கு முன் பரிசீலிக்கப்படும் தொகை ₹1,42,000. ஒரு optional பலன் அந்த items-ஐ ஏற்றால் கணக்கு மாறலாம். ஆனால் optional பாதுகாப்பின் வரம்பு, list மற்றும் applicability பார்த்த பிறகே ₹8,000 முழுவதும் சேர்க்க முடியும்.

Settlement-ல் “Non-medical” என்று ஒரு மொத்த amount இருந்தால் அதோடு நிறுத்தாதீங்க. Item-wise deduction sheet கேளுங்க. அந்த item package-ல் ஏற்கெனவே உள்ளதா, policy-ல் excluded-ஆ, கூடுதல் invoice தேவையா என்று பிரித்துப் பாருங்க.

4.11 Waiting Period

Policy தொடங்கும் நாளும் எல்லா benefits கிடைக்கும் நாளும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டியதில்லை. சில cover-க்கு Waiting Period இருக்கும். Initial, specified disease, PED, maternity என ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி விதி இருக்கலாம். எல்லாவற்றையும் ஒரே waiting என்று குழப்ப வேண்டாம்.

தேதி உதாரணம்: ஒரு கற்பனை Policy-ல் குறிப்பிட்ட பலனுக்கு 24 மாத uninterrupted coverage தேவை. தொடக்கம் 01-01-2026 எனில், இரண்டாம் ஆண்டு முடியும் நேரம் வரை அந்தக் Waiting பொருந்தும்; 01-01-2028 முதல் பரிசீலனை சாத்தியமாகலாம். ஆனால் Policy-ன் exact time, continuity, Claim தேதி மற்றும் wording கணக்கை உறுதி செய்யணும். “இரண்டு calendar years மாறிவிட்டன” என்பது 24 மாதங்கள் முடிந்ததற்குச் சமமல்ல.

Waiting Period முடிந்ததும் எல்லா treatments-க்கும் automatic approval கிடைக்காது. Disclosure, medical necessity, exclusions, available limit போன்ற conditions தொடர்ந்து

பொருந்தும். பழைய policy continuity credit ஏற்கப்பட்டிருந்தால் waiting கணக்கு மாறலாம்; அதற்கான எழுத்துப் பதிவு இருக்கணும்.

4.12 Exclusions

Exclusion என்றால் policy cover செய்யாத செலவு அல்லது சூழல். சில exclusions நிரந்தரமாக இருக்கலாம்; தனிப்பட்ட endorsement-லும் இருக்கலாம். இதை Waiting Period என்று சொன்னால் “கொஞ்ச நாள் போனால் cover ஆகும்” என்ற தவறான எதிர்பார்ப்பு வரும்.

கணக்கு: ஒரு கற்பனை Policy-ல் குறிப்பிட்ட cosmetic சிகிச்சைமுறை excluded; செலவு ₹1 லட்சம். SI ₹20 லட்சம் இருந்தாலும் அந்த exclusion பொருந்தினால் SI பெரியதாக இருப்பதால் மட்டும் payment கிடைக்காது. “Cosmetic” என்ற label மட்டும் வைத்து உண்மையான மருத்துவ case-ஐ முடிவு செய்ய வேண்டாம்; reconstructive அல்லது medically necessary exception இருக்கிறதா என்பதை wording மற்றும் மருத்துவ ஆதாரத்துடன் பார்க்கணும்.

4.13 ஒருங்கிணைந்த Bill பயிற்சி

கற்பனை Claim-ல் Bill ₹4 லட்சம். குறிப்பிட்ட non-payables ₹20,000. தனி Sub-limit காரணமாக Admissible amount-யில் மேலும் ₹30,000 குறைகிறது என்று Assumptions கொடுக்கப்படுகின்றன. அதன் பிறகு 10% co-pay பயன்படுத்தப்படுகிறது; deductible இல்லை; remaining SI போதுமானது. இந்த வரிசை இந்தப் பயிற்சிக்காக மட்டுமே குறிப்பிட்டது.

படி	தொகை
மொத்த Bill	₹4,00,000
Non-payables கழித்த பின்	₹3,80,000
Sub-limit adjustment கழித்த பின்	₹3,50,000
10% co-pay	₹35,000
Insurer பங்கு	₹3,15,000
Customer மொத்தப் பங்கு	₹85,000

சரிபார்ப்பு: ₹3,15,000 + ₹85,000 = ₹4,00,000. இந்த reconciliation முக்கியமானது. பல deduction rows உள்ளபோது ஒரே செலவு இருமுறை கழிக்கப்பட்டதா என்று கவனிங்க. உண்மையான settlement-ல் முழுக் கணக்கையும் clause-உடன் ஒப்பிட்டே Customer-கிட்ட விளக்கணும்.

4.14 Customer-கிட்ட இப்படிப் பேசலாம்

Customer: “Deductible-ம் co-pay-ம் ஒன்றுதானே?”

Advisor: “ரெண்டும் வேறு சார். Deductible ஒரு threshold. Co-pay என்பது admissible claim-ல் நீங்க கட்டும் percentage. ரெண்டும் இருந்தால் எந்த வரிசையில் கணக்கிடணும்னு policy பார்த்து ஒரு example காட்டுறேன்.”

Customer: “Restoration unlimited என்று இருக்கே; அப்போ எந்த அளவு Bill வந்தாலும் பிரச்சினை இல்லையா?”

Advisor: “எத்தனை முறை restore ஆகும்னு சொல்வது ஒரு விஷயம். ஒரு claim-க்கு எவ்வளவு பயன்படுத்தலாம், எந்த admission-க்கு கிடைக்கும் என்பது இன்னொரு விஷயம். அந்த conditions-ஐயும் சேர்த்துப் பார்ப்போம்.”

Customer: “என்னால் இந்தச் சொற்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது.”

Advisor: “எல்லா terms-ஐயும் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டாம். உங்க cover limit, நீங்க கட்ட வேண்டிய பங்கு, Waiting Period, முக்கிய exclusions இவற்றை ஒரு பக்கத்தில் எளிமையாக எழுதித் தரலாம்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

Gross Bill-ஐ அனுமதிக்கப்படும் Claim என்று கருதுதல், bonus-ஐ guaranteed cash refund என்று சொல்வது, unused SI-ஐ அடுத்த ஆண்டு தானாக carry forward செய்வது, room difference மட்டுமே deduction என்று உறுதி தருதல் மற்றும் எல்லா non-payables-ஐ consumables விருப்பம் சரிசெய்யும் என்று சொல்வது ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கணும். ஒவ்வொரு numerical explanation-க்கும் Policy-க்குரிய assumption மற்றும் hypothetical assumption வேறுபாடு தெளிவாக இருக்கணும்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

ஒரு term புரியணும்னா அதன் அர்த்தத்தோடு கணக்கையும் பாருங்க. SI பெரியதாக இருந்தாலும் co-pay, deductible, sub-limit, exclusions காரணமாக customer செலவு வரலாம். முதலில் எளிய கணக்கில் கற்றுக்கொள்ளுங்க; உண்மையான claim-ல் அந்த policy wording-க்கு ஏற்றபடி கணக்கிடணும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. அனுமதிக்கப்படும் Claim ₹2,50,000; co-pay 20%. Insurer பங்கு மற்றும் co-pay என்ன?

2. வருடாந்திர premium ₹24,000-ஐ 12-ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் எண்ணை monthly instalment Quote என்று சொல்லலாமா?

3. ₹5 லட்சம் aggregate deductible; தகுதியான Claims ₹1 லட்சம், ₹2 லட்சம், ₹4 லட்சம். Threshold-க்கு மேலான தொகை என்ன?

4. ₹10 லட்சம் SI; சிகிச்சைமுறை Sub-limit ₹60,000; தகுதியான சிகிச்சைமுறை cost ₹90,000. வேறு deduction இல்லை என்றால் gap என்ன?

5. Room eligibility மீறப்பட்டால் தொடர்புடைய charges பற்றி எந்த clause-ஐப் பார்க்கணும்?

6. Restoration பலனை ஒப்பிடுவதற்கு ஐந்து கேள்விகளை எழுதுங்க.

7. ₹2 லட்சம் Bill; non-payables ₹10,000; அதன் பிறகு 10% co-pay. Customer மொத்தப் பங்கு என்ன?

8. Waiting Period முடிந்ததால் permanent exclusion நீங்குமா?

பதில் சரியா பார்ப்போம்

1: Co-pay ₹50,000; Insurer ₹2,00,000. 2: முடியாது; அது Budget average மட்டுமே. 3: ₹2 லட்சம். 4: ₹30,000. 5: பொருந்தும் proportionate deduction மற்றும் அதன் exceptions. 6: Trigger, subsequent/same Claim, same illness, count, per-claim வரம்பு. 7: Admissible ₹1,90,000; co-pay ₹19,000; Customer மொத்தப் பங்கு ₹29,000. 8: இல்லை; ஒப்பந்த மாற்றம் அல்லது பொருந்தும் விதி இல்லாமல் exclusion தானாக நீங்காது.

Advisor Checklist

• Gross Bill மற்றும் admissible Claim-ஐ வேறுபடுத்தியுள்ளேனா?

• Co-pay எந்தத் தொகைக்கு பொருந்துகிறது என்று விளக்கியுள்ளேனா?

• Deductible-ன் அளவும் aggregation period-மும் பதிவாகியுள்ளதா?

• Sub-limit per event-ஆ அல்லது வருடாந்திரமா என்று பார்த்துள்ளேனா?

• Room category மற்றும் associated deduction நிபந்தனை தெரிகிறதா?

• Restoration-ஐ அடிப்படை SI-க்கு சமமான unrestricted balance எனக் காட்டவில்லையா?

• Bonus rate-ஐ சரியான Plan version-ல் உறுதி செய்துள்ளேனா?

• கணக்கில் Insurer பங்கு + Customer பங்கு = Bill எனச் சரிபார்த்துள்ளேனா?

ஆதாரம்: P01 முதல் P04 Definitions, பலன்கள், exclusions மற்றும் cost-sharing நிபந்தனைகள்; R01 பத்தி 14. இங்குள்ள rates, bills மற்றும் calculations அனைத்தும் தனியாகக் குறிப்பிடப்பட்ட கற்பனை அனுமானங்களைச் சார்ந்தவை.

அத்தியாயம் 05

Waiting Period எப்போது என்ன Cover கிடைக்கும்

Waiting Periods and Continuity

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Policy start date மட்டும் தெரிந்தால் போதாது. Initial, specified disease, PED, maternity waiting ஒவ்வொன்றும் எப்படி வேறுபடுகிறது என்று பார்க்கலாம். பழைய continuity-யும் அதிகரித்த SI-யும் கணக்கில் எப்படி வரும் என்பதையும் புரிஞ்சுக்கலாம். Accident exception அல்லது waiting waiver இருந்தாலும் அது முழு claim-க்கான guarantee இல்லை என்பதைக் கவனத்தில் வையுங்க.

5.1 ஒரே Policy பல நேரக் கடிகாரங்கள்

Policy active ஆனதும் எல்லா benefits-உம் ஒரே நாளில் தொடங்கிவிடாது. தகுதியான accident செலவு ஆரம்பத்திலிருந்தே பரிசீலிக்கப்படலாம். சில illness-க்கு initial waiting இருக்கும். குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கும் PED-க்கும் அதிக waiting இருக்கலாம். Maternity-க்கு தனி waiting, eligibility இருக்கலாம். “Policy active-ஆ?” என்பதும் “இந்த benefit இப்போது கிடைக்குமா?” என்பதும் இரண்டு கேள்விகள்.

ஒரே நோய்க்கு இரண்டு waiting clauses பொருந்தும் சூழலும் வரலாம். Specified disease list-லும் PED definition-லும் வரும் நோய் என்றால், wording என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கணும். குறைவான waiting-ஐ மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு “இப்போ cover ஆகும்” என்று சொல்லாதீங்க.

சிம்பிளாகச் சொன்னால்

Customer-கிட்ட இப்படி சொல்லலாம்: “Policy தொடங்கும் நாள் ஒன்று. சில benefits கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நாள் வேறு. உங்களுக்கு முக்கியமான cover என்னன்னு பார்த்து, அதற்கான waiting எப்போ முடியும்னு தனியாகக் குறிச்சுக்கலாம்.” தேதிகளோடு ஒரு timeline காட்டினால் இன்னும் எளிதாகப் புரியும்.

5.2 Initial Waiting Period

பல retail health policies-ல் illness treatment-க்கு ஆரம்ப 30 நாள் waiting இருக்கும்; தகுதியான accident claims-க்கு exception இருக்கலாம். ஆனால் எல்லா policy-க்கும் இதை ஒரே விதியாகச் சொல்லாதீங்க. Wording, renewal continuity, portability credit, தேர்ந்தெடுத்த waiver ஆகியவற்றைப் பார்க்கணும். இந்த நூலின் P01–P04 ஆவணங்களில் initial waiting தனியாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

“31-வது நாள் admit ஆனா எல்லாம் கிடைக்குமா?” இல்லை. நோய் எப்போது ஆரம்பித்தது, diagnosis எப்போது, admission எப்போது என்பதெல்லாம் முக்கியம். PED அல்லது specified disease waiting இன்னும் இருக்கலாம். Clause treatment date-ஐக் குறிப்பிடுகிறதா, நோய் ஏற்பட்ட நாளைக் குறிப்பிடுகிறதா என்பதையும் படிக்கணும்.

புதிய policy-ன் 12-வது நாளில் fever காரணமாக admission வருகிறது என்று வைத்துக்கலாம். Cashless card காட்டினால் மட்டும் waiting நீங்காது. Policy clause-உம் medical facts-உம் பார்க்கணும். Accident admission என்றால் initial-wait exception பரிசீலிக்கப்படலாம். அப்போதும் accident definition, exclusions, available cover எல்லாம் பொருந்தும்.

5.3 Specified Disease Waiting

சில நோய்களுக்கும் procedures-க்கும் தனி Waiting Period இருக்கும். Hernia, cataract, சில ENT procedures என்று நினைவில் இருக்கும் பட்டியலை மட்டும் வைத்து advice கொடுக்காதீங்க. Customer policy-ன் actual list பார்க்கணும். ஒரே மருத்துவப் பெயருக்குள் வேறு procedures இருக்கலாம்; diagnosis-உம் treatment plan-உம் wording-உடன் பொருந்துகிறதா என்று பாருங்க.

ஒரு plan-ல் குறிப்பிட்ட நோய்க்கு 24 மாத waiting என்று வைத்துக்கலாம். Policy வாங்கும்போது அந்த நோய் இல்லாவிட்டாலும் இந்த waiting பொருந்தலாம். இதுதான் PED waiting-க்கும் specified disease waiting-க்கும் முக்கிய வித்தியாசம். “புதுசா வந்த நோய்தானே; உடனே claim கிடைக்கும்” என்று சொல்ல முடியாது.

ஏற்கெனவே surgery திட்டமிட்டிருந்தால் பெயரை மட்டும் கேட்டு policy விற்க வேண்டாம். Symptoms, doctor advice, pending tests பற்றி proposal கேட்கும் details முழுவதையும் பெறணும். Insurance waiting முடியட்டும் என்று treatment-ஐத் தள்ளிப் போடச் சொல்வதும் advisor வேலை இல்லை.

5.4 Pre-existing Disease

PED-ல் இரண்டு காலக் கணக்குகள் இருக்கு. Look-back என்பது policy வாங்குவதற்கு முன் இருந்த diagnosis அல்லது doctor advice/treatment வரலாற்றைப் பார்ப்பது. PED Waiting Period என்பது policy தொடங்கிய பிறகு காத்திருக்கும் காலம். இரண்டையும் குழப்பாதீங்க. P01-ல் 36 மாத look-back இருப்பதால் அதற்கு முன்னால் நடந்த எதையும் சொல்ல வேண்டாம் என்று அர்த்தம் இல்லை. Proposal என்ன கேட்கிறது என்பதற்கும் பதில் சொல்லணும்.

Diabetes அல்லது BP மருந்தால் control-ல் இருந்தாலும் அதை disclose செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். “இப்போ symptoms இல்லை” என்பதால் பழைய history இல்லாமல் போய்விடாது. முழு details கொடுத்து insurer acceptance-உம் conditions-உம் வந்த பிறகுதான் அந்த policy-ன் cover பற்றி உறுதியாகப் பேசணும்.

காலம்	எதைப் பார்க்கிறது	தவறான புரிதல்
PED look-back	ஆரம்பத்திற்கு முந்தைய Diagnosis/advice/சிகிச்சை	இதுவே Claim Waiting
PED Waiting	Policy தொடங்கிய பின் qualifying continuity	முடிந்தால் எல்லா exclusions-மும் நீங்கும்
Moratorium	குறிப்பிட்ட grounds-ல் contest செய்வதற்கான protection	எல்லா Claims-க்கும் automatic payment

PED cover ஆரம்பிக்கும் நாள், disclose செய்த தகவல்கள், schedule special conditions எல்லாம் சேர்த்துப் பார்க்கணும். Waiting reduction option எடுத்தால் எல்லா நோய்களுக்கும் எல்லா waiting-மும் குறையும் என்று நினைக்காதீங்க. எந்த waiting மாறுகிறது, எது மாறவில்லை என்பதை எழுதி விளக்குங்க.

5.5 Maternity Waiting

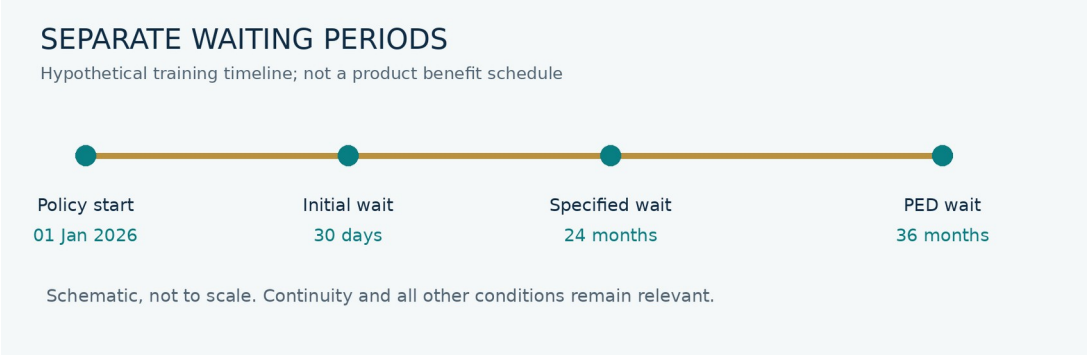
Maternity benefit-க்கு waiting மட்டும் இல்லை. யார் eligible, எந்த event cover, amount limit என்ன, எத்தனை deliveries, தம்பதியர் இருவரும் சேர வேண்டுமா, newborn rules என்ன என பல conditions இருக்கலாம். “Pregnancy வந்த பிறகு வாங்கினாலும் delivery bill கிடைக்கும்” என்று wording பார்க்காமல் சொல்லாதீங்க.

ஒரு தம்பதி அடுத்த ஆறு மாதத்தில் குழந்தை பெறத் திட்டமிடுகிறார்கள். பார்க்கும் benefit-க்கு 24 மாத waiting என்றால், அவர்களின் இப்போதைய maternity தேவைக்கு அது பொருந்தாது. Policy-ன் மற்ற benefits பயனற்றவை என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆனால் இந்த maternity தேவையை அது நிறைவேற்றாது என்பதை நேராகச் சொல்லணும்.

Women Care, Comprehensive, Health Assure எல்லாவற்றிலும் maternity waiting ஒன்றுதான் என்று நினைக்காதீங்க. SI, policy term, benefit conditions மாறலாம். அத்தியாயம் 07-ல் ஆவண அடிப்படையிலான ஒப்பீட்டை பார்க்கலாம்.

5.6 கற்பனை timeline

கீழே உள்ள கோடு ஒரு training model மட்டுமே. இது எந்த திட்டத்தின் பலன் promise-யும் அல்ல. Policy 01-01-2026 அன்று தொடங்குகிறது; initial Waiting 30 நாட்கள், specified Waiting 24 மாதங்கள், PED Waiting 36 மாதங்கள் என்று Assumptions தரப்பட்டுள்ளன. Continuity break இல்லை; PED Insurer-க்கு disclosed and ஏற்கப்பட்ட; மற்ற நிபந்தனைகள் பொருந்துகின்றன.



படம் 5.1 • வெவ்வேறு Waiting Periods; அளவுகோலுக்கு ஏற்ப வரையப்படவில்லை.

Timeline-ல் ஒரு milestone கடந்தால் எல்லா waiting-மும் முடிந்துவிடாது. முதல் 30 நாட்கள் முடிந்ததும் தகுதியான புதிய illness பரிசீலிக்கப்படலாம்; அதே நாளில் PED cover தொடங்கிவிடாது. Specified waiting முடிந்தாலும் அந்த நோய் PED-ஆக இருந்தால் longer waiting rule பொருந்தலாம்.

கணக்குப் பயிற்சி: 01-01-2026 முதல் 31-12-2027 வரை இரண்டு முழு Policy years. 15-12-2027 அன்று நிகழும் சிகிச்சைக்கு “2027 வந்துவிட்டதே” என்று 24 மாத Waiting முடிந்ததாகக் கருத முடியாது. Exact inception time மற்றும் clause-ல் உள்ள calendar கணக்கு தேவை. Renewal receipt-களை வைத்து தொடர்ச்சியை உறுதி செய்யணும்.

5.7 Continuity Credits

Portability அல்லது migration செய்யும்போது விதிப்படி waiting credits மாற்றப்படலாம். ஆனால் SI அதிகரித்தால் கூடுதல் தொகைக்கு புதிய waiting அல்லது underwriting இருக்கலாம். “மூன்று வருடம் policy வைத்திருந்ததால் புதிய ₹20 லட்சமும் முதல் நாளிலிருந்து cover” என்று உறுதி சொல்லாதீங்க.

பழைய cover ₹5 லட்சம்; புதிய cover ₹10 லட்சம் என்று வைத்துக்கலாம். பழைய ₹5 லட்சத்துக்கு eligible continuity credit கிடைக்கலாம். கூடுதல் ₹5 லட்சத்துக்கு தனி waiting இருக்கலாம். எந்தத் தொகைக்கு என்ன credit ஏற்கப்பட்டது என்பதை புதிய insurer-ன் எழுத்துப் பதிவில் பார்க்கணும்.

IRDAI 29-05-2024 circular-ல் migration மற்றும் portability credits, grace period-ல் continuity protection மற்றும் 60 மாத moratorium தொடர்பான விதிகள் தனித்தனியாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் முழுப் பொருளையும் தற்போதைய amendments-உடன் அத்தியாயம் 13-ல் சரிபார்க்கணும். இந்த அத்தியாயத்தின் நோக்கம் காலக் கணக்குகளை ஒன்றாகக் கலக்காமல் கற்றுக்கொள்வது. [R01, பத்திகள் 8, 11–13]

5.8 Customer-கிட்ட இப்படிப் பேசலாம்

Customer: “முப்பது நாள் முடிந்தால் எல்லா நோய்களுக்கும் Claim பண்ணலாமா?”

Advisor: “அது initial Waiting மட்டும். சில நோய்கள், முன்பிருந்த உடல்நிலைகள் மற்றும் maternity போன்ற பலன்களுக்கு வேறு Waiting இருக்கலாம். உங்க Policy-க்கான timeline-ஐப் பிரித்துக் காட்டுகிறேன்.”

Customer: “எனக்கு sugar control-ல் இருக்கு; Waiting இருக்காதே?”

Advisor: “Control-ல் இருப்பது நல்லது. ஆனால் insurance-ல் Diagnosis மற்றும் சிகிச்சை வரலாறும் முக்கியம். அதை முழுமையாக disclose செய்து Insurer எந்த நிபந்தனைகளில் ஏற்கிறது என்று பார்க்கணும்.”

Customer: “பழைய Policy-ஐ நிறுத்திட்டு புதியதா போடலாமா?”

Advisor: “முதலில் continuity credit, acceptance மற்றும் தேதிகள் உறுதி செய்வோம். புதிய proposal கொடுத்துவிட்டது மட்டுமே பழைய பாதுகாப்பை நிறுத்துவதற்கான அடிப்படை அல்ல.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

Policy age மற்றும் insured member-ன் continuity ஒன்றாக இருக்க வேண்டியதில்லை; பின்னர் சேர்க்கப்பட்ட உறுப்பினருக்கு தனி start தேதி இருக்கலாம். SI enhancement, Policy break மற்றும் optional Waiting reduction ஆகியவை காலக் கணக்கை மாற்றலாம். Brochure timeline-ஐ Customer-க்குரிய timeline என்று மாற்றாமல் அனுப்ப வேண்டாம். “Day one accident” என்ற சொல்லிலும் Policy in force மற்றும் தகுதியான accident சிகிச்சை அவசியம்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Waiting Periods பல அடுக்குகளாக இயங்குகின்றன. Initial, specified, PED மற்றும் maternity Waiting-ஐத் தனியாகக் குறிக்க வேண்டும். PED look-back, Waiting மற்றும் moratorium வெவ்வேறு கருத்துகள். Continuity credit-ஐ வாக்குறுதியாக அல்லாமல் ஆவணத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட தகவலாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. புதிய illness என்றால் specified Waiting பொருந்தாதா? காரணம் எழுதுங்க.

2. PED look-back மற்றும் PED Waiting வேறுபாட்டை ஒரு timeline-ல் காட்டுங்க.

3. ₹5 லட்சத்திலிருந்து ₹10 லட்சமாக பாதுகாப்பு உயர்த்தும்போது கேட்க வேண்டிய continuity கேள்விகள் என்ன?

4. 24 மாத Waiting உள்ள பலனுக்கு ஆறு மாதத்தில் delivery எதிர்பார்க்கும் தம்பதியிடம் என்ன சொல்வீர்கள்?

5. பின்னர் சேர்க்கப்பட்ட குழந்தையின் Waiting-ஐ எந்தத் தேதியிலிருந்து பார்க்கணும்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்

முதல் கேள்வியின் விடை: specified Waiting நோய் முன்பே இருந்ததா என்பதிலிருந்து தனியாகப் பொருந்தலாம். மூன்றாவது கேள்வியில் பழைய வரம்பு, credit ஏற்கப்பட்ட தொகை, increased portion மற்றும் new Waiting தேதி இடம்பெறணும். ஐந்தாவது கேள்வியில் member inclusion தேதி மற்றும் பொருந்தும் newborn/child பலன் clause-ஐப் பார்க்கணும்; policyholder-ன் பழைய inception தேதியை தானாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Advisor Checklist

• ஒவ்வொரு Waiting category-க்கும் தனி காலம் பதிவாகியுள்ளதா?

• Initial Waiting மற்றும் accident exception சரியான wording-ல் உள்ளதா?

• மருத்துவ வரலாறு disclosed and ஏற்கப்பட்ட நிலை தெளிவாக உள்ளதா?

• Policy break மற்றும் member inclusion தேதி பார்த்துள்ளேனா?

• SI enhancement-ன் கூடுதல் பகுதி தனியாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளதா?

• Portability credit எழுத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதா?

• Waiting முடிந்தாலும் மற்ற நிபந்தனைகள் தொடரும் என்று விளக்கியுள்ளேனா?

ஆதாரம்: R01 பத்திகள் 8, 11–13; P01 முதல் P04 exclusions மற்றும் continuity clauses. Timeline முழுவதும் கற்பனை training model.

அத்தியாயம் 06

Medical Underwriting Company என்ன பார்க்கிறது

Medical Underwriting



மருத்துவ விளக்கமும் காப்பீட்டு மதிப்பீடும் தனித்தனி பொறுப்புகள். AI உருவாக்கிய காட்சி.

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Medical details கேட்டால் சில customers தயங்கலாம். ஏன் கேட்கிறோம் என்பதை முதலில் விளக்கணும். Diabetes, BP, thyroid, asthma, heart/kidney problems, cancer history, surgery, BMI பற்றி சரியான தகவல் பெறுவதை இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். Company ஏற்கலாம், கூடுதல் premium அல்லது conditions சொல்லலாம், ஒத்திவைக்கலாம், மறுக்கலாம். முடிவு வரும்முன் நாம உறுதி தரக்கூடாது.

6.1 Underwriting என்பது என்ன

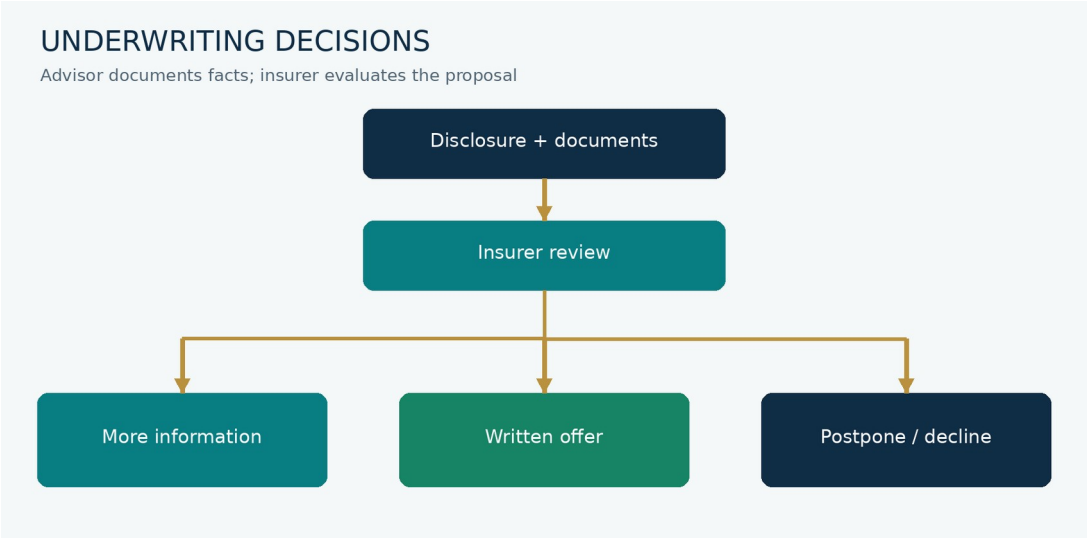
Underwriting என்றால், customer கொடுத்த medical மற்றும் risk details-ஐப் பார்த்து “இந்த policy கொடுக்கலாமா? எந்த conditions-ல் கொடுக்கலாம்?” என்று insurer முடிவு செய்யும் வேலை. “நான் நல்லாத்தான் இருக்கேன்” என்ற customer கருத்தும் insurer acceptance-உம் ஒன்றல்ல. அதேபோல் report-ல் ஒரு value மாறியதால் உடனே reject ஆகும் என்றும் முடிவு செய்ய முடியாது.

Advisor-ன் வேலை diagnosis செய்வதோ underwriting முடிவு சொல்வதோ இல்லை. தகவலைச் சரியாகப் பதிவு செய்யணும், documents ஒழுங்குபடுத்தணும், company கேட்கும் clarification வாங்கணும். பிறகு எழுத்தில் வரும் முடிவை customer-க்கு

புரியும்படி விளக்கணும். “Acceptance உறுதி”, “Claim கண்டிப்பா கிடைக்கும்” என்று சொல்லக் கூடாது.

சிம்பிளாகச் சொன்னால்

“நீங்க தரும் medical details-ஐ company பார்த்து, எந்த conditions-ல் policy கொடுக்கலாம் என்று சொல்லும். எல்லா details-உம் சரியாகப் பதிவு செய்யவும், முடிவு வந்ததும் புரியும்படி விளக்கவும் நான் உதவுறேன்.”



படம் 6.1 • தகவல் பெறுதல் முதல் underwriting முடிவு வரை.

6.2 Disclosure பெறும் முறை

Medical questions-ஐ customer புரிந்துகொள்ளும் மொழியில் கேளுங்க. ஒரு நீளமான கேள்வியைப் பகுதிகளாகப் பிரித்து விளக்கலாம்; அர்த்தத்தை மாற்றக் கூடாது. “இது இருந்தாலும் problem இல்லை” என்று சொல்லி பதிலை வழிநடத்த வேண்டாம். Customer சொன்னது, report-ல் இருப்பது, insurer கேட்ட clarification ஆகியவற்றைத் தனியாகப் பதிவு செய்யுங்க.

Diagnosis date தெரியவில்லையா? ஒரு தேதியை ஊகித்து நிரப்பாதீங்க. Prescription அல்லது discharge summary மூலம் கண்டுபிடிக்க முயலுங்க. Approximate date மட்டுமே தெரிந்தால் அதையே தெளிவாகச் சொல்லி insurer guidance வாங்குங்க. Online form mandatory field என்பதற்காக தவறான date போடக் கூடாது.

Signature அல்லது OTP கொடுப்பதற்கு முன் customer எதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறார் என்று தெரிந்திருக்கணும். “சும்மா formalities” என்று சொல்லாதீங்க. Submit செய்வதற்கு முன் medical answers-ஐ அவருடன் ஒரு முறை படித்துப் பாருங்க. பல தவறுகளை அப்போதே சரிசெய்யலாம்.

6.3 Diabetes மற்றும் Blood Pressure

Diabetes எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, எவ்வளவு காலமாக treatment, என்ன medicines, என்ன reports, ஏதேனும் complications இருக்கிறதா என்று கேட்க வேண்டியிருக்கலாம். HbA1c report இருந்தால் copy வாங்கலாம். அதன் value மட்டும் வைத்து advisor eligibility முடிவு சொல்லக் கூடாது. Insulin பயன்பாடு, பழைய hospital admission போன்றவற்றையும் மறைக்காமல் பதிவு செய்யணும்.

BP-க்கும் diagnosis, regular medicines, follow-up, தொடர்புடைய health conditions பற்றி கேளுங்க. “Tablet எடுத்ததால் normal” என்றால் BP history இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை. Diabetes-உம் BP-யும் இருந்தால் இரண்டையும் தெளிவாகப் பதிவு செய்யணும்.

ரவி 46 வயது; நான்கு வருடமாக diabetes medicine எடுக்கிறார் என்று வைத்துக்கலாம். “Medical test-ல் கண்டுபிடிச்சுக்குவாங்க” என்று proposal-ல் No போட முடியாது. Test செய்வது disclosure-க்கு மாற்று இல்லை. Customer சொன்ன history, reports, company கேட்ட details எல்லாம் சரியாகப் பொருந்தணும்.

6.4 Thyroid மற்றும் Asthma

“Thyroid இருக்கு” என்றால் அதோடு நிறுத்த வேண்டாம். என்ன diagnosis, எந்த medicine, எப்போதிலிருந்து treatment, follow-up எப்படி என்று கேளுங்க. “சாதாரண thyroid” என்று குறிப்பு போட்டுவிட்டு medical question-ஐ விட்டுவிடாதீங்க. Surgery அல்லது investigations இருந்தால் அவையும் பதிவு செய்யணும்.

Asthma-க்கு inhaler, அடிக்கடி வரும் episodes, emergency treatment, hospital admission, doctor notes போன்றவை முக்கியமாக இருக்கலாம். குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்தது; இப்போது இல்லை என்றாலும் proposal கேட்கும் காலத்துக்கான history பெறணும். இப்போது inhaler பயன்படுத்தவில்லை என்பதால் history இல்லை என்று நாம முடிவு செய்யக் கூடாது.

இந்த details insurance assessment-க்காக. Medicine நிறுத்திவிட்டு test எடுக்கச் சொல்வதற்காக இல்லை. Readings மாற்றுவது, report மறைப்பது, treatment-ஐ மாற்றச் சொல்வது தவறு. Tests-ஐ doctor அல்லது authorised process கொடுக்கும் instructions-படி செய்யணும்.

6.5 Heart Disease மற்றும் Kidney Disease

Heart disease என்றால் exact diagnosis, admission, procedure, இப்போதைய treatment, follow-up reports கேட்கப்படலாம். Angioplasty, bypass, valve surgery நடந்திருந்தால் தெளிவாகப் பதிவு செய்யணும். “இப்போ நல்லா இருக்கார்” என்று மட்டும் சொல்வது இந்த history-க்கு மாற்றாகாது.

Kidney problem-க்கும் diagnosis, tests, admission, procedure, current follow-up விவரங்கள் தேவை. ஒரு பழைய scan பார்த்து “சரியாகிவிட்டது” என்று advisor

முடிவு சொல்ல வேண்டாம். Company கூடுதல் opinion அல்லது tests கேட்கலாம். இதை முன்பே சொன்னால் தாமதம் ஏன் வருகிறது என்று customer-க்கு புரியும்.

பெரிய medical history இருந்தால் “எந்த company-யும் தராது” என்று சொல்லாதீங்க. பொருத்தமான product, eligibility, underwriting வழியை அதிகாரப்பூர்வமாகப் பார்க்கணும். அதேபோல் “கண்டிப்பா வாங்கித் தர்றேன்” என்பதும் தவறு. ஏற்கும் முடிவு insurer-டம்தான் இருக்கிறது.

6.6 Cancer வரலாறு மற்றும் முந்தைய அறுவைசிகிச்சை

Cancer history இருந்தால் diagnosis, treatment dates, surgery, chemotherapy/radiotherapy, follow-up, discharge records தேவைப்படலாம். Customer “remission-ல் இருக்கேன்” என்று சொன்னால் அதைப் பதிவு செய்து supporting documents வாங்குங்க. அந்த மருத்துவ நிலையை advisor தானாக உறுதி செய்யக் கூடாது.

பழைய surgery என்றால் பெரிய operation மட்டும் கேட்க வேண்டாம். Proposal கேட்கும் scope-ல் வரும் procedures, admissions அனைத்தையும் பதிவு செய்யணும். Operation நல்லபடியாக முடிந்திருந்தாலும், அது ஏன் செய்யப்பட்டது என்பது underwriting-க்கு முக்கியமாக இருக்கலாம்.

Document தொலைந்துவிட்டால் hospital-ல் duplicate கிடைக்குமா என்று உதவுங்க. கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக report உருவாக்கவோ தேதியை மாற்றவோ கூடாது. உள்ள உண்மையான தகவலை insurer-க்கு சொல்லி, மாற்றாக என்ன document தரலாம் என்று கேளுங்க.

6.7 BMI மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள்

BMI என்பது எடை, உயரம் வைத்து வரும் ஒரு கணக்கு: எடை kg-ல் ÷ உயரம் metre-ல்². அது ஒருவரின் முழு உடல்நலத் தீர்ப்பு இல்லை. Company பயன்படுத்தும் limits product மற்றும் underwriting criteria-க்கு மாறலாம். நினைவில் இருக்கும் ஒரு எண்ணை எல்லாருக்கும் பொருந்தும் rule போலச் சொல்லாதீங்க.

கணக்கு: எடை 80 kg, உயரம் 1.70 m எனில் 80 ÷ (1.70 × 1.70) ≈ 27.7. இது கணிதப் பயிற்சி மட்டும். இந்த BMI-க்கு குறிப்பிட்ட loading அல்லது decline அவசியம் என்று இந்நூல் கூறவில்லை. உயரம் 170 cm என்பதை 170 m என்று உள்ளிடுவது போன்ற data-entry தவறுகள் Quote மற்றும் underwriting-ஐ பாதிக்கலாம்.

எல்லாருக்கும் ஒரே medical tests இருக்காது. வயது, SI, medical answers, underwriting request ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறலாம். Test cost, appointment, fasting instructions, report submission அனைத்தையும் authorised communication-ல் உறுதி செய்யுங்க. Test முடிந்தது என்பதால் policy accepted என்று அர்த்தம் இல்லை.

6.8 சாத்தியமான முடிவுகள்

முடிவு	பொருள்	ஆலோசகர் அடுத்த செயல்
Standard acceptance	வழக்கமான நிபந்தனைகளில் offer	issued schedule சரிபார்த்தல்
Additional premium அல்லது loading	கூடுதல் premium உடன் offer	காரணம், தொகை, ஒப்புதல் விளக்குதல்
திட்டம் அனுமதிக்கும் special நிபந்தனைகள்	மாற்றப்பட்ட நிபந்தனைகள்	wording மற்றும் endorsement ஆய்வு
More தகவல்	முடிவுக்கு கூடுதல் ஆவணம் தேவை	exact requirement பெறுதல்
Postponement	பின்னர் மறுபரிசீலனை	reason மற்றும் review நிபந்தனை பதிவு
Decline	தற்போதைய proposal ஏற்கப்படவில்லை	எழுத்தில் உள்ள முடிவு மற்றும் விருப்பங்கள் விளக்குதல்

Company விருப்பப்படி எல்லா plans-லும் எந்த exclusion வேண்டுமானாலும் சேர்க்கலாம் என்று நினைக்காதீங்க. Approved product-உம் பொருந்தும் விதிகளும் அனுமதிக்கும் conditions-தான் பொருந்தும். Customer-க்கு வந்த actual written offer-ஐப் பார்த்து விளக்கணும்.

6.9 ஒரு underwriting case

கற்பனை Customer சுமதி, 42 வயது, thyroid சிகிச்சை மற்றும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் அறுவைசிகிச்சை வரலாறு. ஆலோசகர் முதலில் proposal மருத்துவக் கேள்விகளைப் படித்து வரலாற்றைப் பதிவு செய்கிறார். தற்போதைய prescription, discharge summary மற்றும் Follow-up note கிடைக்கின்றன. ஒரு அறிக்கை மட்டும் இல்லை; அந்த gap பணிக் குறிப்பில் பதிவாகிறது.

Insurer clarification கேட்டபின் சுமதி Hospital-யிலிருந்து record பெறுகிறார். Underwriting offer additional premium-உடன் வருகிறது என்று கற்பனை செய்வோம். ஆலோசகர் பழைய indicative Quote-ஐ இறுதிக் கட்டணம் என்று வாதிடாமல், புதிய எழுத்தில் உள்ளச் சலுகை, நிபந்தனைகள் மற்றும் payment instructions-ஐ விளக்குகிறார். சுமதி நிபந்தனைகளைப் புரிந்து ஏற்கிறாரா என்பது பதிவாக வேண்டும்.

இந்த case-ல் “ஆலோசகர் சரியாகப் பேசினார்; அதனால் Claim உறுதி” என்பது பாடமல்ல. உண்மையான தகவல், ஆவணப் பதிவு மற்றும் informed முடிவு ஆகியவை செயல்முறையின் தரத்தை மேம்படுத்துகின்றன என்பதே பாடம். எதிர்கால Claim அதன் மருத்துவ உண்மைகள் மற்றும் Policy நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப மதிப்பிடப்படும்.

6.10 Customer-கிட்ட இப்படிப் பேசலாம்

Customer: “இதைச் சொன்னால் premium அதிகமாகிவிடுமே?”

Advisor: “நிறுவனம் உங்க உண்மையான தகவலை வைத்து நிபந்தனைகள் முடிவு செய்யணும். குறைந்த premium பெறுவதற்காக வரலாறு மறைப்பது சரியான வழி அல்ல. கிடைக்கும் offer-ஐப் பார்த்து உங்க செலவுத் திட்டத்துக்கு ஏற்றதா என்று முடிவெடுக்கலாம்.”

Customer: “Test எடுத்துட்டாங்க; அப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்.”

Advisor: “பரிசோதனைகள் நடந்தாலும் proposal-ல் கேட்ட வரலாற்றை முழுமையாகச் சொல்ல வேண்டும். எல்லா பழைய Diagnosis அல்லது சிகிச்சையும் ஒரு test-ல் தெரியாது. உங்க பதில்களும் அறிக்கைகளும் சரியாக இருக்கணும்.”

Customer: “Policy கிடைக்குமா இல்லையா இப்பவே சொல்லுங்க.”

Advisor: “நான் acceptance உறுதி தர முடியாது. தேவையான தகவல்களைச் சரியாகச் சமர்ப்பித்து Insurer-ன் முடிவைப் பெற உதவுகிறேன். முடிவு வந்ததும் நிபந்தனைகளை ஒன்றாகப் பார்ப்போம்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

மருத்துவ question-க்கு ஆலோசகர் தானாக No நிரப்புதல், Customer-ன் medicine-ஐ “minor” என்று தவிர்த்தல், test result-ஐப் பார்த்து மருத்துவ Diagnosis கொடுத்தல், loading-ஐ மறைத்து payment link அனுப்புதல் மற்றும் decline-க்கு காரணம் ஊகித்துக் சொல்வது ஆகியவை தவறுகள். Underwriting-க்கு முன் பணம் செலுத்தியதாலேயே risk commencement உறுதியாகிவிட்டது என்று கருதக்கூடாது; உண்மையான acceptance மற்றும் schedule பார்க்கணும்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Underwriting-ல் ஆலோசகரின் மதிப்பு சரியான தகவல், ஆவண ஒழுங்கு மற்றும் தெளிவான விளக்கத்தில் உள்ளது. மருத்துவ நோயறிதலும் Insurer acceptance-மும் அவரின் முடிவுகள் அல்ல. Customer disclosure, கிடைக்கும் evidence, நிலுவை தேவைகள் மற்றும் இறுதி எழுத்தில் உள்ள நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாக நிர்வகிக்க வேண்டும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. Controlled diabetes இருந்தால் proposal-ல் No என்று பதிலிடலாமா?

2. Diagnosis தேதி தெரியாதபோது என்ன செய்வீங்க?

3. 72 kg, 1.60 m என்றால் BMI என்ன? அதிலிருந்து Policy acceptance முடிவு செய்யலாமா?

4. Indicative விலை விவரத்துக்கு பிறகு loading வந்தால் Customer-க்கு எப்படி விளக்குவீங்க?

5. மருத்துவப் பரிசோதனை disclosure-க்கு ஏன் மாற்றாகாது?

6. Missing அறிக்கைக்கு அனுமதிக்கத்தக்க இரண்டு அடுத்த நடவடிக்கைகளை எழுதுங்க.

பதில் சரியா பார்ப்போம்

1: கூடாது; proposal scope-க்கு ஏற்ப உண்மையான வரலாறு தெரிவிக்கணும். 2: கிடைக்கும் records மூலம் உறுதி செய்து, uncertainty-ஐ Insurer-க்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். 3: சுமார் 28.1; அதிலிருந்து acceptance முடிவு செய்ய முடியாது. 4: எழுத்தில் உள்ளச் சலுகை, கூடுதல் தொகை, நிபந்தனைகள் மற்றும் Customer ஒப்புதல். 5: பரிசோதனைகள் எல்லா கடந்த வரலாற்றையும் காட்டாது. 6: Hospital duplicate கேட்பது; Insurer-க்கு gap தெரிவித்து alternative requirement கேட்பது.

Advisor Checklist

• மருத்துவ பதில்கள் Customer-உடன் மீண்டும் வாசிக்கப்பட்டதா?

• Diagnosis, மருந்துகள், அறுவைசிகிச்சை மற்றும் நிலுவைப் பரிசோதனைகள் பதிவாகியுள்ளனவா?

• தெரியாத தகவலை ஊகித்து நிரப்பவில்லையா?

• மருத்துவ ஆலோசனை வழங்காமல் என் பங்குக்குள் செயல்பட்டேனா?

• அறிக்கை பகிர்வதற்கு ஒப்புதல் மற்றும் அணுகல் கட்டுப்பாடு உள்ளதா?

• எழுத்தில் உள்ள underwriting offer முழுமையாக விளக்கப்பட்டதா?

• Customer acceptance மற்றும் இறுதி Policy நிபந்தனைகள் பொருந்துகின்றனவா?

• அனைத்து நிலுவை தேவைகளுக்கும் பொறுப்பாளரும் தேதியும் உள்ளதா?

ஆதாரம்: P01 முதல் P04 disclosure மற்றும் பொதுவான நிபந்தனைகள்; underwriting-க்கான நடைமுறை உதாரணங்கள் ஆசிரியர் உருவாக்கியவை. இங்கு மருத்துவ thresholds அல்லது Insurer-ன் உள் ஏற்றுக்கொள்ளல் அளவுகோல்கள் உருவாக்கப்படவில்லை.

அத்தியாயம் 07

நான்கு Star Health Plans எப்படி ஒப்பிடுவது

Star Health Product Mastery

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் நான்கு தயாரிப்புகளின் முக்கிய வேறுபாடுகளை ஆதாரத்துடன் விளக்கவும், அடிப்படைப் பாதுகாப்பையும் விருப்பக் கூடுதல் பாதுகாப்பையும் பிரிக்கவும், பொருத்தமான திட்டத்திற்கான காரணத்தை எழுதவும் முடியும். தயாரிப்பின் பெயரை நினைவில் வைத்திருப்பதைவிட அதன் தற்போதைய பதிப்பை அடையாளம் காண்பதே முதல் திறன்.

முதலில் சரியான ஆவணத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

Product name தெரிந்தால் மட்டும் போதாது. ஒரே பெயரில் version மாறியிருக்கலாம். முதலில் UIN, policy wording, brochure, CIS, schedule ஆகியவை ஒரே version-ஐச் சேர்ந்தவையா என்று பாருங்க. இங்கே பழைய ஆய்வில் பயன்படுத்திய ஆவணங்களின் அடிப்படையில்தான் ஒப்பீடு இருக்கு; புதிய quote கொடுக்கும் முன் applicable version-ஐ மீண்டும் உறுதி செய்யணும்.

தயாரிப்பு	பயன்படுத்திய **UIN**
Super Star	SHAHLIP27049V022627
Star Comprehensive	SHAHLIP26044V092526
Star Health Assure	SHAHLIP26048V032526
Star Women Care	SHAHLIP23132V022223

Brochure-ல் features சீக்கிரம் தெரியும்; CIS-ல் முக்கிய limits சுருக்கமாக இருக்கும். Claim பற்றி புரிஞ்சுக்க full wording, schedule, endorsements சேர்த்துப் படிக்கணும். இரண்டு documents வேறுபட்டால் நமக்கு சாதகமானதை நாமே தேர்வு செய்யாதீங்க. Insurer-டம் written clarification வாங்குங்க.

சிம்பிளாக தயாரிப்பு ஒப்பீடு

“எது best?” என்று ஆரம்பிப்பதற்கு பதிலாக “யாருக்காகப் பார்க்கிறோம்?” என்று ஆரம்பிக்கலாம். இளம் குடும்பம், பெற்றோர், maternity planning, ஏற்கெனவே நோய்

உள்ளவர் எனத் தேவை மாறும். அதற்கு ஏற்ற entry age, room, waiting, co-pay, limits, options ஆகியவற்றை ஒப்பிடணும்.

நுழைவுத் தகுதி மற்றும் குடும்ப அமைப்பு

தயாரிப்பு	முக்கிய நுழைவுத் தகுதி	ஆலோசகர் கவனம்
Super Star	பெரியவர் 18 வயதிலிருந்து; அதிகபட்ச நுழைவு வயது வரம்பின்றி. குழந்தை பொதுவாக 91 நாள் முதல் 25 வயது	Floater-இல் அதிகபட்சம் 2 பெரியவர்கள், 4 குழந்தைகள்; உறவு மற்றும் சார்புநிலை விதிகளைப் பாருங்க
Comprehensive	பெரியவர் 18–65; சார்ந்த குழந்தை 91 நாள்–25 வயது	குழந்தை மற்றும் குடும்ப இணைப்பு விதிகளை முன்மொழிவில் உறுதிசெய்யவும்
Health Assure	பெரியவர் 18–75; Floater குழந்தை 16 நாள் முதல்; Individual குழந்தை 91 நாள் முதல்	பெற்றோர், மாமனார்/மாமியார் உள்ளிட்ட விரிவான குடும்ப அமைப்பு; அதிகபட்சம் 6 பெரியவர்கள், 3 குழந்தைகள்; உறவுத் தகுதி பொருந்தும்
Women Care	Individual பெண்களுக்கு 18 –75; Floater பெரியவர் 18–75	Floater-இல் குறைந்தது ஒரு வயது வந்த பெண் அவசியம்; பெண் குழந்தை மட்டும் இந்த நிபந்தனையை நிறைவேற்றாது

Entry age என்பது புதிதாக வாங்கும் eligibility. அதே வயதில் renewal right முடியும் என்று அர்த்தம் இல்லை. Underwriting, acceptance, SI options, dependent child வயது விதி எல்லாம் தனித்தனியாகப் பார்க்கணும். Maximum entry age இல்லை என்றாலும் எல்லா applications-உம் automatic acceptance இல்லை.

அறை அனுமதி: சிறிய வரி, பெரிய விளைவு

தயாரிப்பு / தொகை	அறை தொடர்பான அடிப்படை விதி
Super Star	அடிப்படையில் Any Room; Room Rent Modification விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால் அது மாறும்
Comprehensive	Single Private A/C Room
Health Assure ₹5 / ₹7.5 லட்சம்	நாளொன்றுக்கு Sum Insured-இன் 1% வரை
Health Assure ₹10 / ₹15 / ₹20 / ₹25 லட்சம்	Suite மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வகைகளைத் தவிர Any Room
Health Assure ₹50 / ₹75 / ₹100 / ₹200 லட்சம்	Any Room
Women Care ₹5 லட்சம்	நாளொன்றுக்கு Sum Insured-இன் 1% வரை
Women Care ₹10–₹25 லட்சம்	Suite மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வகைகளைத் தவிர Any Room
Women Care ₹50 / ₹100 லட்சம்	Any Room

கற்பனைக் கணக்கு: ₹5 லட்சம் SI-ன் 1% என்றால் room limit தினம் ₹5,000. Customer ₹8,000 room எடுத்தால் difference மட்டும் கட்டினால் போதுமா? முன்பே அப்படிச் சொல்லாதீங்க. Associated charges-ல் proportionate deduction இருக்கா, exceptions என்ன என்று wording பார்க்கணும். ICU rule-ஐ சாதாரண room rule-உடன் குழப்ப வேண்டாம்.

Super Star: தேர்வுகளின் பயனும் பொறுப்பும்

Super Star-ல் hospital admission-க்கு முன் 90 நாட்கள், பின் 180 நாட்களுக்கான தொடர்புடைய admissible செலவுகள் உள்ளன என்று பயன்படுத்திய ஆவணம் சொல்கிறது. அந்த நாட்களுக்குள் வரும் எல்லாச் செலவும் தானாகக் கிடைக்காது. ஏற்கப்படும் treatment-உடன் தொடர்பும் மற்ற conditions-உம் இருக்கணும்.

Base Cumulative Bonus claim இல்லாத ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் SI-ன் 50%; அதிகபட்சம் 100%. Restoration பலமுறை என்றாலும் எப்போது பயன்படுத்தலாம், அடுத்த admission-க்கா, ஒரு claim limit என்ன என்பதைக் கண்டிப்பாகப் பார்க்கணும். “Unlimited” என்ற வார்த்தையை ஒரு treatment-க்கு unlimited money என்று விளக்காதீங்க.

Freeze Your Age என்றால் premium எப்போதுமே உயராது என்று அர்த்தம் இல்லை. Premium calculation-ல் வயதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறது, claim வந்தால் என்ன ஆகும், 55 வயது சார்ந்த limit, product rate revision ஆகியவற்றைப் பிரித்துப் பார்க்கணும். பெயரை மட்டும் மொழிபெயர்க்காமல் அந்த clause-உம் actual quote-உம் வைத்து விளக்குங்க.

Quick Shield: எல்லா நோய்களுக்கும் உடனடி பாதுகாப்பு அல்ல

Quick Shield ஒரு optional cover. அதைத் தேர்ந்தெடுத்து insurer ஏற்றிருந்தால், குறிப்பிடப்பட்ட PED-களுக்கான waiting waiver மூலம் முதல் வாங்குதலின் 31-வது நாளிலிருந்து குறிப்பிட்ட In-patient / Day Care cover அமையலாம். பட்டியலில் Diabetes, Hypertension, Asthma, Hyperlipidemia, குறிப்பிட்ட definition-க்கு உட்பட்ட “Coronary Artery Disease with PTCA done prior to one year” உள்ளன. நோயின் பெயர் மட்டும் வைத்து eligibility உறுதி செய்யாதீங்க.

இதற்கும் முழு medical disclosure அவசியம். எல்லா heart problems, complications, OPD செலவுகளும் Quick Shield-ல் வந்துவிடாது. இந்த option-ன் premium ஐந்து ஆண்டுகளுக்குச் சேகரிக்கப்படும்; அதற்குள் admissible claim வந்தால் மீதமுள்ள option premium-ஐ claim-லிருந்து கழிக்கும் விதியும் இருக்கு. இந்தப் பணக் கணக்கையும் வாங்குவதற்கு முன்பே customer-க்கு சொல்லணும். [P01, Optional Covers, Quick Shield]

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

விருப்பம்	விளக்க வேண்டிய பொருள்
PED Waiting Period Reduction	அடிப்படை 36 மாதத்தை 24 அல்லது 12 மாதமாகக் குறைக்கும் தேர்வு; தகுதி மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளல் பொருந்தும்
Specified Disease Waiting Reduction	24 மாதத்திலிருந்து 12 மாதம்; இது PED விதியைத் தானாக நீக்காது
Voluntary Co-payment	குறைந்த கட்டணத்திற்குப் பதிலாகக் Claim-ல் Customer சொந்தச் செலவுப் பங்கு ஏற்கிறார்
Voluntary Deductible	குறிப்பிட்ட முதல் செலவை Customer ஏற்கும் அமைப்பு; Co-payment தேர்வுடன் சேர்க்க இயலாத விதியைச் சரிபாருங்க

விருப்பம்	விளக்க வேண்டிய பொருள்
Room Rent Modification	Room eligibility-யைக் குறைக்கும் தேர்வு; Hospital விருப்பத்துடன் பொருத்திப் பாருங்க
Consumables	குறிப்பிடப்பட்ட பட்டியலுக்கான பாதுகாப்பு; எல்லா non-medical செலவுகளுக்கும் எல்லையற்ற ஒப்புதல் அல்ல
Maternity / ART	தனித்தனி விருப்பங்கள்; Waiting, தொகை வரம்பு, வாழ்நாள் பயன்பாட்டு வரம்பு பொருந்தும்

Quote ஒப்பிடும்போது எந்த options சேர்த்திருக்கிறோம், ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன premium என்று எழுதுங்க. குறைவான quote base plan-க்கா, co-pay போன்ற condition சேர்த்த plan-க்கா என்று தெரியாமல் “இது cheap” என்று சொல்ல வேண்டாம்.

Comprehensive: பொதுப் பாதுகாப்புடன் வரம்புகளைப் படித்தல்

Comprehensive-ல் pre-hospitalisation 60 நாட்கள், post-hospitalisation 90 நாட்கள் தொடர்புடைய செலவுகள் உள்ளன. Single Private A/C Room eligibility முக்கியம். Base SI-யும் சேர்ந்த Cumulative Bonus-உம் முடிந்த பிறகு 100% restoration ஒருமுறை என்ற விதி இருக்கு; அது அடுத்த admission தொடர்பான conditions-க்கு உட்பட்டது. இதை மற்ற plans-ன் multiple restoration-உடன் ஒரே மாதிரி சொல்லாதீங்க. [P02, Section II, Automatic Restoration]

61 வயது அல்லது அதற்கு மேல் புதிதாகச் சேருபவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட cover பிரிவுகளின் admissible claims-ல் 10% co-pay விதி இருக்கு. முன்பே சேர்ந்து தொடர்ந்து renew செய்பவருக்கும் அதே விதிதான் என்று எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. Entry age, history, schedule பார்க்கணும். Co-pay என்பது hospital discount இல்லை; customer ஏற்கும் செலவுப் பங்கு.

மகப்பேறு: தம்பதியர் தொடர்ச்சியும் Sub-limit-ம்

Comprehensive Delivery Expenses clause-ல் தம்பதியர் இருவருக்கும் 24 மாத continuous cover குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு delivery claim-க்குப் பிறகு அடுத்த claim-க்கும் மீண்டும் 24 மாத waiting குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வாழ்நாளில் அதிகபட்சம் இரண்டு deliveries என்ற limit-உம் இருக்கு. Customer-க்கு வழங்கிய UIN, schedule,

wording-ஐ ஒப்பிட்டு உறுதி செய்யுங்க. Documents முரண்பட்டால் insurer-டம் எழுத்தில் clarification வாங்கணும்.

Sum Insured	சாதாரண பிரசவ வரம்பு	Caesarean வரம்பு
₹5 லட்சம்	₹15,000	₹20,000
₹7.5 லட்சம்	₹25,000	₹40,000
₹10–₹25 லட்சம்	₹30,000	₹50,000
₹50–₹100 லட்சம்	₹50,000	₹1 லட்சம்

கீழே உள்ள table delivery sub-limit-ஐ மட்டும்தான் காட்டுகிறது. Hospital delivery bill அதைவிட அதிகமாக இருக்கலாம். Newborn செலவு, vaccination, மற்ற benefits-க்கு தனி conditions இருக்கும். Maternity claim-க்கு பொதுவான pre/post hospitalisation benefits எல்லாம் கூடுதலாக வரும் என்று நினைக்காதீங்க. [P02, Section II, Delivery Expenses]

Health Assure: விரிவான குடும்பத் தேவையை மதிப்பிடுதல்

Health Assure-ல் பெற்றோர் உள்ளிட்ட பெரிய குடும்ப அமைப்பைப் பரிசீலிக்கலாம். ஆனால் எல்லோரும் ஒரே SI-ஐப் பகிர்ந்தால் அந்தத் தொகை போதுமா என்பதையும் பார்க்கணும். Parents தனி cover, தனி family floater, இந்த விரிவான floater என options ஒப்பிட்டுதான் முடிவு செய்யணும்.

Pre-hospitalisation 60 நாட்கள்; post-hospitalisation 180 நாட்கள். Claim இல்லாத ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் Cumulative Bonus 25%; அதிகபட்சம் 100%. Multiple restoration உள்ளது. ஒரு பகுதி பயன்படுத்தினால் பயன்படுத்திய அளவு, முழுவதும் பயன்படுத்தினால் 100% என செயல்படும் conditions இருக்கின்றன. ஒரு claim-க்கே மீண்டும் மீண்டும் restore செய்து unlimited amount பெறலாம் என்று சொல்லக் கூடாது. [P03, Section II, Cumulative Bonus; Automatic Restoration]

Health Assure-ல் policy term கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். பயன்படுத்திய wording-ல் 3-year policy-க்கு PED waiting 30 மாதங்கள்; 1-year அல்லது 2-year policy-க்கு 36 மாதங்கள். அதனால “Health Assure என்றாலே 30 months” என்றோ “எல்லாத்துக்கும் 36 months” என்றோ சொல்லாதீங்க. Comparison-ல் policy term-ஐ தனியாகக் காட்டுங்க.

Delivery Expenses-ல் SI-ன் 10% வரை, 24 மாத continuous cover, தம்பதியர் condition, அதிகபட்சம் இரண்டு deliveries என்ற விதிகள் உள்ளன. Admissible முதல் delivery-க்குப் பிறகு அடுத்த delivery-க்கு புதிய waiting இல்லை என்ற விதி Comprehensive-

லிருந்து வேறுபடுகிறது. இதை எல்லா plans-க்கும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தாதீங்க. Entry age 61 மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கான 10% co-pay-யும் பார்க்கணும். [P03, Delivery Expenses; Co-payment]

Health Assure-ல் ₹50,000 அல்லது ₹1 லட்சம் annual aggregate deductible தேர்வு செய்து premium concession பெறும் option இருக்கு. Premium குறைகிறது; அதற்குப் பதிலாக deductible அளவுக்கான முதல் admissible செலவை customer சமாளிக்கணும். இது ஒவ்வொரு policy year-க்கும் பொருந்தும். இந்தப் பொறுப்பை மறைக்காமல் விளக்குங்க. [P03 Brochure, Optional Cover to choose deductible]

Women Care: பெண்களின் தேவையை விரிவாகப் புரிஞ்சுக்குதல்

Women Care-ஐ “Delivery plan” என்று மட்டும் சொல்லிவிட வேண்டாம். பொதுவான hospital cover-உடன் பெண்கள், குழந்தைகள் தொடர்பான குறிப்பிட்ட benefits உள்ளன. அதே நேரத்தில் பெண்களுக்கான எல்லா treatment-மும் முழுவதும் cover என்று சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு benefit-க்கும் limit, condition பார்க்கணும்.

Pre-hospitalisation 60 நாட்கள்; post-hospitalisation 90 நாட்கள். Claim-free வருடத்துக்கு Cumulative Bonus 20%; அதிகபட்சம் 100%. 100% restoration ஒருமுறை. Base PED waiting, specified disease waiting தலா 24 மாதங்கள்; initial waiting 30 நாட்கள். Accident rule-உம் special sections-ன் exceptions-உம் தனியாகப் பொருந்தும்.

Sum Insured	பிரசவச் செலவு அதிகபட்சம்	பிரசவக் Waiting
₹5 லட்சம்	₹25,000	24 மாதங்கள்
₹10 லட்சம்	₹50,000	24 மாதங்கள்
₹15 / ₹20 லட்சம்	₹50,000	12 மாதங்கள்
₹25 / ₹50 லட்சம்	₹75,000	12 மாதங்கள்
₹100 லட்சம்	₹1 லட்சம்	12 மாதங்கள்

வாழ்நாளில் அதிகபட்சம் இரண்டு deliveries என்ற limit-உம் இருக்கு. Newborn cover, அடுத்த வருடம் குழந்தையைச் சேர்ப்பது, vaccination, மற்ற benefits ஆகியவற்றை delivery limit-உடன் ஒன்றாகக் கலக்காமல் தனியாக விளக்கணும். [P04, Section II, 24–25]

Surrogate Mother, Oocyte Donor cover-க்கு சட்டமும் குறிப்பிட்ட eligibility-யும் பொருந்தும். எல்லா fertility treatments-க்கும் முழுப் பணம் கிடைக்கும் என்று

அர்த்தம் இல்லை. வயது, registered centre, proposer, medical evidence போன்ற conditions முக்கியம். ஒரு special section-க்கு மட்டும் உள்ள waiting waiver-ஐ முழு policy-க்கும் பொருத்தாதீங்க.

Optional Cancer Benefit-க்கு extra premium வேண்டும். Schedule-ல் பெயரிடப்பட்ட பெண் உறுப்பினரின் தகுதியான முதல் cancer நிகழ்வுக்கான fixed benefit இது. வயது 91 நாட்கள் முதல் 65 வரை; individual amount options ₹5, ₹10, ₹15, ₹20, ₹25 லட்சம்; initial waiting 180 நாட்கள். முதல் சேர்க்கையிலேயே தேர்வு செய்யணும்; renewal-ல் புதிதாகச் சேர்க்க முடியாது. வாழ்நாளில் ஒருமுறை. Benefit கொடுத்தபின் இந்த option முடியும்; base policy அதன் rules-உடன் தொடரும். Cancer definition, exclusions பார்க்காமல் benefit உறுதி சொல்லாதீங்க. [P04, Section II.29]

ஒரே பார்வையில் Waiting-உம் Restoration-உம்

அம்சம்	Super Star	Comprehensive
தொடக்கக் Waiting	30 நாட்கள்	30 நாட்கள்
குறிப்பிட்ட நோய்கள்	24 மாதங்கள்; விருப்பக் குறைப்பு இருக்கலாம்	24 மாதங்கள்
அடிப்படை PED	36 மாதங்கள்; ஏற்றுக்கொண்ட விருப்பங்கள் மாறுபடுத்தலாம்	36 மாதங்கள்; விருப்பக் குறைப்பு தனியாக
Restoration-ன் அடிப்படை வேறுபாடு	பலமுறை; அடுத்த அனுமதி மற்றும் பிற விதிகள்	அடிப்படை + Bonus தீர்ந்தபின் ஒருமுறை

அம்சம்	Health Assure	Women Care
தொடக்கக் Waiting	30 நாட்கள்	30 நாட்கள்
குறிப்பிட்ட நோய்கள்	24 மாதங்கள்	24 மாதங்கள்

அம்சம்	Health Assure	Women Care
PED	3 ஆண்டு காலத்திற்கு 30 மாதம்; 1/2 ஆண்டுக்கு 36 மாதம்	24 மாதங்கள்
Restoration-ன் அடிப்படை வேறுபாடு	பலமுறை; அடுத்த அனுமதி விதிகள்	பகுதி / முழுப் பயன்பாட்டுக்குப் பின் ஒருமுறை

Table-ல் எண்கள் இருப்பதால் மட்டும் claim உறுதியாகிவிடாது. Medical history disclose செய்திருக்கணும்; insurer ஏற்றிருக்கணும்; exclusions, sub-limits தொடர்ந்து பொருந்தலாம். Accident-க்கு initial-wait exception இருந்தாலும் event policy period-க்குள் இருக்கணும்; மற்ற conditions-உம் பொருந்தும்.

நடைமுறை ஆலோசனைச் சூழல்கள்

இளம் தம்பதியர்: இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குழந்தைத் திட்டம், தனியார் Hospital விருப்பம், ₹2 லட்சம் மகப்பேறு செலவு மதிப்பீடு. முதலில் Hospital செலவையும் சேமிப்பையும் கேளுங்க. ₹50,000 பிரசவ வரம்புள்ள ஒரு தேர்வு முழுச் செலவையும் ஏற்காது. Waiting முடியும் தேதி, இருவரும் சேர வேண்டுமா, பிறந்த குழந்தையைச் சேர்க்கும் நடைமுறை ஆகியவற்றுடன் ஒப்பீடு அளியுங்கள். வாங்கினால் பிரசவம் முழுவதும் இலவசம் என்ற வாக்கியம் தவறு.

62 வயது புதிய விண்ணப்பதாரர்: மருத்துவ வரலாறு, தற்போதைய Policy, விரும்பும் Hospital, ஆண்டுக் கட்டணம் மற்றும் Claim-ல் செலுத்தக்கூடிய சொந்தப் பணம் ஆகியவற்றைக் கேளுங்க. நுழைவுத் தகுதி இருப்பது ஏற்றுக்கொள்ளல் உறுதி அல்ல. சொந்தச் செலவுப் பங்கு ₹4 லட்சம் ஏற்கத்தக்க Claim-ல் 10% எனில் ₹40,000; இதர Cover ஆகாத செலவுகள் கூடுதலாக இருக்கலாம். இந்தக் கணக்கு கற்பனையானது; குறிப்பிட்ட Customer-க்கான ஒப்புதல் அல்ல.

நீரிழிவு உள்ள 42 வயது Customer: Quick Shield பெயரைச் சொல்வதற்கு முன் நோய் கண்டறிந்த ஆண்டு, மருந்துகள், பரிசோதனைப் பதிவுகள் மற்றும் சிக்கல்களைச் சேகரிக்க அனுமதி வாங்குங்க. விருப்பத்தின் அங்கீகாரம், 31-வது நாள் விதி, கட்டண விளைவு மற்றும் பாதுகாப்பின் எல்லையை எழுத்தில் விளக்குங்க. OPD மருந்துகளும் தானாகக் கிடைக்கும் என்று Customer கருதுகிறாரா என்பதை மறுகேள்வி மூலம் உறுதி செய்யுங்க.

Customer-கிட்ட இப்படிப் பேசலாம்

Customer: “நான்கில் எது சிறந்தது?”

Advisor: “உங்க குடும்பம், medical history, room preference, budget எல்லாம் பார்த்துதான் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு பொருத்தமான இரண்டு options-ஐ ஒரே SI, ஒரே add-ons வைத்து ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம்.”

Customer: “Any Room என்றால் எல்லாச் செலவும் வருமா?”

Advisor: “Any Room என்பது room category பற்றிய benefit. Treatment eligible-ஆ, SI எவ்வளவு, exclusions அல்லது co-pay இருக்கா என்பதையும் பார்க்கணும். Room benefit மட்டும் எல்லாச் செலவுக்கும் approval இல்லை.”

Customer: “Brochure-ல் ஒரு மாதிரி, CIS-இல் வேறு மாதிரி இருக்கு.”

Advisor: “இதை guess பண்ண வேண்டாம். உங்க quote-ன் UIN வைத்து company-கிட்ட எழுத்தில் clarification வாங்குவோம். சரியான condition தெரிந்த பிறகு முடிவு செய்யலாம்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

பழைய விற்பனைப் படத்தை தற்போதைய Policy-யாகக் காட்டுதல்; Bonus-ஐ பணத் திருப்பமாகச் சொல்வது; Restoration-ஐ முதல் Claim-க்கான அளவற்ற தொகையாக விளக்குதல்; கூடுதல் பாதுகாப்பை அடிப்படை அம்சமாகக் காட்டுதல்; மகப்பேறு Sub-limit-ஐ மறைத்தல்; நுழைவு வயதையும் Renewal வயதையும் குழப்புதல் ஆகியவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். விலையைக் காட்டும் ஒவ்வொரு ஒப்பீட்டிலும் தேதி, குடும்ப விவரம், தொகை, Policy காலம் மற்றும் தேர்ந்தெடுத்த விருப்பங்கள் இருக்கணும். இந்நூலில் உண்மையான Premium Quotes தரப்படவில்லை.

கருத்துப்படம்: ஆவணத்திலிருந்து பரிந்துரைக்கு

படி	எழுத வேண்டிய முடிவு
1. பதிப்பு	UIN, ஆவண நாள், பொருந்தும் Schedule
2. தேவை	குடும்பம், மருத்துவ வரலாறு, அறை, Budget
3. வடிகட்டி	நுழைவுத் தகுதி, மதிப்பீடு, Waiting
4. ஒப்பீடு	தொகை, Sub-limit, சொந்தச் செலவுப் பங்கு, விருப்பங்கள்
5. உறுதி	முரண்பாடுகளுக்கான எழுத்தில் உள்ள பதில்
6. முடிவு	Customer புரிதல் மற்றும் தேர்வு பதிவு

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Product knowledge என்றால் benefits list மனப்பாடம் இல்லை. சரியான version எது, customer தேவைக்கு அது எப்படிப் பொருந்தும், என்ன limits இருக்கும் என்று விளக்கத் தெரியணும். இந்த நான்கு plans-லும் room, waiting, maternity, restoration rules ஒரே மாதிரி இல்லை என்பதை நினைவில் வையுங்க.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. Health Assure ₹7.5 லட்சம் திட்டத்தில் Room limit நாளொன்றுக்கு எவ்வளவு? 2. Quick Shield பற்றி “முதல் நாளிலிருந்து எல்லா நோய்களுக்கும் பாதுகாப்பு” என்பது ஏன் தவறு? 3. ஒரே Sum Insured-யில் மகப்பேறு வரம்புகள் ஏன் தனியாக ஒப்பிடப்பட வேண்டும்? 4. புதிய UIN ஆவணமும் பழைய Customer-ன் Policy-யும் மாறினால் எதைப் பார்க்கணும்? 5. Restoration மற்றும் அதிக Base Sum Insured இடையேயான வேறுபாட்டை விளக்குங்க.

பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. ₹7,500; தொடர்புடைய விதிகளும் பொருந்தும். 2. குறிப்பிட்ட நோய்கள், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விருப்பம், 31-வது நாள் மற்றும் சிகிச்சை வகை நிபந்தனைகள் உள்ளன. 3. மகப்பேறு தனி Sub-limit-ம் Waiting-உம் கொண்டது. 4. அந்த Customer-க்கு வழங்கப்பட்ட Schedule, Wording, Endorsement மற்றும் மாற்ற அறிவிப்பு. 5. Restoration நிகழ்வு சார்ந்தது; Base SI முதல் பெரிய Claim-க்கு முக்கியம்.

Advisor Checklist

• UIN மற்றும் பயன்படுத்திய ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டனவா?

• அடிப்படை மற்றும் விருப்பப் பாதுகாப்புகள் பிரிக்கப்பட்டனவா?

• அறை, PED, மகப்பேறு, Co-payment, Restoration தனித்தனியாக விளக்கப்பட்டனவா?

• முரண்பட்ட தகவலுக்கு நிறுவனத்தின் எழுத்தில் clarification பெறப்பட்டதா?

• Customer தேர்வுக்கான காரணமும் ஏற்கும் வரம்புகளும் பதிவு செய்யப்பட்டனவா?

ஆதாரம்: P01–P04 தற்போதைய Policy Wordings; ஒவ்வொரு தயாரிப்பின் Brochure, Prospectus மற்றும் CIS. பெறப்பட்ட நாள் 10-10-2026. மேலுள்ள ஒப்பீடு முக்கிய அம்சங்களுக்கான பயிற்சி விளக்கம்; முழு ஒப்பந்தத்தின் மாற்று அல்ல.

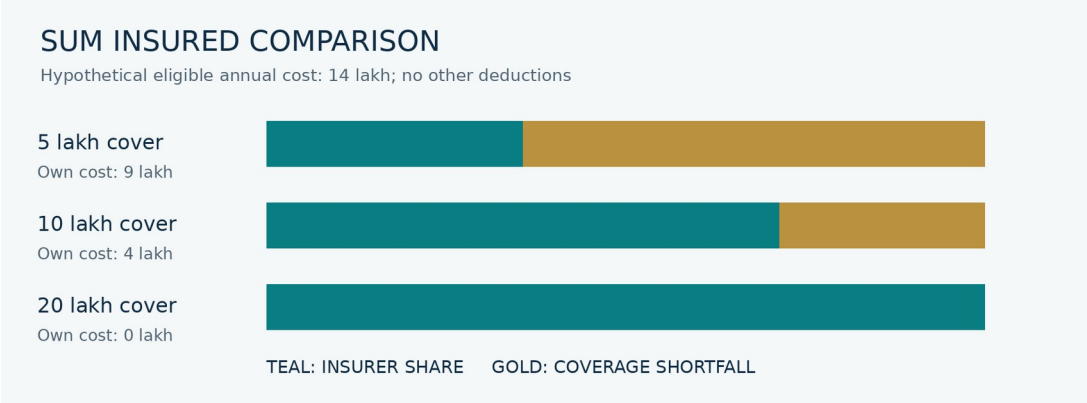
அத்தியாயம் 08

₹5 லட்சமா ₹10 லட்சமா ₹20 லட்சமா

Sum Insured Planning

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

எவ்வளவு cover எடுக்கணும் என்ற கேள்விக்கு ஒரே பதில் எல்லாருக்கும் பொருந்தாது. ₹5, ₹10, ₹20 லட்சம் cover-ஐ ஒரே கற்பனைக் கணக்கில் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம். Floater-ல் இரண்டு claims வந்தால் என்ன ஆகும், savings-உம் base cover-உம் Super Top-Up-உம் எப்படி சேர்ந்து உதவும் என்பதையும் பார்க்கலாம்.



படம் 8.1 • ஒரே கற்பனைச் செலவில் பாதுகாப்புத் தொகைகளின் வேறுபாடு.

தொகை என்பது ஆண்டின் செலவுத் திட்டத்தில் ஒரு பகுதி

SI பார்த்ததும் hospital bill-உடன் நேராக ஒப்பிட்டுவிடாதீங்க. முதலில் admissible expense எவ்வளவு, sub-limit இருக்கிறதா, co-pay இருக்கிறதா, ஏற்கெனவே SI எவ்வளவு பயன்படுத்தப்பட்டது என்று பார்க்கணும். அதற்குப் பிறகுதான் available cover-ன் பயன் தெரியும்.

வயது அல்லது income மட்டும் வைத்து cover முடிவு செய்ய முடியாது. குடும்பத்தில் எத்தனை பேர், எந்த hospital விருப்பம், எந்த நகரம், medical history என்ன, premium தொடர்ந்து கட்ட முடியுமா, சொந்த savings எவ்வளவு என்று சேர்த்துப் பார்க்கணும். “எல்லாருக்கும் ₹10 லட்சம் போதும்” என்று சொல்ல முடியாது.

சிம்பிளாக

ஒரு வீட்டில் ஒரே தண்ணீர்த் தொட்டியை எல்லாரும் பயன்படுத்துவது போல Floater-ஐ நினைச்சுப் பாருங்க. தொட்டி எவ்வளவு பெரியது என்பதோடு எத்தனை பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதும் முக்கியம். ஒருத்தருடைய பெரிய claim-க்குப் பிறகு மற்றவர்களுக்கு மீதி குறையலாம். Restoration இருந்தாலும் அது எப்போது பயன்படும் என்பதற்கு conditions இருக்கு.

₹5, ₹10, ₹20 லட்சம்: ஒரே கணக்கில் ஒப்பீடு

கீழுள்ள அனைத்தும் கற்பனையான பயிற்சிக் கணக்குகள். Hospital விலை மதிப்பீடுகள் அல்லது குறிப்பிட்ட தயாரிப்பின் நன்மைகள் அல்ல. முழுச் செலவும்

ஏற்கத்தக்கது; Co-payment, Deductible, Sub-limit, Bonus, Restoration இல்லை என்று எளிமைக்காகக் கருதுகிறோம்.

ஆண்டு **Admissible expense**	**₹5** லட்சம் பாதுகாப்பில் சொந்தப் பங்கு	**₹10** லட்சத்தில் சொந்தப் பங்கு	**₹20** லட்சத்தில் சொந்தப் பங்கு
₹3 லட்சம்	₹0	₹0	₹0
₹8 லட்சம்	₹3 லட்சம்	₹0	₹0
₹14 லட்சம்	₹9 லட்சம்	₹4 லட்சம்	₹0
₹24 லட்சம்	₹19 லட்சம்	₹14 லட்சம்	₹4 லட்சம்

Table-ல் customer share பூஜ்யம் என்று இருந்தால், உண்மையில் hospital-க்கு ஒரு ரூபாய்கூட கட்ட வேண்டாம் என்று அர்த்தம் இல்லை. Non-payables, deposit, room difference போன்றவை இருக்கலாம். SI பெரிதாக இருப்பதால் cover ஆகாத treatment cover ஆகிவிடாது.

இரண்டு குடும்ப உறுப்பினர்களின் Claim

நால்வர் குடும்பத்துக்கு ₹10 லட்சம் Floater. முதல் admissible claim ₹7 லட்சம். அதே வருடத்தில் இன்னொருவருக்கு ₹6 லட்சம் தேவை என்று வைத்துக்கலாம். Restoration இல்லாத இந்தக் கணக்கில் ₹3 லட்சம்தான் மீதி; இரண்டாவது claim-ல் ₹3 லட்சம் குடும்பம் செலுத்தணும். ₹10 லட்சம் பெரிய தொகையாகத் தோன்றினாலும் இரண்டு admissions-க்கு போதவில்லை.

Restoration இருந்தால் கணக்கு மாறலாம். அடுத்த claim-க்கா, அதே நோய்க்கா, partial usage-க்குப் பிறகே கிடைக்குமா என்று பார்க்கணும். “Restoration இருக்கு; அதிக base cover தேவையில்லை” என்று சொல்லாமல் இரண்டு options-க்கும் கணக்குப் போட்டுக் காட்டுங்க.

சொந்தச் செலவுப் பங்கு தொகை அதிகரித்தாலும் இருக்கலாம்

₹20 லட்சம் SI; admissible claim ₹4 லட்சம்; co-pay 10% என்று வைத்துக்கலாம். Company ₹3.6 லட்சம், customer ₹40,000. SI நிறைய மீதி இருந்தாலும் co-pay நீங்காது. மொத்த bill ₹4.2 லட்சம்; ₹20,000 non-payable என்றால் customer மொத்தம் ₹60,000 செலுத்துவார். இது விளக்கக் கணக்கு மட்டுமே; actual deduction order policy-க்கு மாறலாம்.

தேவையிலிருந்து தொகைக்குச் செல்லும் முறை

விருப்பமான hospitals-ல் room மற்றும் பெரிய treatments-க்கான தற்போதைய written estimates பெறச் சொல்லலாம். அவை எதிர்கால விலைக்கான guarantee இல்லை. ஒரு பெரிய claim, இரண்டு நடுத்தர claims, வேலை மாறும்போது office

cover இல்லாத நிலை என மூன்று சூழல்களை வைத்து cover போதுமா என்று பாருங்க.

Premium தொடர்ந்து கட்ட முடியுமா என்பதும் முக்கியம். முதல் வருடம் பெரிய policy எடுத்து அடுத்த வருடம் நிறுத்துவதைவிட, தொடரக்கூடிய base cover-உம் பொருத்தமான கூடுதல் cover-உம் உதவலாம். ஆனால் premium குறைக்க பெரிய deductible எடுத்தால், அந்த threshold-ஐ சமாளிக்க பணம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கணும்.

மதிப்பீட்டுப் பகுதி	கேட்க வேண்டிய கேள்வி
குடும்பம்	ஒரே ஆண்டில் இருவருக்கு சிகிச்சை தேவைப்பட்டால் என்ன செய்வோம்?
Hospital	விரும்பும் அறையும் சிகிச்சை நிலையமும் எந்தச் செலவுத் தரத்தில் உள்ளன?
வேலை	நிறுவனக் குழுப் பாதுகாப்பு வேலை மாற்றத்தில் தொடருமா?
சொந்தப் பணம்	Cover ஆகாத செலவும் Deductible-மும் செலுத்த முடியுமா?
நீண்டகாலம்	Renewal-க் கட்டணம் உயர்ந்தாலும் செலுத்தும் இடம் உள்ளதா?
அமைப்பு	Individual, Floater, Super Top-Up எந்தக் கலவை பொருத்தம்?

மருத்துவச் செலவு உயர்வை விளக்குதல்

விலை உயர்வு கணிப்பை உண்மையான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விகிதமாகச் சொல்லக்கூடாது. உதாரணமாக இன்றைய கற்பனைச் செலவு ₹5 லட்சம்; வருடத்திற்கு 8% உயர்வு என்ற பயிற்சி அனுமானத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ₹5,00,000 × 1.08^5 ≈ ₹7,34,664. 8% என்பது இங்கு கணக்குப் பயிற்சிக்கான Assumption மட்டுமே; மருத்துவத் துறையின் தற்போதைய அளவிடப்பட்ட விகிதமோ உறுதியான முன்னறிவிப்போ அல்ல.

இந்தக் கணக்கு customer-ஐ பயமுறுத்தி பெரிய policy விற்க அல்ல. ஒருமுறை SI தேர்ந்தெடுத்துவிட்டு மறந்துவிட வேண்டாம் என்பதற்காக. Family changes, hospital preference, income, cover usage எல்லாம் வைத்து renewal நேரத்தில் review செய்யணும்.

Advisor-க்கான குறிப்புகள்

Customer-க்கு இரண்டு அல்லது மூன்று நடைமுறை options கொடுங்க. பொருத்தமான base cover, அதிக base cover, base + Super Top-Up என்று ஒப்பிடலாம். ஒவ்வொன்றிலும் premium, claim நேர சொந்தச் செலவு, limits, continuity ஆகியவற்றை ஒரே format-ல் காட்டுங்க. "ஏன் இந்த option?" என்பதற்கு இரண்டு வாக்கியத்தில் தெளிவாகப் பதில் சொல்ல முடியணும்.

பேசிப் பார்ப்போம்

Customer: "எனக்கு இப்போது எந்த நோயும் இல்லை. ₹5 லட்சம் போதாதா?"

Advisor: "இப்போ health நல்லா இருப்பது நல்ல விஷயம். அதோடு உங்க hospital preference, family cover, savings-உம் சேர்த்துப் பார்ப்போம். ஒரு கற்பனை ₹14 லட்சம் admissible expense வந்தால் ₹5, ₹10, ₹20 லட்சம் cover-ல் உங்க செலவு எப்படி மாறும்னு காட்டுறேன்."

Customer: "அதிகத் தொகைக்கு கட்டணம் செலுத்த முடியாது."

Advisor: "தொடர்ந்து renew செய்ய முடிவது முக்கியம். Base cover-உடன் Super Top-Up option-ஐயும் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி deductible amount-ஐ எப்படி சமாளிப்பீங்கன்னு கணக்கிடுவோம்."

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

Bonus சேர்த்து வரக்கூடிய எதிர்காலத் தொகையை முதல் ஆண்டிலேயே உறுதியான Base SI-யாகக் காட்ட வேண்டாம். நிறுவனக் குழுக் காப்பீட்டை வாழ்நாள் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பாகக் நினைக்க வேண்டாம். பெற்றோர் சேர்க்கப்பட்ட பெரிய Floater-இல் தொகைப் பகிர்வை விளக்காமல் விட வேண்டாம். தொகை உயர்த்தும்போது அதிகரித்த பகுதிக்கு புதிய மதிப்பீடு அல்லது Waiting பொருந்துமா என்று கேட்கணும். அதிகத் தொகை எல்லா Exclusions-ஐயும் நீக்குவதில்லை.

கருத்துப்படம்: பாதுகாப்பின் மூன்று அடுக்குகள்

அடுக்கு	முக்கியப் பணி	தனியாகச் சரிபார்க்க வேண்டியது
சொந்தச் சேமிப்பு	அவசரப் பணப்புழக்கம், சொந்தச் செலவுப் பங்கு, Cover ஆகாத செலவு	உடனடியாகப் பயன்படுத்த முடியுமா?
Base Policy	பொதுவான மற்றும் முதல் பெரிய Admissible expense	அறை, தொகை, விலக்கு, தொடர்ச்சி
Super Top-Up	Aggregate Deductible-க்கு மேலான பெரிய ஆண்டு செலவு	கணக்கிடப்படும் செலவு, ஆண்டு ஒத்திசைவு, தனிக் Waiting

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Cover தொகையை குடும்பத் தேவை, hospital preference, நீண்டகால budget வைத்து முடிவு செய்யணும். ₹5, ₹10, ₹20 லட்சத்தை ஒரே example-ல் பார்த்தால் வித்தியாசம் புரியும். Amount மட்டுமே எல்லாம் இல்லை; conditions-உம் customer savings-உம் முக்கியம்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. Restoration இல்லாத ₹10 லட்சம் Floater-இல் ₹6 லட்சம் மற்றும் ₹7 லட்சம் ஏற்கத்தக்க Claims வந்தால் குடும்பத்தின் தொகைப் பற்றாக்குறை எவ்வளவு? 2. ₹20 லட்சம் Policy-ல் ₹3 லட்சம் ஏற்கத்தக்க Claim-க்கு 20% Co-payment இருந்தால் சொந்தப் பங்கு? 3. Bonus-ஐ Base SI-க்குச் சமமாகக் கருதுவதில் என்ன அபாயம்? 4. ஒரு குடும்பத்திற்கான மூன்று தேர்வுகளை உருவாக்கி ஒவ்வொன்றின் வரம்பையும் எழுதுங்க.

பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. ₹3 லட்சம். 2. ₹60,000; பிற Cover ஆகாத செலவுகள் இருந்தால் கூடுதல். 3. Bonus சேரும் காலம், Claim-ன் விளைவு, பயன்பாட்டு விதி மாறலாம். 4. நியாயமான Needs analysis, Budget, காப்பீட்டு விதி மற்றும் தெளிவான காரணம் மதிப்பீட்டின் அடிப்படை.

Advisor Checklist

- குறைந்தது இரண்டு செலவுச் சூழல்கள் கணக்கிடப்பட்டனவா?
- Floater பகிர்வும் குழுக் காப்பீட்டின் வரம்பும் விளக்கப்பட்டனவா?
- சொந்தப் பணத் தேவையும் ஆண்டு கட்டணத் திறனும் கேட்கப்பட்டனவா?
- அதிகரித்த தொகைக்கான புதிய நிபந்தனைகள் சரிபார்க்கப்பட்டனவா?
- ஆண்டுதோறும் மறுபரிசீலனை செய்யும் நாள் பதிவு செய்யப்பட்டதா?

ஆதாரம்: Sum Insured, Co-payment, Restoration ஆகியவற்றுக்கான P01–P04 Definitions. அனைத்து செலவுகளும் வளர்ச்சி விகிதமும் ஆசிரியர் உருவாக்கிய பயிற்சி Assumptions.

அத்தியாயம் 09

Super Top-Up கணக்கு எப்படி வேலை செய்கிறது

Super Top-Up Insurance

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Base cover எங்கே முடிகிறது, deductible என்ன செய்கிறது, Super Top-Up எப்போது உதவுகிறது என்று பார்க்கலாம். ஒரு claim-ஐத் தனியாகப் பார்க்கும் முறைக்கும் ஒரு வருட claims-ஐ சேர்க்கும் முறைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கணக்குடன் புரிஞ்சுக்கலாம். இரண்டு policies-ன் dates ஏன் முக்கியம் என்பதையும் பார்க்கலாம்.

Base Cover-க்கு மேலே என்ன தேவை?

ஒரு பெரிய bill-ன் முதல் பகுதியை base policy அல்லது நம்ம savings சமாளிக்கலாம். அதற்கு மேலே வரும் தகுதியான செலவுக்கு கூடுதல் policy உதவலாம். அது பணம் தர ஆரம்பிக்கும் முன் கடக்க வேண்டிய threshold-தான் deductible. இது company-கிட்ட வைக்கும் deposit இல்லை; திரும்பக் கிடைக்கும் பணம் என்றும் நினைக்காதீங்க.

Super Top-Up தனி policy. அதற்கென்று underwriting, waiting, exclusions, room rules, admissible expense definition, claim process இருக்கலாம். Base policy ஒரு செலவை ஏற்றது என்பதால் Super Top-Up-உம் தானாக ஏற்றுவிடும் என்று சொல்ல முடியாது.

சிம்பிளாக

எளிமையாகச் சொன்னால், eligible expense முதலில் ஒரு threshold-ஐத் தாண்டணும். Top-Up பொதுவாக ஒவ்வொரு claim-ஐயும் தனியாகப் பார்க்கலாம்; Super Top-Up policy year-ன் eligible expenses-ஐ சேர்த்துப் பார்க்கலாம். Actual wording-ல் என்ன method இருக்கிறது என்று உறுதி செய்துதான் விளக்கணும்.

Top-Up மற்றும் Super Top-Up ஒப்பீடு

அம்சம்	**Top-Up** மாதிரி	**Super Top-Up** மாதிரி
Deductible பரிசீலனை	ஒவ்வொரு Claim-க்கும்	Policy ஆண்டின் சேர்க்கைச் செலவுக்கு

அம்சம்	**Top-Up** மாதிரி	**Super Top-Up** மாதிரி
இரண்டு சிறிய Claims	ஒவ்வொன்றும் வரம்புக்குக் கீழே இருந்தால் பணம் கிடைக்காமல் இருக்கலாம்	சேர்த்து வரம்பைத் தாண்டினால் மேலதிகம் பொருந்தலாம்
ஒரே பெரிய Claim	Deductible-க்கு மேலான ஏற்கத்தக்க பகுதி	பயன்படுத்தாத Aggregate Deductible-க்கு மேலான பகுதி
சரிபார்க்க வேண்டியது	ஒவ்வொரு Claim வரையறை	ஆண்டு, நபர் / குடும்ப சேர்க்கை, Admissible expense

இவை பொதுவான training models. Actual product-ல் method அல்லது terms மாறலாம். Deductible-க்கு எந்த expenses சேரும், குடும்ப உறுப்பினர்களின் செலவுகளைச் சேர்க்கலாமா, மற்ற insurer paid amount-க்கு என்ன proof தேவை என்று எழுத்தில் உறுதி செய்யுங்க.

₹5 லட்சம் Deductible: மூன்று Claims

கற்பனை Super Top-Up தொகை ₹20 லட்சம்; ஆண்டு Aggregate Deductible ₹5 லட்சம். மூன்று Claim-களும் இந்தப் Policy-ன் கீழ் முழுமையாக ஏற்கத்தக்கவை; வேறு கழிவுகள் இல்லை எனக் கருதுகிறோம். ₹20 லட்சம் என்பது Deductible-க்கு மேலான பாதுகாப்புத் தொகை என்ற மாதிரி வரையறையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

நிகழ்வு	**Admissible expense**	ஆண்டு சேர்க்கை	இந்நிகழ்வில் **Super Top-Up** செலுத்துவது
முதல் Claim	₹3 லட்சம்	₹3 லட்சம்	₹0
இரண்டாவது Claim	₹4 லட்சம்	₹7 லட்சம்	₹2 லட்சம்
மூன்றாவது Claim	₹6 லட்சம்	₹13 லட்சம்	₹6 லட்சம்
மொத்தம்	₹13 லட்சம்	₹13 லட்சம்	₹8 லட்சம்

இந்த உதாரணத்தில் முதல் ₹5 லட்சம் base policy அல்லது customer பொறுப்பு. Super Top-Up மொத்தம் ₹8 லட்சம் தருகிறது; அதன் ₹20 லட்சம் cover-ல் ₹12 லட்சம் மீதி.

இதே claims-க்கு ஒவ்வொரு claim-லும் தனி ₹5 லட்சம் deductible போட்டால், முதல் இரண்டு claims-க்கு ₹0; மூன்றாவதற்கு ₹1 லட்சம்தான். Aggregate method-ன் வித்தியாசம் இதுதான்.

முதல் Claim-யே மிகப்பெரியதாக இருந்தால்

Deductible ₹5 லட்சம்; அதற்கு மேல் cover ₹20 லட்சம். முதல் admissible claim-வே ₹28 லட்சம் என்று வைத்துக்கலாம். Threshold-க்கு மேல் ₹23 லட்சம் இருந்தாலும் Super Top-Up limit ₹20 லட்சம்தான். முதல் ₹5 லட்சத்தோடு மேலும் ₹3 லட்சமும் வேறு வழியில் சமாளிக்கணும். “எந்த bill வந்தாலும் போதும்” என்று சொல்லாதீங்க.

மொத்தப் பில்லும் Admissible expense-ம் ஒன்றல்ல

Hospital bill ₹6 லட்சம். Super Top-Up விதிப்படி அதில் ₹1.5 லட்சம் admissible இல்லை என்று வைத்துக்கலாம். Deductible கணக்குக்கு வரும் செலவு ₹4.5 லட்சம்தான் என்றால் ₹5 லட்சம் threshold இன்னும் தாண்டவில்லை. Bill ₹6 லட்சம் என்பதற்காக ₹1 லட்சம் Super Top-Up தரும் என்று கணக்கிட முடியாது.

Base insurer ₹4 லட்சம் கொடுத்தால் Super Top-Up deductible-க்கும் அதே ₹4 லட்சம் தானாகக் கணக்காகும் என்று நினைக்காதீங்க. அதன் admissible expense விதியும் documents-உம் பார்க்கணும். ஒரே செலவுக்கு இரண்டு முறை முழுப் பணம் வாங்க முடியாது.

அடிப்படை ₹3 லட்சம்; Deductible ₹5 லட்சம்

Base cover ₹3 லட்சம்; Super Top-Up deductible ₹5 லட்சம். முழுவதும் admissible ஆன ₹8 லட்சம் செலவில், எளிய கணக்குப்படி base ₹3 லட்சம், Super Top-Up ₹3 லட்சம் தரலாம். நடுவில் உள்ள ₹2 லட்சம் customer செலவு. அதனால “Base policy இருக்கா?” என்று மட்டும் கேட்காமல், எவ்வளவு பயன்படுத்தக்கூடிய cover என்று கேளுங்க.

Policy ஆண்டுகளை ஒத்திசைத்தல்

Base policy ஜனவரி–டிசம்பர். Super Top-Up ஜூலை–ஜூன் என்று வைத்துக்கலாம். மே claim-உம் ஆகஸ்ட் claim-உம் Super Top-Up-ன் வெவ்வேறு policy years-ல் வரலாம். இரண்டையும் ஒரே deductible கணக்கில் சேர்க்க முடியாமல் போகலாம். Dates ஒத்திருந்தால் புரிய எளிது; ஆனால் date மாற்றும்போது continuity பாதிக்கப்படுகிறதா என்பதையும் பார்க்கணும்.

பொதுவாக பயன்படுத்தாத deductible அடுத்த வருடத்துக்கு carry forward ஆகாது; actual wording பார்க்கணும். Base policy-ல் உள்ள எல்லாரும் Super Top-Up-லும் இருக்கிறார்களா என்று check செய்யுங்க. Base-ல் இருக்கும் parent கூடுதல் policy-ல் விடுபட்டிருக்கலாம்.

கருத்துப்படம்: பணம் எந்த அடுக்கிலிருந்து?

Admissible expense-ப் பகுதி	**₹5** லட்சம் **Deductible** மாதிரியில் ஆதாரம்
₹0 முதல் ₹5 லட்சம் வரை	Base Policy / சொந்தப் பணம்
₹5 லட்சத்திற்கு மேல், கூடுதல் cover வரம்புக்குள்	Super Top-Up, அதன் விதிகளுக்குட்பட்டு
கூடுதல் cover வரம்புக்கும் மேல்	சொந்தப் பணம் / பொருந்தும் மற்ற பாதுகாப்பு
Non-payable expense	மேலுள்ள தொகைப் படிகளில் தானாகக் காப்பளிக்கப்படாது

Advisor-க்கான குறிப்புகள்

ஒரு claim, இரண்டு சிறிய claims, ஒரு மிகப் பெரிய claim என்று மூன்று கணக்குகள் காட்டுங்க. Customer-யே கணக்கைச் சொல்லச் சொல்லலாம். Super Top-Up-க்கு புதிய waiting ஆரம்பிக்கிறதா என்பதைத் தெளிவாகச் சொல்லணும். Base policy-ன் பழைய continuity தானாக அதற்கும் கிடைக்காது.

இரண்டு policies-லும் Cashless இருந்தாலும் ஒரே admission-ல் coordination தேவைப்படலாம். Documents copies, முதல் insurer settlement letter, expense breakup தயாராக இருக்க உதவுங்க. இருவரும் அதே நாளில் deposit இல்லாமல் pay செய்வார்கள் என்று உறுதி தராதீங்க.

உரையாடல்

Customer: “₹5 லட்சம் Deductible என்றால் எனக்கு ₹5 லட்சம் இழப்பா?”

Advisor: “அது Super Top-Up company ஏற்காத முதல் பகுதி. உங்க base policy அதன் conditions-படி அதை ஏற்கலாம். Base cover போதாத gap இருந்தால் உங்க கையிலிருந்து செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.”

Customer: “இரண்டு ₹3 லட்சம் Claims வந்தால்?”

Advisor: “இந்த example-ல் இரண்டும் admissible; ஒரே Super Top-Up policy year-ல் வந்ததாக வைத்துக்கிட்டா மொத்தம் ₹6 லட்சம். ₹5 லட்சம் aggregate deductible-க்கு மேல் ₹1 லட்சம் பரிசீலிக்கலாம். Actual policy விதிகளையும் பார்க்கணும்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

ஒவ்வொரு Claim Deductible-ஐ ஆண்டு Aggregate Deductible என்று விளக்குதல்; Hospital முழுப் பில்லையே சேர்க்கைச் செலவாகக் கருதுதல்; Policy ஆண்டுகள் மாறுவதை மறத்தல்; Base SI-யை விட Deductible அதிகமாக இருப்பதைச் சொல்லாமல் விடுதல்; Super Top-Up policy-க்குத் தனிக் Waiting இல்லை என்று கருதுதல் ஆகியவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். Sum Insured என்பது Deductible-ஐ உள்ளடக்கிய மொத்த எல்லையா அல்லது அதற்கு மேலான எல்லையா என்பதை ஆவணத்தில் உறுதி செய்யுங்க.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Super Top-Up பெரிய ஆண்டு செலவுக்கு உதவும் அமைப்பு. அதன் பயனைப் புரிஞ்சுக்க Aggregate Deductible, Admissible expense மற்றும் Policy ஆண்டு மூன்றையும் ஒன்றாகப் பார்க்கணும். இது Base Policy-யின் எல்லா குறைகளையும் சரிசெய்யும் மாற்று அல்ல.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. ₹5 லட்சம் Aggregate Deductible-இல் ஒரே ஆண்டின் ₹2, ₹2, ₹4 லட்சம் ஏற்கத்தக்க Claims-க்கு கூடுதல் cover மொத்தம் எவ்வளவு? 2. அதே செலவுகள் ஒவ்வொரு Claim-க்கும் ₹5 லட்சம் Deductible கொண்ட மாதிரியில்? 3. ₹4 லட்சம் அடிப்படை, ₹6 லட்சம் Deductible, ₹10 லட்சம் ஏற்கத்தக்க செலவில் இடைவெளி எவ்வளவு? 4. Policy ஆண்டுகள் மாறினால் சேர்க்கைக் கணக்கு ஏன் மாறும்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. ₹3 லட்சம், போதிய கூடுதல் cover வரம்பு மற்றும் பிற நிபந்தனைகள் பூர்த்தியானால். 2. ₹0. 3. ₹2 லட்சம்; கூடுதல் cover ₹4 லட்சம் என்ற எளிய மாதிரி. 4. ஒவ்வொரு Super Top-Up policy ஆண்டுக்கும் Deductible மீண்டும் கணக்கிடப்படுவதால்.

Advisor Checklist

- Deductible முறை மற்றும் வரையறை உறுதிசெய்யப்பட்டதா?
- அடிப்படை மற்றும் கூடுதல் cover உறுப்பினர்கள் ஒப்பிடப்பட்டனரா?
- ஆண்டுத் தேதிகள், Waiting, அறை மற்றும் Exclusions பார்க்கப்பட்டனவா?
- மூன்று Claim-க் கணக்குகளை Customer புரிந்துகொண்டாரா?
- இரு நிறுவனங்களின் Claim ஒருங்கிணைப்புக்கான ஆவணத் திட்டம் உள்ளதா?

ஆதாரம்: இது தயாரிப்பு சாராத கருத்துப் பயிற்சி. குறிப்பிட்ட Top-Up / Super Top-Up பரிந்துரைக்கு அதன் தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ Policy Wording மற்றும் CIS கட்டாயம். இங்குள்ள எண்கள் முழுவதும் கற்பனையானவை.

அத்தியாயம் 10

Cashless Claim Hospital-ல் என்ன நடக்கும்

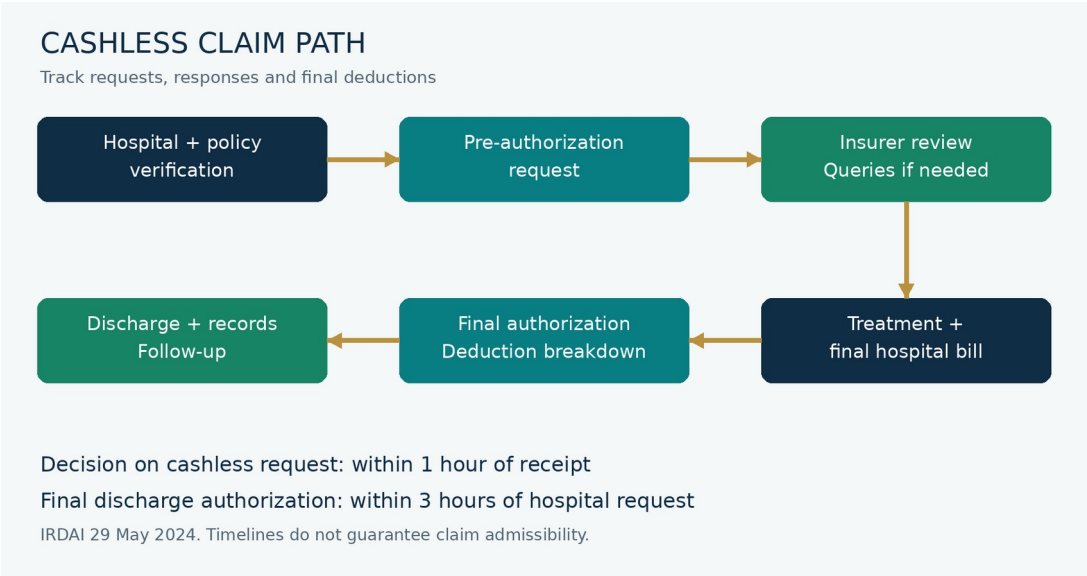
Cashless Claim Process



Hospital Insurance Desk-உடன் தகவல் ஒருங்கிணைப்பு. AI உருவாக்கிய காட்சி.

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Network check-லிருந்து discharge approval வரை என்ன நடக்கும் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். Initial approval ஏன் final amount இல்லை, medical query வந்தால் என்ன செய்யணும், தாமதத்தை எப்படிப் பதிவு செய்து follow-up செய்யணும் என்பதும் தெரிஞ்சுக்கலாம்.



படம் 10.1 • பணமில்லா Claim-ன் முழு செயல்முறை.

Cashless என்பதன் சரியான பொருள்

Cashless என்றால் admissible hospital செலவை insurer நேராக hospital-க்குச் செலுத்தும் முறை. Customer எதுவுமே கட்ட வேண்டாம் என்று அர்த்தம் இல்லை. Co-pay, deductible, non-payables, limit-க்கு மேலான செலவு இருக்கலாம். Admission நேர deposit-உம் final claim settlement-உம் ஒன்றல்ல.

Network hospital name மட்டும் போதாது. சரியான branch, address, insurer/TPA arrangement, treatment facility பார்க்கணும். List மாறலாம்; பழைய card அல்லது screenshot இன்றைய proof இல்லை. Non-network Cashless arrangement இருந்தாலும் முன்பே எழுத்தில் உறுதி செய்யாமல் “கிடைக்கும்” என்று சொல்லாதீங்க.

சிம்பிளாக

Cashless என்பது பணம் எந்த வழியில் செல்கிறது என்பது. Coverage என்பது அந்த treatment செலவை policy ஏற்கிறதா என்பது. இரண்டும் வேறு. Cashless வசதி இருப்பதால் policy-ன் eligibility, limits, exclusions நீங்கிவிடாது.

முழு நடைமுறை வரைபடம்

நிலை	செயல்	பதிவு / முடிவு
1. மருத்துவத் தேவை	மருத்துவர் சிகிச்சைத் திட்டம் அமைக்கிறார்	அவசரம் / திட்டமிட்ட அனுமதி
2. தகுதி சரிபார்ப்பு	Policy, உறுப்பினர், Hospital கிளை சரிபார்ப்பு	Policy எண், நிலை, கிடைக்கும் தொகை
3. Pre-authorization	Hospital விண்ணப்பமும் மதிப்பீடும் அனுப்புகிறது	அனுப்பிய நேரம், Reference Number
4. மருத்துவ விளக்கம்	கேள்வி இருந்தால் Hospital பதிலளிக்கிறது	கேள்வி, ஆதாரம், பதில் நேரம்
5. ஆரம்ப முடிவு	அனுமதி / பகுதி அனுமதி / மறுப்பு	அனுமதிக் கடிதம் மற்றும் நிபந்தனை
6. சிகிச்சை	செலவு உயர்ந்தால் Enhancement கோரப்படுகிறது	புதுப்பிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு

நிலை	செயல்	பதிவு / முடிவு
7. விடுவிப்பு	இறுதிப் பில், Discharge Summary அனுப்பப்படுகிறது	இறுதி Claim அனுப்பிய நேரம்
8. Final Authorization	இறுதி ஏற்கத்தக்க தொகை கணக்கிடப்படுகிறது	கழிவுப் பிரிப்பு, நோயாளிப் பங்கு
9. முடிப்பு	ரசீது, Settlement letter, ஆவணப் பிரதிகள்	தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டிய கோப்பு

Emergency-ல் insurance பதிலுக்காக தேவையான treatment-ஐத் தாமதிக்கச் சொல்லாதீங்க. Treatment முடிவு doctor-டம் இருக்கட்டும். Advisor-ஆக நம்மால் செய்ய முடிவது insurance process-க்கு சரியான தகவலைச் சேர்த்து உதவுவதுதான்.

முன் அனுமதி மற்றும் மருத்துவக் கேள்விகள்

Planned treatment என்றால் hospital முன்பே pre-authorization அனுப்பலாம். எவ்வளவு முன்னதாக அனுப்பணும் என்பதை அந்த policy process-ல் check செய்யுங்க. Emergency-ல் medical situation அனுமதிக்கும் அளவு சீக்கிரம் intimate செய்யணும். எல்லா insurer-க்கும் ஒரே intimation deadline என்று சொல்ல வேண்டாம்.

Query வந்ததும் “Claim reject” என்று நினைக்க வேண்டாம். நோய் எப்போது தொடங்கியது, பழைய treatment, test result, இப்போதைய treatment necessity பற்றி clarification தேவைப்படலாம். Medical பதிலை advisor எழுதக் கூடாது; doctor/hospital பதிவை வாங்கணும். உண்மையான record error இருந்தால் உரியவரிடம் correction கேட்கலாம்; claim கிடைக்க dates மாற்றக் கூடாது.

Regulatory நேரங்களைக் கவனமாக விளக்குதல்

இங்கே குறிப்பிடுவது 29-05-2024 IRDAI Health Master Circular விதி. Cashless request பெற்றதும் உடனடியாக, அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரத்துக்குள் முடிவு எடுக்க வேண்டும். Hospital-ன் discharge final authorisation request பெற்றதிலிருந்து மூன்று மணி நேரத்துக்குள் final authorisation வழங்க வேண்டும். இது எல்லா claims-உம் கட்டாயம் approve செய்ய வேண்டும் என்ற அர்த்தம் இல்லை. நடைமுறையில் பொருந்தும் புதிய மாற்றங்கள் இருந்தால் உறுதி செய்யணும். [R01, பத்திகள் 15–16]

Patient வீட்டுக்குப் போக நினைத்த நேரம் மட்டும் போதாது. Hospital final request எப்போது அனுப்பியது, insurer எப்போது பெற்றது என்பதற்கான பதிவு வேண்டும். மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேலான delay காரணமாக கூடுதல் hospital charges

வந்தால் insurer shareholder fund-லிருந்து ஏற்கும் விதி circular-ல் இருக்கு. Bill, timestamps, messages வைத்து முறையாகக் கேளுங்க; எல்லா bill-மும் தானாக waive ஆகும் என்று சொல்லாதீங்க.

ஒரு கற்பனை Example

கார்த்திக்கின் treatment estimate ₹2.5 லட்சம்; initial approval ₹1.8 லட்சம். Final bill ₹2.7 லட்சம்; இறுதி admissible amount ₹2.4 லட்சம்; co-pay இல்லை என்று வைத்துக்கலாம். Customer share ₹30,000. Initial ₹1.8 லட்சமே final limit என்று அர்த்தம் இல்லை. Estimate ₹2.5 லட்சம் என்பதும் உறுதியான approval இல்லை.

அதே ₹2.4 லட்சம் admissible amount-க்கு 10% co-pay என்றால் insurer ₹2.16 லட்சம்; ₹2.7 லட்சம் bill-ல் customer மொத்தம் ₹54,000. ஒவ்வொரு deduction-க்கும் காரணம் பிரித்துக் காட்டுங்க. இவை கற்பனைக் கணக்குகள்; actual settlement-க்கான முன்கூட்டிய உறுதி இல்லை.

ஆலோசகரின் செயல் வரம்பு

Customer சம்மதத்துடன் policy details, claim number, contact person, current status வாங்குங்க. Query pending என்றால் யார் reply செய்யணும், எந்த document, எப்போது அனுப்பப்பட்டது என்று note செய்யுங்க. “நான் பேசிட்டேன்; bill முழுசா வரும்” என்று ஆதாரமில்லாமல் சொல்லாதீங்க.

உரையாடல்

Customer: “Cashless இருந்தும் ₹20,000 ஏன் கேட்கிறார்கள்?”

Advisor: “அது deposit-ஆ, non-payable expense-ஆ, co-pay-ஆ என்று breakup வாங்கிப் பார்ப்போம். Final letter-உடன் ஒப்பிட்டு ஏன் அந்த amount கேட்கிறாங்கன்னு விளக்குறேன்.”

Customer: “கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள்; மறுப்பா?”

Advisor: “Query வந்திருக்கலாம்; அது final rejection-ன்னு உடனே சொல்ல முடியாது. Query copy வாங்கி hospital-லிருந்து சரியான medical reply அனுப்ப உதவுவோம். Final decision வந்த பிறகுதான் முடிவு தெரியும்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

ஆரம்ப அனுமதியை இறுதி உறுதியாகக் காட்டுதல்; Network தகுதியை Coverage-க்கு மாற்றாகச் சொல்வது; நோயாளியின் உடல்நிலையைப் பகிர்ந்த குழுச் செய்திகளில் வெளிப்படுத்துதல்; விடுவிப்புக் Claim அனுப்பப்படாத நேரத்தை Insurer தாமதமாகக் கணக்கிடுதல்; மருத்துவப் பதிவை மாற்றச் சொல்லுதல் ஆகியவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். Cashless மறுப்பு ஏற்பட்டால் அதன்

காரணத்தைப் பொறுத்து Reimbursement வழி இருக்கலாம்; ஆனால் அது Claim ஏற்கப்படும் என்ற உறுதி அல்ல.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Cashless-ல் சரியான details, hospital coordination, timestamps, expense breakup எல்லாம் உதவும். Treatment-யோ claim approval-யோ advisor கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால் customer-க்கு என்ன நடக்கிறது, அடுத்து என்ன செய்யணும் என்று தெளிவாக விளக்க முடியும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. ஆரம்ப அனுமதியும் Final Authorization-மும் ஏன் வேறுபடலாம்? 2. மூன்று மணி நேரத்தை எந்த நிகழ்விலிருந்து கணக்கிட வேண்டும்? 3. ₹3 லட்சம் பில், ₹2.5 லட்சம் Admissible expense, 10% Co-payment என்ற எளிய மாதிரியில் நோயாளிப் பங்கு? 4. மருத்துவக் கேள்விக்கு யார் பதிலளிக்க வேண்டும்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. இறுதிச் சிகிச்சை, பில் மற்றும் நிபந்தனைகள் மாறலாம். 2. Hospital-ன் விடுவிப்புக்கான இறுதி அனுமதிக் Claim பெறப்பட்ட நேரம். 3. ₹75,000. 4. உரிய Hospital / மருத்துவர் உண்மையான ஆதாரத்துடன்; ஆலோசகர் ஒருங்கிணைக்கலாம்.

Advisor Checklist

- Hospital-ன் சரியான கிளையும் உறுப்பினர் தகுதியும் உறுதிசெய்யப்பட்டனவா?
- ஆரம்ப மற்றும் இறுதிக் Claim நேரங்கள் பதிவாகியுள்ளனவா?
- கேள்விகள் உரிய மருத்துவ அதிகாரியிடம் சென்றனவா?
- இறுதிக் கழிவுகள் காரணத்துடன் விளக்கப்பட்டனவா?
- Customer-கிட்ட ரசீதுகளும் தீர்வுக் கடிதமும் உள்ளனவா?

ஆதாரம்: R01 பத்திகள் 15–17; P01–P04 Claim Procedure மற்றும் Hospitalisation Conditions. நேர வரம்பு Regulatory விதி; அறிவிப்பு மற்றும் ஆவண நடைமுறைகள் பொருந்தும் Policy-ப்படி சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

அத்தியாயம் 11

Reimbursement கட்டிய பணத்தை Claim செய்வது

Reimbursement Claims

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Claim அறிவிப்பைச் சரியாகச் செய்தல்; மருத்துவம், செலவு மற்றும் அடையாள ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல்; கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் பதிவை பராமரித்தல்; தீர்வுத் தொகையைப் பில்லுடன் ஒப்பிடுதல் ஆகியவை நோக்கங்கள்.

Reimbursement எப்போது தேவைப்படலாம்?

Customer முதலில் hospital bill செலுத்திவிட்டு, policy ஏற்கும் பகுதியை insurer-டம் கேட்பதுதான் Reimbursement. Cashless கிடைக்காத நேரம் அல்லது பொருந்தும் மற்ற சூழல்களில் இது தேவைப்படலாம். பணம் கட்டிவிட்டதால் முழுவதும் திரும்பும் என்று அர்த்தம் இல்லை. Treatment eligibility, waiting, exclusions, limits தொடர்ந்து பொருந்தும்.

Cashless மறுக்கப்பட்டது என்பதும் முழு claim reject ஆனது என்பதும் ஒன்றல்ல. போதுமான தகவல் இல்லாததால் Cashless கிடைக்காமல் இருக்கலாம்; உண்மையான exclusion காரணமாகவும் மறுக்கப்பட்டிருக்கலாம். Letter-ல் என்ன காரணம் என்று படித்துவிட்டுத்தான் அடுத்த வழியைத் தீர்மானிக்கணும்.

சிம்பிளாக

நீங்க கட்டிய amount-உம் policy ஏற்கும் amount-உம் வேறாக இருக்கலாம். Payment proof, medical evidence, policy eligibility மூன்றும் பார்க்கப்படும். Bill மட்டும் இருந்தால் எல்லா details-உம் தெரியாது.

அறிவிப்பிலிருந்து தீர்வு வரை

படி	**Customer /** ஆலோசகர் உதவி	நிறுவனத்திடம் உறுதிசெய்ய வேண்டியது
1. அறிவிப்பு	Policy, நோயாளி, Hospital, தேதி தெரிவிக்கவும்	Claim Reference மற்றும் பெறுதல் பதிவு

படி	**Customer /** ஆலோசகர் உதவி	நிறுவனத்திடம் உறுதிசெய்ய வேண்டியது
2. ஆவண ஒருங்கிணைப்பு	உள்ள பிரதிகளை ஒழுங்குபடுத்தவும்	Hospital-யிடமிருந்து தேவைப்படும் பதிவுகள்
3. விண்ணப்பம்	உண்மையான தகவல், சம்மதம், வங்கித் தகவல்	அதிகாரப்பூர்வ சமர்ப்பிப்பு வழி
4. கேள்வி	கேள்விப் பட்டியல் மற்றும் பதிலைப் பதிவு செய்யவும்	நிலுவை விவரம் மற்றும் பெற்ற நாள்
5. மதிப்பீடு	கூடுதல் உண்மையான விளக்கத்திற்கு உதவவும்	முடிவு மற்றும் காரணங்கள்
6. தீர்வு	வங்கியில் வந்த தொகையை ஒப்பிடவும்	கழிவுப் பிரிப்பு / Settlement letter
7. மறுபரிசீலனை	தவறு இருந்தால் ஆதாரத்துடன் எழுதவும்	Grievance Reference மற்றும் பதில்

ஆவணச் சேகரிப்பில் முக்கிய Regulatory-ப் பொறுப்பு

29-05-2024 IRDAI Health Master Circular பத்தி 17(c)-ல், claim intimate செய்த பிறகு hospital-லிருந்து தேவையான documents-ஐ insurer/TPA சேகரிக்க வேண்டும் என்று உள்ளது. அந்த hospital records-ஐ submit செய்யும் சுமையை policyholder மீது போடக் கூடாது. Customer-கிட்ட ஏற்கெனவே இருக்கும் copies-ஐ நாம் ஒழுங்குபடுத்தலாம்; அதனால் insurer-ன் பொறுப்பு மாறாது. [R01]

Claim form, identity, bank details அல்லது customer-க்கே தெரிந்த தகவல்களுக்கு அவருடைய உதவி தேவைப்படலாம். “எதுவுமே தர வேண்டாம்” என்றும் சொல்லாதீங்க; hospital records-க்காக customer-ஐ மீண்டும் மீண்டும் ஓடச் சொல்வதும் சரியல்ல. Hospital-லிருந்து பெறுவது எது, customer தருவது எது என்று பிரிக்கணும்.

ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய ஆவணங்கள்

தொகுப்பு	**Example**-கள்	ஏன் முக்கியம்?
Policy / அடையாளம்	Policy எண், உறுப்பினர் விவரம், தேவையான அடையாளச் சான்று	சரியான நபரும் பாதுகாப்புக் காலமும்
மருத்துவம்	Discharge Summary, பரிசோதனை முடிவுகள், மருத்துவர் பரிந்துரை	நோய், சிகிச்சை, தேதிகள் மற்றும் தொடர்பு
செலவு	Itemised Final Bill, ரசீதுகள், மருந்துப் பில்கள்	உண்மையில் ஏற்பட்ட மற்றும் செலுத்திய தொகை
வங்கி	அதிகாரப்பூர்வமாகக் கேட்கப்படும் கணக்குச் சான்று	சரியான பயனாளிக்குத் தொகை செலுத்துதல்
முந்தைய தீர்வு	மற்ற Insurer-ன் Settlement Letter	பல Policy ஒருங்கிணைப்பு
தொடர்பு	அறிவிப்பு, கேள்வி, பதில், பெற்றதற்கான உறுதி	செயல்முறை மற்றும் காலவரிசை

Accident போன்ற cases-க்கு கூடுதல் documents தேவைப்படலாம். எல்லா claim-க்கும் ஒரே நீண்ட list கட்டாயம் என்று சொல்லாதீங்க. பொருந்தும் requirement-ஐ official-ஆக உறுதி செய்யுங்க. Original கொடுத்தால் acknowledgement-உம் readable copy-உம் வைத்துக்கொள்ளணும்.

கோப்பை அமைக்கும் நடைமுறை

ஒவ்வொரு claim-க்கும் தனி folder வையுங்க. File name-ல் தேவையில்லாமல் நோயின் பெயரை வெளியிடாமல் claim reference + document type பயன்படுத்தலாம். Date order-ல் வைத்தால் pre/post expenses பிரிக்க எளிது. Customer சம்மதமின்றி personal email, public group, எல்லாரும் திறக்கக்கூடிய link-ல் reports பகிர வேண்டாம்.

ஒரு பக்கத்தில் admission, discharge, intimation, submission, query, reply, settlement dates எழுதுங்க. “பத்து முறை phone பண்ணினோம்” என்பதைக் காட்டிலும் எந்த document எப்போது received ஆனது என்ற பதிவு பிரச்சினையைத் தீர்க்க உதவும்.

ஒரு Settlement கணக்கு

கற்பனை bill ₹2,80,000. Non-payable ₹15,000; sub-limit காரணமாக மேலும் ₹25,000 deduction. மீதி ₹2,40,000. அதற்கு 10% co-pay என்றால் insurer ₹2,16,000; customer இறுதிச் செலவு ₹64,000. ₹2,80,000 கட்டிய receipt இருக்கிறது என்பதால் முழுவதும் refund ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது.

இது training calculation மட்டுமே. Actual deduction order, limits, co-pay எல்லாம் policy-க்கு மாறும். Settlement letter-ல் deduction reason இல்லாவிட்டால் எழுத்தில் explanation கேளுங்க.

தொழில்முறை வழிகாட்டுதலும் உரையாடலும்

Customer: “பணம் செலுத்திவிட்டேன். எப்போது முழுவதும் திரும்பும்?”

Advisor: “முதலில் intimation-உம் documents status-உம் பார்க்கலாம். முழு amount கிடைக்குமா என்பது policy ஏற்கும் செலவைப் பொறுத்தது. Official timeline, இன்னும் என்ன pending என்பதையும் எழுத்தில் கேட்டுத் தெரிஞ்சுக்கலாம்.”

Customer: “அதே ஆவணத்தை மீண்டும் கேட்கிறார்கள்.”

Advisor: “முன்னாடி அனுப்பிய copy-உம் acknowledgement-உம் இருக்கா பார்க்கலாம். File தெளிவில்லையா, வேற document கேட்டிருக்காங்களா என்று clarify செய்வோம். Hospital records சேகரிக்கும் insurer பொறுப்பையும் சுட்டிக்காட்டலாம்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

தெளிவில்லாத படங்களை அனுப்புதல், பில் மற்றும் ரசீதை ஒன்றாகக் கருதுதல், வங்கிக் கணக்கில் பெயர் வேறுபாட்டைச் சரிபார்க்காதது, முன்/பின் சிகிச்சைத் தொடர்பை விளக்காதது, அனுப்பியதற்கான ஆதாரத்தை வைத்திருக்காதது ஆகியவை தாமதத்தை அதிகரிக்கலாம். பொய்யான பில், மாற்றப்பட்ட தேதி அல்லது உண்மையில் செலுத்தாத செலவு சேர்த்தல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை. Policy-ல் குறிப்பிடப்பட்ட அறிவிப்பு மற்றும் சமர்ப்பிப்பு விதிகளைப் பாருங்க; தாமதம் இருந்தால் உண்மையான காரணத்துடன் விளக்கம் அளிக்க உதவுங்கள்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Reimbursement என்பது bill கொடுத்ததும் பணம் வரும் ஒரு step இல்லை. Intimation, medical proof, payment proof, assessment, settlement என பல steps இருக்கு. Advisor சரியான பதிவும் follow-up-உம் செய்ய உதவணும்; final amount-க்கு முன்கூட்டியே guarantee தரக்கூடாது.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. பிலும் பணம் செலுத்திய ரசீதும் ஏன் தனித்தனி? 2. Hospital பதிவுகளைச் சேகரிப்பதில் யாருக்குப் பொறுப்பு உள்ளது? 3. ₹1 லட்சம் பில்லில் ₹10,000

ஏற்கத்தக்கதல்ல; மீதிக்கு 20% Co-payment என்றால் Insurer பங்கு? 4. ஒரே ஆவணம் மீண்டும் கேட்கப்பட்டால் முதல் நடவடிக்கை என்ன?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. ஒன்று கட்டண விவரம்; மற்றொன்று செலுத்தியதற்கான ஆதாரம். 2. அறிவிப்புக்குப் பிறகு Insurer / TPA, R01 பத்தி 17(c). 3. ₹72,000. 4. முன் அனுப்பியதற்கான பதிவு, வாசிக்கக்கூடிய தன்மை மற்றும் கேள்வியின் சரியான தேவையை உறுதிசெய்தல்.

Advisor Checklist

• Claim Reference மற்றும் காலவரிசை உள்ளனவா?

• மருத்துவம், செலவு, வங்கி விவரங்கள் சரியான நபருடன் பொருந்துகின்றனவா?

• Hospital ஆவணச் சேகரிப்புப் பொறுப்பு தெளிவுபடுத்தப்பட்டதா?

• தீர்வுக் கடிதமும் வங்கியில் வந்த தொகையும் ஒப்பிடப்பட்டனவா?

• தனியுரிமை, சம்மதம் மற்றும் ஆவணப் பாதுகாப்பு பராமரிக்கப்பட்டனவா?

ஆதாரம்: R01 பத்தி 17; P01–P04 Claims Procedure. குறிப்பிட்ட Claim-ன் நடைமுறைக்கும் காலக்கெடுக்கும் தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதலைப் பாருங்க.

அத்தியாயம் 12

Claim மறுத்தால் அடுத்து என்ன செய்யலாம்

Claim Rejection & Grievance Handling

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Rejection message வந்ததும் பதற்றமாகப் பதில் சொல்லாமல் reason-ஐப் பார்க்கப் பழகலாம். Policy limit காரணமா, record mistake-ஆ, continuity விடுபட்டதா என்று documents-உடன் பிரிக்கணும். சரியான review request, insurer grievance, IRDAI complaint, Ombudsman வழிகளை இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம்.

முதலில் கடிதத்தைப் படியுங்கள்

“Claim Rejected” என்ற message மட்டும் பார்த்து முடிவு செய்யாதீங்க. Full rejection-ஆ, ஒரு deduction-ஆ, Cashless மட்டும் மறுத்தார்களா, இன்னும் details pending-ஆ என்று பாருங்க. R01 பத்தி 17-ல் rejection/partial payment reason-உம் குறிப்பிட்ட policy clause-உம் சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்கு. உரிய Claims Review Committee / Product Management Committee approval பற்றிய விதியும் உள்ளது.

முதல் பதிலிலேயே யாரையும் குற்றம் சொல்லாதீங்க; “நான் கண்டிப்பா வாங்கித் தர்றேன்” என்றும் சொல்ல வேண்டாம். “Letter, policy, medical records ஒப்பிட்டுப் பார்த்து அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு முடிவு செய்வோம்” என்று ஆரம்பிக்கலாம்.

சிம்பிளாக

மூன்று கேள்விகள் கேளுங்க. Company எந்த rule சொல்கிறது? அதற்கு என்ன evidence இருக்கு? Customer-கிட்ட வேறுபட்ட உண்மையை நிரூபிக்கும் record இருக்கிறதா? கோபமாக நீண்ட message எழுதுவதைவிட இந்த மூன்றுக்கும் தெளிவான பதில் அதிகம் உதவும்.

பொதுவான காரணங்கள்

காரணம்	ஆய்வு செய்ய வேண்டியது	சரியான அடுத்த செயல்
Waiting முடியவில்லை	தொடக்க நாள், தொடர்ச்சி, பொருந்தும் நோய்	பழைய Policy மற்றும் மாற்றக் கிரெடிட் காட்டுதல்
முன்பிருந்த நோய் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை	Proposal, மருத்துவ வரலாறு, கேள்வியின் வடிவம்	உண்மையான வெளிப்படுத்தல் ஆதாரம் அளித்தல்

காரணம்	ஆய்வு செய்ய வேண்டியது	சரியான அடுத்த செயல்
விலக்கப்பட்ட சிகிச்சை	துல்லியமான விலக்குப் பிரிவு	மருத்துவ உண்மையும் பிரிவும் பொருந்துகிறதா ஆய்வு
Hospital அனுமதி அவசியம் பற்றிய கேள்வி	மருத்துவரின் காரணம், பதிவுகள்	மருத்துவரிடமிருந்து உண்மையான விளக்கம்
Sub-limit / சொந்தச் செலவுப் பங்கு	Schedule மற்றும் கணக்கு	கணக்குப் பிழை இருந்தால் திருத்தம் கோருதல்
ஆவணச் சிக்கல்	நிலுவைத் தேவை, முன் அனுப்பிய பதிவு	காணாத தகவலை அடையாளம் கண்டு ஒருங்கிணைத்தல்

நோயின் பெயர் மட்டும் பார்த்து rejection சரி என்று சொல்ல முடியாது. Timeline, diagnosis date, பழைய advice, தற்போதைய treatment-ன் தொடர்பு எல்லாம் முக்கியம். அதேபோல் பல வருடம் premium கட்டியதால் எல்லா exclusions-உம் நீங்கிவிடாது.

மறுபரிசீலனைக் Claim-ஐ அமைத்தல்

Review letter முதல் paragraph-ல் policy number, claim reference, amount, decision date, என்ன review கேட்கிறோம் என்று எழுதுங்க. அடுத்து rejection reason. பிறகு எந்த document அந்த முடிவை மறுபரிசீலிக்க உதவுகிறது என்று date-உடன் சொல்லுங்க. தேவையில்லாத recipients-க்கு முழு medical history அனுப்பாதீங்க.

பயிற்சி மாதிரி: “Claim எண் ... தொடர்பான ... தேதியிட்ட முடிவை மறுபரிசீலிக்கக் கோருகிறோம். கடிதத்தில் PED Waiting முடியவில்லை எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இணைக்கப்பட்ட முந்தைய Policies மற்றும் Portability Endorsement-இல் ... முதல் தொடர்ச்சிப் பாதுகாப்பு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கிரெடிட் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதைத் தெளிவுபடுத்தி, பொருந்தும் பிரிவுடன் திருத்தப்பட்ட முடிவை வழங்கவும்.”

Sample letter-ன் blanks-ஐ actual records வைத்துத்தான் நிரப்பணும். புதிய diagnosis உருவாக்கவோ medical history மாற்றவோ கூடாது. மிரட்டல் அல்லது நிரூபிக்க முடியாத accusations சேர்ப்பது claim review-க்கு உதவாது.

குறைதீர்ப்பு வழிமுறை

நிலை	அணுகுமுறை	வைத்திருக்க வேண்டிய பதிவு
நிறுவனச் சேவை / Claims குழு	தெளிவான விளக்கம் அல்லது திருத்தம் கோருதல்	தொடர்பு எண், பதில்
Grievance Redressal Officer	முறையான எழுத்தில் உள்ள புகார்	புகார் எண், அனுப்பிய நாள், ஆதாரங்கள்
IRDAI Bima Bharosa	பொருந்தும் புகாரைப் பதிவு செய்து கண்காணித்தல்	அதிகாரப்பூர்வ பதிவு மற்றும் நிலை
Insurance Ombudsman	தகுதி மற்றும் காலவரம்பிற்கு உட்பட்டு அணுகுதல்	முன் புகார், பதில் / பதிலின்மை, Claim
பிற சட்ட வழிகள்	சூழலுக்கேற்ற சுயாதீன சட்ட ஆலோசனை	காலவரம்பு மற்றும் வழக்கின் நிலை

Bima Bharosa-ல் complaint போட்டுவிட்டால் claim pay செய்ய order வந்துவிட்டது என்று அர்த்தம் இல்லை. ஒவ்வொரு அமைப்பின் role என்ன என்று விளக்கணும். ஒரே விஷயத்தை ஒரே நேரத்தில் பல forums-க்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு restrictions இருக்கலாம். Legal advice தேவைப்பட்டால் advisor தன் வரம்பை உணர்ந்து செயல்படணும்.

Ombudsman தகுதியைச் சரிபார்த்தல்

முதலில் insurer அல்லது பொருந்தும் intermediary-க்கு written complaint கொடுக்கணும். பதில் திருப்தியில்லையென்றால் அல்லது 30 நாட்களில் பதில் இல்லையென்றால் உரிய Ombudsman அலுவலகத்தை அணுகலாம். பயன்படுத்திய CIO guidance-ல் claim + expenses சேர்த்து ₹50 லட்சத்தை மீறாத limit-உம் பொதுவாக ஒரு வருட time limit-உம் உள்ளது. அந்த ஒரு வருடம் எந்த நாளிலிருந்து என்பதைக் case-க்கு ஏற்ப சரிபார்க்கணும். தற்போதைய நடைமுறையையும் உறுதி செய்யுங்க. [R02]

இதே matter court, consumer forum, arbitrator முன் pending-ஆ அல்லது ஏற்கெனவே முடிந்ததா என்றும் பார்க்கணும். Ombudsman complaint-க்கு fee இல்லை. Current jurisdiction, procedure check செய்து customer signature அல்லது உரிய authorisation-உடன் செயல்படுங்க. Outcome guarantee சொல்லாதீங்க.

கற்பனை வழக்கு: தொடர்ச்சி கணக்கில் விடுபட்ட ஆண்டு

மீனாவுக்கு புதிய insurer-ல் இரண்டாவது வருட claim. “36 மாத waiting முடியவில்லை” என்று letter வருகிறது. ஆனால் பழைய insurer-ல் இரண்டு வருட policies-உம் portability record-உம் இருக்கு. பழைய SI, புதிய SI, transferred credit, இந்த claim-ன் பகுதி எல்லாம் ஒப்பிடணும். Eligible credit விடுபட்டிருந்தால் review கேட்கலாம். புதிய increased SI-க்கும் அதே credit கிடைக்கும் என்று ஊகிக்க வேண்டாம்.

உரையாடல்

Customer: “இது மோசடி. உடனே முழுப் பணம் வாங்கித் தருங்கள்.”
Advisor: “இந்த முடிவால் உங்களுக்கு சிரமம் இருக்குன்னு புரிகிறது. முதலில் எந்த clause, என்ன evidence என்று பார்ப்போம். தவறு இருந்தால் documents வைத்து review-க்கும் grievance-க்கும் உதவுறேன். Final outcome-ஐ முன்னாடியே உறுதி சொல்ல முடியாது.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

காலவரம்பைத் தவறவிடுதல், புகார் எண்ணைப் பதிவு செய்யாமை, முழுப் Policy-ஐப் பார்க்காமல் வாதிடுதல், மருத்துவ உண்மையை மாற்றுதல், Moratorium-ஐ எல்லா Exclusions-ஐயும் நீக்கும் விதியாகச் சொல்வது ஆகியவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். உண்மையான மோசடி, ஒப்பந்த வரம்பு மற்றும் Disclosure தொடர்பான பாதுகாப்பு வெவ்வேறு சட்டக் கருத்துகள்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Claim பிரச்சினையில் நல்ல உதவி என்றால் evidence, dates, சரியான complaint route, தெளிவான request. Customer-க்காக உறுதியாக வேலை செய்வது வேறு; வெற்றிக்கு guarantee கொடுப்பது வேறு.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. Cashless மறுப்புக்கும் Claim Repudiation-க்கும் வேறுபாடு என்ன? 2. Rejection letter-ல் எந்தத் தகவல் அவசியம்? 3. Ombudsman-க்கு முன் நிறுவனத்திடம் என்ன செய்யணும்? 4. பழைய தொடர்ச்சி விடுபட்ட வழக்கில் எந்த ஆவணங்கள் உதவும்?
பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. பணம் செலுத்தும் வசதி மறுப்பு மற்றும் ஒப்பந்தக் Claim முடிவு வேறுபடலாம். 2. காரணமும் குறிப்பிட்ட Policy-ப் பிரிவும். 3. எழுத்தில் உள்ள புகார்; பதில் / 30 நாள் நிலையைப் பார்க்கணும். 4. பழைய Policies, Renewal ஆதாரங்கள், Portability Endorsement, தொகை விவரம்.

Advisor Checklist

- முழுக் கடிதமும் பொருந்தும் பிரிவும் பெறப்பட்டனவா?
- உண்மையான காலவரிசை உருவாக்கப்பட்டதா?
- கோரப்படும் திருத்தம் தெளிவாக உள்ளதா?
- புகார் எண், காலவரம்பு, அதிகார வரம்பு பதிவாகியுள்ளனவா?
- Customer-ன் அனுமதியும் தனியுரிமையும் பாதுகாக்கப்பட்டனவா?

ஆதார வழிகாட்டி: R01 பத்தி 17; R02 Council for Insurance Ombudsmen Procedure / FAQs, சரிபார்ப்பு 10-10-2026; Bima Bharosa அதிகாரப்பூர்வ தளம் https://bimabharosa.irdai.gov.in/.

அத்தியாயம் 13

IRDAI விதிகள் Customer-க்கு என்ன பாதுகாப்பு

IRDAI Regulations & Policyholder Protection

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

IRDAI rule-உம் ஒரு product condition-உம் எப்படி வேறு என்று புரிஞ்சுக்கலாம். Waiting, continuity, moratorium, renewal, claims பற்றி source-உடன் பதில் சொல்லப் பழகலாம். புதிய தகவல் உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால் “சரிபார்க்கணும்” என்று சொல்லவும் தெரியணும்.

விதிகள் எந்த அடுக்கில் வருகின்றன?

IRDAI காப்பீட்டுத் துறையின் regulator. Regulations, circulars மூலம் insurer பொறுப்புகளும் policyholder பாதுகாப்புகளும் சொல்லப்படுகின்றன. Product wording-ல் அந்த plan benefits, limits, process இருக்கும். Schedule-ல் customer தேர்ந்தெடுத்த SI, members, options இருக்கும். Endorsement-ல் ஏற்றுக்கொண்ட மாற்றம் இருக்கும். எல்லாமே ஒரே document இல்லை.

ஒரு product-ல் 24 மாத waiting இருப்பதால் எல்லா plans-க்கும் 24 மாதம் என்று அர்த்தம் இல்லை. Regulatory maximum 36 மாதம் என்பதால் எல்லா policies-லும் 36 மாதம் இருக்கணும் என்றும் இல்லை. Plan குறைவான waiting கொடுக்கலாம். இந்த வித்தியாசத்தை customer-க்கு சொல்லணும்.

ஆதாரமும் சரிபார்ப்புத் தேதியும்

இந்த அத்தியாயத்தின் அடிப்படை ஆவணங்கள்: 22-03-2024 IRDAI Insurance Products Regulations, Schedule III [R03], 29-05-2024 Health Master Circular [R01], Ombudsman-க்கான CIO guidance [R02]. இவை 10-10-2026 அன்று பெறப்பட்டதாக முந்தைய ஆய்வுப் பதிவு சொல்கிறது. இந்த மொழிநடைப் பதிப்பில் அவை புதிதாக மீண்டும் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகக் கருத வேண்டாம்.

ஒரு முக்கிய வரம்பு: 2025–2026-ல் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா amendments-உம் முழுமையாக உறுதி செய்யப்பட்டதாக இந்த நூல் கூறவில்லை. “புதிய premium rule” அல்லது “புதிய claim timing” என்று customer-கிட்ட சொல்லும் முன் official document, date, applicability பார்க்கணும். இணையத்தில் “2026 rules” என்று title இருப்பது மட்டும் புதிய சட்டத்துக்கான proof இல்லை.

சிம்பிளாக

Regulatory rules policyholder-க்கு அடிப்படைப் பாதுகாப்பு தருகின்றன. Policy-ல் customer வாங்கிய குறிப்பிட்ட cover இருக்கும். Rule இருக்கிறது என்பதால்

ஒவ்வொரு நோயும் செலவும் automatic-ஆக cover ஆகாது. அதேபோல் brochure சுருக்கத்தை வைத்து policyholder rights-ஐக் குறைத்தும் சொல்ல முடியாது.

Waiting-உம் முன்பிருந்த நோயும்

R03 Schedule III பிரிவு 7-ல் disclosed PED-க்கான waiting, continuous cover-ல் அதிகபட்சம் 36 மாதங்கள் என்று இருக்கு; Overseas Travel exception தனியாக உள்ளது. அதே Schedule definition-ல் Specific Waiting Period-க்கும் அதிகபட்சம் 36 மாதங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Product குறைவான waiting கொடுத்தால் அந்த product rule-ஐப் பார்க்கணும்.

PED definition-ன் 36 மாத look-back-உம் 36 மாத waiting-உம் ஒன்று இல்லை. Look-back policy-க்கு முந்தைய medical history பற்றி. Waiting policy தொடங்கிய பிறகு cover-க்காகக் காத்திருப்பது. Proposal கேட்கும் full history சொல்லணும். “36 மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததைச் சொல்ல வேண்டாம்” என்று advice கொடுக்காதீங்க.

Moratorium: 60 மாதத் தொடர்ச்சியின் பொருள்

60 continuous months-க்குப் பிறகு non-disclosure அல்லது misrepresentation காரணமாக policy/claim-ஐ contest செய்ய முடியாது; established fraud exception இருக்கு. Portability/migration continuity-யும் சேரும். SI உயர்த்திய கூடுதல் பகுதிக்கு, உயர்த்திய நாளிலிருந்து தனி 60 மாத கணக்கு வரும். [R03 Schedule III பிரிவு 8; R01 பத்தி 13]

₹5 லட்சம் policy ஐந்து வருடம் தொடர்ந்து இருந்தது; இப்போது ₹10 லட்சமாக உயர்த்துகிறோம் என்று வைத்துக்கலாம். பழைய ₹5 லட்சத்தின் clock-உம் கூடுதல் ₹5 லட்சத்தின் clock-உம் ஒன்றல்ல. Old five years increased portion-க்கும் தானாகப் பொருந்தாது. Moratorium என்பது SI limit, exclusions, treatment eligibility, cost sharing எல்லாவற்றையும் நீக்கும் rule இல்லை.

Renewal உரிமையும் அதன் வரம்பும்

முன்னாடி claim செய்தார் என்ற காரணத்துக்காக மட்டும் renewal மறுக்கக் கூடாது. SI மாறாமல் renew செய்யும்போது fresh medical underwriting செய்யக் கூடாது என்ற protection இருக்கு. SI அதிகரித்தால் increased portion-க்கு assessment இருக்கலாம். Product withdraw செய்தால் appropriate alternative வழங்கணும். Fraud, பொருந்தும் legal exceptions தனியாக உள்ளன. [R01 பத்தி 10; R03 பிரிவு 9]

Renew செய்ய முடியும் என்றால் premium எப்போதும் மாறாது என்று அர்த்தம் இல்லை. Individual claim experience-க்கு personal loading என்பதும் portfolio-level price revision என்பதும் வேறு. Applicable official notice பார்த்துதான் premium change விளக்கணும்; உறுதியாகத் தெரியாத percentage சொல்லாதீங்க.

Grace Period: தொடர்ச்சியும் பாதுகாப்பும் வேறு

R01 பத்திகள் 8–9-ல் monthly instalment-க்கு 15 நாள்; quarterly, half-yearly, annual payment-க்கு 30 நாள் grace குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்குள் renew செய்தால் earned continuity credits பாதுகாக்கப்படும். Policy term-க்குள் instalment payment-ன் grace period-லும்கூட cover கிடைக்கும் என்று circular தனியாகச் சொல்கிறது.

இதை annual policy expire ஆன பிறகு payment செய்யாத எல்லா gap-க்கும் cover என்று விரிவுபடுத்தாதீங்க. Expiry-க்கும் renewal-க்கும் நடுவில் admission வந்தால் schedule-உம் applicable rule-உம் பார்த்து உறுதி செய்யணும். Due date-க்கு முன்னாடியே renew செய்வது நல்ல நடைமுறை.

Portability மற்றும் Migration

வேறு insurer-க்கு மாறுவது Portability. அதே insurer-ன் வேறு plan-க்கு மாறுவது Migration. Applicable indemnity policies-ல் old SI, benefits தொடர்பான continuity credits மாற்றப்படலாம். புதிய insurer assessment-உம் புதிய conditions-உம் பொருந்தும். பழைய features அனைத்தும் அப்படியே தொடரும் என்று சொல்லாதீங்க.

R01 பத்தி 12-ல், புதிய insurer கேட்கும் தகவலை பழைய insurer அதிகபட்சம் 72 மணி நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டும். அந்தத் தகவல் பெற்றபின் புதிய insurer அதிகபட்சம் ஐந்து நாட்களில் முடிவு சொல்ல வேண்டும். இதனால் portability application முழுவதும் எப்போதும் ஐந்து நாளில் முடிந்துவிடும் என்று அர்த்தம் இல்லை.

பிற முக்கிய Policyholder பாதுகாப்புகள்

பாதுகாப்பு	நடைமுறை விளக்கம்
Customer Information Sheet	முக்கிய விதிகளின் சுருக்கம்; கேட்டால் உள்ளூர் மொழியில் கிடைக்க வேண்டும்
Free Look	ஓராண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலப் Policy-க்கு ஆவணம் பெற்றதிலிருந்து 30 நாள் பரிசீலனை; ரத்து மற்றும் திருப்புத் தொகை விதிகளைப் பாருங்க
Cashless முடிவு	Claim பெற்றதிலிருந்து அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரம்; முடிவு என்பது கட்டாய ஒப்புதல் அல்ல

பாதுகாப்பு	நடைமுறை விளக்கம்
இறுதி விடுவிப்பு அனுமதி	Hospital Claim பெற்றதிலிருந்து மூன்று மணி நேரம்; தாமதச் செலவுக்கான விதி உள்ளது
Hospital ஆவணங்கள்	அறிவிப்புக்குப் பிறகு Insurer / TPA சேகரிக்கும் பொறுப்பு
மூத்த குடிமக்கள் சேவை	Claim மற்றும் குறைகளுக்குத் தனி சேவை வழி அமைக்கப்பட வேண்டும்

வயதும் நோயும் தொடர்பான தவறான பொதுமைப்படுத்தல்கள்

எல்லா வயதினரின் தேவைக்கும் products வழங்க வேண்டும் என்ற regulatory நோக்கம் இருக்கு. ஆனால் ஒவ்வொரு plan-உம் எல்லா வயதையும் underwriting இல்லாமல் ஏற்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் இல்லை. பல PED-களுக்கு cover வழங்க முயல வேண்டும் என்பதும் every application acceptance guarantee இல்லை. Eligibility-யும் assessment-உம் தனியாக விளக்கணும். [R03 Schedule III பிரிவு 6]

தொழில்முறை உரையாடல்

Customer: “ஐந்து வருடம் கட்டிவிட்டால் எல்லா Claim-மும் வரும்தானே?”

Advisor: “60 மாத continuity-க்குப் பிறகு disclosure தொடர்பாக முக்கிய protection இருக்கு; established fraud exception. ஆனா SI, exclusions, treatment conditions தொடரும். உங்க claim-க்கு எந்த clause பொருந்துது என்று பார்க்கலாம்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

Regulatory அதிகபட்சத்தை எல்லாப் Policies-ன் ஒரே விதியாகச் சொல்வது; காலக்கெடு இருப்பதால் கட்டாய ஒப்புதல் என விளக்குதல்; சட்டத் தகவலை தேதியின்றி பகிர்தல்; பழைய சுற்றறிக்கை புதிய திருத்தத்தால் மாறியிருக்கிறதா பார்க்காதது; நிறுவனம் வழங்கிய Schedule-ஐப் புறக்கணித்தல் ஆகியவை தவறுகள். முரண்பாடு இருந்தால் துல்லியமான ஆவணத்துடன் எழுத்தில் clarification வாங்குங்க.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Rules தெரிந்தால் மட்டும் போதாது; அவை எதற்கு பொருந்தும், எதற்கு பொருந்தாது என்பதும் தெரியணும். Continuity, Waiting Period, Moratorium, claim timelines எல்லாம் தனித்தனி விஷயங்கள். Legal rule சொல்லும்போது official source-உம் verification date-உம் இருக்கணும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. PED வரையறையின் பின்நோக்கு காலமும் Waiting-உம் எப்படி வேறுபடும்? 2. அதிகரித்த Sum Insured-க்கு Moratorium எப்போது தொடங்கும்? 3. Grace Period தொடர்ச்சி பாதுகாப்பையும் மருத்துவச் செலவு பாதுகாப்பையும் ஏன் பிரிக்க வேண்டும்? 4. ஒரு மணி நேர Cashless விதி எதை உறுதிசெய்கிறது?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. ஒன்று முன்பிருந்த மருத்துவ நிலை; மற்றொன்று தொடக்கத்திற்குப் பிந்தைய பாதுகாப்புத் தாமதம். 2. அதிகரிப்பு நாளிலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட பகுதிக்கு. 3. தொடர்ச்சி பாதுகாக்கப்படுவது எல்லா செலுத்தாத இடைவெளிகளிலும் Claim Coverage இருப்பதை நிரூபிக்காது. 4. முடிவுக்கான நேரம்; கட்டாய ஏற்றுக்கொள்ளல் அல்ல.

Advisor Checklist

• கூறப்படும் விதியின் ஆவணம், தேதி, பிரிவு உள்ளனவா?

• தயாரிப்பு நிபந்தனை Regulatory-யிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டதா?

• Customer-ன் தொடர்ச்சி மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட தொகை வரலாறு உள்ளதா?

• புதிய மாற்றம் பற்றிய தகவல் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்பட்டதா?

• உறுதியில்லாத தகவல் “சரிபார்ப்பு தேவை” என்று குறிக்கப்பட்டதா?

ஆதாரம்: R01 IRDAI/HLT/CIR/PRO/84/5/2024, 29-05-2024; R03 IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024, Schedule III, அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ்; R02 CIO Procedure. ஆவணங்கள் பெறப்பட்ட நாள் 10-10-2026.

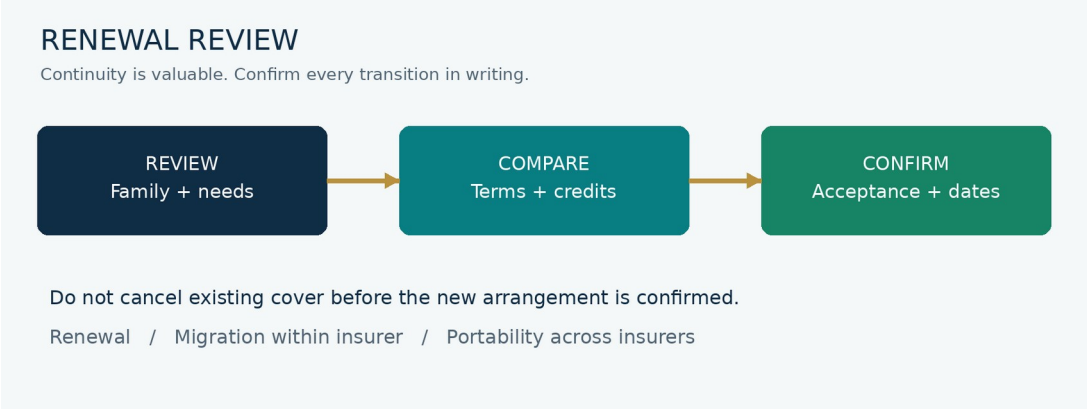
அத்தியாயம் 14

Renewal Portability பழைய பலன்களைப் பாதுகாப்பது

Renewal, Portability & Migration

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Renewal date மறக்காமல் இருப்பதோடு continuity benefits-ஐயும் பாதுகாக்கணும். அதே insurer-க்குள் plan மாற்றுவது, வேறு insurer-க்கு மாறுவது எப்படி வேறு என்று பார்க்கலாம். புதிய policy final acceptance வரும்முன் பழையதை நிறுத்தினால் என்ன பிரச்சினை வரலாம் என்பதையும் புரிஞ்சுக்கலாம்.



படம் 14.1 • தொடர்ச்சியைப் பாதுகாக்கும் மறுபரிசீலனை.

Renewal ஒரு கட்டண நினைவூட்டல் மட்டுமல்ல

Renewal என்பது payment reminder மட்டும் இல்லை. Family members, phone/address, nominee, SI, room preference, office cover, budget எல்லாம் review செய்ய நல்ல நேரம். கடந்த வருட claim இருந்தால் limits போதுமா என்று கற்றுக்கொள்ளலாம்; claim செய்ததால் உடனே company மாற்றணும் என்று முடிவு செய்ய வேண்டாம்.

Payment link வந்ததாலேயே renewal complete இல்லை. Paid receipt, புதிய schedule, சரியான members, அடுத்த cover dates எல்லாம் பார்க்கணும். பணம் கட்டிய பிறகும் வயது தவறாக இருந்தாலோ குழந்தை விடுபட்டிருந்தாலோ உடனே correction கேளுங்க.

சிம்பிளாக

Renewal என்றால் அடுத்த காலத்துக்கு policy தொடர்வது. Migration என்றால் அதே insurer-க்குள் plan மாறுவது. Portability என்றால் வேறு insurer-க்கு மாறுவது. Continuity records மூன்றிலும் முக்கியம். புதிய plan-ன் benefits பழையதின் exact copy ஆக இருக்க வேண்டியதில்லை.

நடைமுறை காலவரிசை

கட்டம்	ஆலோசனைச் செயல்
Renewal-க்கு 60–90 நாட்களுக்கு முன்	குடும்பத் தேவை, Budget, மாற்ற விருப்பம் ஆய்வு
மாற்றம் பரிசீலிக்கும்போது	தற்போதைய விண்ணப்பக் காலவரம்பை நிறுவனத்திடம் உறுதிசெய்தல்
முடிவுக்கு முன்	பழைய / புதிய விதிகள், கிரெடிட்கள், மதிப்பீடு ஒப்பீடு
கட்டண நாளுக்கு முன்	அதிகாரப்பூர்வ Quote, உறுப்பினர்கள், தேதிகள் சரிபார்ப்பு
கட்டணத்திற்குப் பிறகு	ரசீது, Schedule, மாற்ற ஒப்புதல், பாதுகாப்புத் தொடக்கம்
ஆண்டு முழுவதும்	குடும்ப மாற்றம் மற்றும் சேவைத் தேவையைப் பதிவு செய்தல்

இங்கே சொன்ன 60–90 நாள் என்பது service planning suggestion; regulatory application deadline இல்லை. Portability application window-ஐ current official rule, insurer procedure வைத்து check செய்யணும். கடைசி நாளில் ஆரம்பித்தால் details சேகரிக்கவும் underwriting-க்கும் நேரம் குறையும்.

Grace Period-ஐ நம்பித் தாமதிக்க வேண்டாம்

R01 பத்திகள் 8–9-ல் monthly instalment-க்கு 15 நாட்கள், மற்ற குறிப்பிடப்பட்ட payment modes-க்கு 30 நாட்கள் grace period உள்ளது. அதற்குள் renew செய்தால் continuity credits பாதுகாக்கப்படும். ஆனால் annual policy expiry-க்கும் late payment-க்கும் நடுவில் நடந்த treatment தானாக cover என்று சொல்லாதீங்க. Policy term-க்குள் instalment grace cover-க்கு தனி விதி இருக்கு.

Policy மார்ச் 31 முடிகிறது; ஏப்ரல் 10 renew செய்கிறார்; ஏப்ரல் 5 admission என்று வைத்துக்கலாம். Continuity தொடருமா என்பது ஒரு கேள்வி. ஏப்ரல் 5 bill cover ஆகுமா என்பது இன்னொரு கேள்வி. Written clarification இல்லாமல் “30 நாளுக்குள் கட்டினா எல்லாம் வரும்” என்று சொல்லாதீங்க.

மாற்றத்திற்கான காரணத்தை எழுதுங்க

Company மாற்றுவதற்கு room eligibility, விருப்பமான hospital network, family setup, long-term budget போன்ற நல்ல காரணங்கள் இருக்கலாம். Premium மட்டும் குறைவாக இருந்தால் deductible, co-pay, sub-limit, குறைந்த benefits இருக்கிறதா என்று ஒப்பிடணும்.

ஒரே SI வைத்து compare பண்ணுங்க. பழையது ₹10 லட்சம், புதியது ₹5 லட்சம் என்றால் premium குறைவு என்று மட்டும் முடிவு சொல்ல முடியாது. பழைய bonus புதிய policy-ல் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்பதையும் தனியாகக் காட்டுங்க.

ஒப்பீட்டுப் பகுதி	பழைய **Policy**	புதிய முன்மொழிவு
அடிப்படை / Bonus	தற்போதைய Schedule-இலிருந்து	எழுத்தில் உள்ள மேற்கோளிலிருந்து
அறை / சொந்தச் செலவுப் பங்கு	தற்போதைய உரிமை	புதிய விதி
தொடர்ச்சி	தொடங்கிய நாள், இடைவெளி	மாற்றப்படும் கிரெடிட்
மருத்துவ மதிப்பீடு	ஏற்கெனவே உள்ள நிபந்தனை	புதிய முடிவு / நிலுவை
கூடுதல் தொகை	தற்போது இல்லை / உள்ளது	புதிய Waiting / மதிப்பீடு
Hospital	விரும்பும் கிளை	தற்போதைய Network உறுதி

தொடர்ச்சிக் கிரெடிட் எப்படி வேலை செய்கிறது?

Portability மூலம் பழைய insurer-ல் இருந்த காலத்துக்கான eligible credits புதிய insurer-ல் கணக்கில் வரலாம். ஆனால் புதிய policy-ன் எல்லா benefits-க்கும் waiting zero என்று அர்த்தம் இல்லை. Old SI credit, increased SI, புதிய special benefit எல்லாம் தனித்தனியாகப் பார்க்கணும்.

₹5 லட்சம் policy-ல் மூன்று வருட continuity; புதிய plan-ல் ₹10 லட்சம் கேட்கிறார் என்று வைத்துக்கலாம். பழைய ₹5 லட்சத்துக்கு என்ன credit, கூடுதல் ₹5 லட்சத்துக்கு என்ன rule என்று எழுதணும். “மூன்று வருடம் முடிஞ்சதால் ₹10 லட்சமும் day one” என்று சொல்ல முடியாது.

ஏற்றுக்கொள்ளல் உறுதியாவதற்கு முன் பழையதை நிறுத்தாதீங்க

Apply செய்தது, medical test முடிந்தது, premium estimate வந்தது இவையெல்லாம் final acceptance இல்லை. Final conditions, premium, members, continuity credit, start date உறுதி செய்யணும். Transfer தாமதமானால் பழைய cover தொடரும் வழியை சரியான நேரத்தில் insurer-உடன் பேசுங்க.

Portability-யிலும் old claims, medical history மறைக்கக் கூடாது. பழைய company-க்கு தெரியும் என்பதால் புதிய form-ல் கேட்கும் details விட்டுவிட வேண்டாம். Customer படித்து சரி என்று உறுதி செய்த பிறகுதான் submit செய்யணும்.

உரையாடல்

Customer: “நிறுவனத்தை மாற்றினால் பழைய வருடங்கள் வீணா?”

Advisor: “பொருந்தும் continuity credits-ஐ மாற்ற வசதி இருக்கு. எந்த amount-க்கு எந்த benefit-க்கு கிடைக்குதுன்னு புதிய company written record-ல் பார்த்து உறுதி செய்வோம்.”

Customer: “புதியது மலிவு; பழையதை இன்றே ரத்து செய்யலாமா?”

Advisor: “முதலில் புதிய company final acceptance, start date, conditions எல்லாம் உறுதி செய்வோம். Cover-ல் gap வராமல் மாற்றணும்; அதற்கு முன்னாடி பழையதை cancel பண்ண வேண்டாம்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

மாற்றத்தை புதிய விற்பனையாக மட்டும் பார்க்குதல்; பழைய ஆவணங்களைச் சேமிக்காதது; ஏற்கெனவே உள்ள Exclusions-ஐப் புதிய திட்டம் நீக்கிவிடும் என ஊகித்தல்; உறுதிப்படுத்தப்படாத காலக்கெடுவைக் சொல்வது; இறுதி Schedule வரும்முன் பழைய பாதுகாப்பை ரத்து செய்தல் ஆகியவை தவறுகள். ஒவ்வொரு புதுப்பிப்பிலும் புதிய மருத்துவ மதிப்பீடு கட்டாயம் என்ற தவறான விளக்கத்தையும் தவிர்க்கணும்; தொகை உயர்வு மற்றும் பொருந்தும் விதிவிலக்குகளைத் தனியாகப் பாருங்க.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Renewal continuity-ஐப் பாதுகாக்கிறது. Migration, portability வேறு options கொடுக்கின்றன. முன்பே review செய்து, சரியாக compare செய்து, gap இல்லாமல் முடிப்பதுதான் நல்ல service. “Company மாறிட்டோம்” என்பதோடு எந்த benefits தொடர்கின்றன என்பதும் customer-க்கு தெரியணும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. Migration மற்றும் Portability வேறுபாடு? 2. புதிய நிறுவனத்திற்கு விண்ணப்பித்ததும் பழையதை ரத்து செய்யலாமா? 3. ₹5 லட்சத்திலிருந்து ₹10 லட்சமாக மாற்றும்போது தனியாகச் சரிபார்க்க வேண்டியது? 4. Grace Period குறித்த தவறான வாக்குறுதியைச் சரியான வாக்கியமாக மாற்றுங்க.

பதில் சரியா பார்ப்போம்: 1. அதே நிறுவனம் / வேறு நிறுவனம். 2. இல்லை; இறுதி ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் தேதிகள் உறுதியாக வேண்டும். 3. கூடுதல் ₹5 லட்சத்திற்கான மதிப்பீடு, Waiting மற்றும் Moratorium. 4. தொடர்ச்சிக் கிரெடிட் மற்றும் இடைவெளிக் கால Coverage தனித்தனியாக உறுதிசெய்யப்பட வேண்டும்.

Advisor Checklist

• முன்கூட்டிய Renewal ஆய்வு நடந்ததா?

• புதிய குடும்ப / Nominee விவரங்கள் சரியா?

• பழைய மற்றும் புதிய விதிகள் ஒரே அளவில் ஒப்பிடப்பட்டனவா?

• தொடர்ச்சிக் கிரெடிட் எழுத்தில் உறுதிசெய்யப்பட்டதா?

• புதிய Schedule மற்றும் கட்டண ரசீது Customer-கிட்ட உள்ளனவா?

ஆதாரம்: R01 பத்திகள் 8–13; R03 Schedule III பிரிவுகள் 9–10; பொருந்தும் P01–P04 Renewal, Migration, Portability விதிகள்.

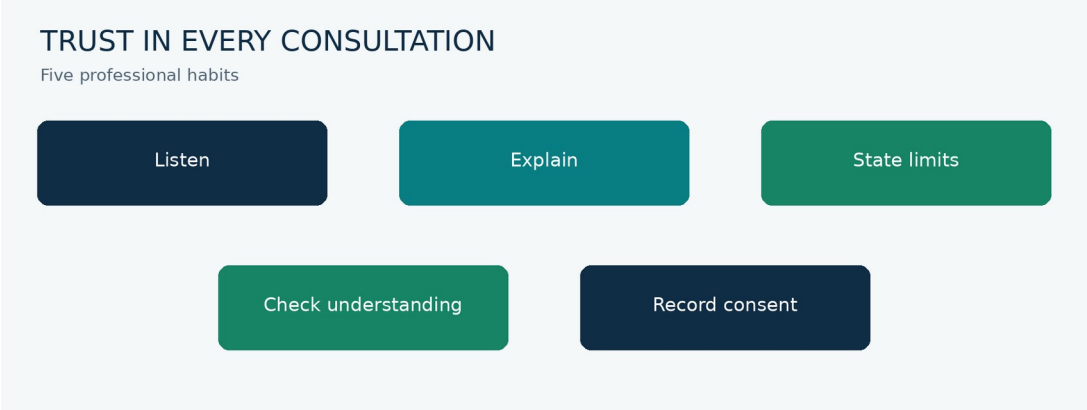
அத்தியாயம் 15

Customer-கிட்ட இயல்பாகப் பேசலாம்

Professional Customer Communication

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Customer கேள்வி கேட்கும்போது உடனே technical answer சொல்ல வேண்டியதில்லை. அவருடைய கவலை என்ன என்று கேட்கவும், சிக்கலான விஷயத்தை எளிமையாகச் சொல்லவும் இந்த அத்தியாயத்தில் பழகலாம். உறுதியில்லாததை guarantee-ஆகச் சொல்லாமல், அவருக்குப் புரிந்ததா என்று தெரிந்துகொள்வதும் முக்கியம்.



படம் 15.1 • நம்பகமான உரையாடலின் ஐந்து பழக்கங்கள்.

விளக்குவதற்கு முன் கேளுங்க

“Claim வருமா?” என்ற கேள்விக்குப் பின்னால் பல கவலைகள் இருக்கலாம். Company-ஐ நம்பலாமா, பெரிய bill வந்தால் என்ன செய்வது, பழைய அனுபவம் மீண்டும் வருமா என்று நினைக்கலாம். Benefits list சொல்லத் தொடங்காமல் “உங்களுக்கு எந்த situation பற்றி அதிகக் கவலை?” என்று கேளுங்க. அவர் முடிக்கும் வரை கேட்டு, புரிந்ததைச் சுருக்கமாகத் திரும்பச் சொல்லுங்க.

ஒரு நேரத்தில் ஒரு விஷயம் போதும். Term, எளிய அர்த்தம், ஒரு example, அதன் limit என்ற வரிசையில் பேசலாம். Co-pay விளக்கும்போதே deductible, restoration, bonus எல்லாத்தையும் சேர்த்தால் customer குழம்பிவிடுவார்.

சிம்பிளாக உரையாடல் அமைப்பு

கட்டம்	பயன்படும் வாக்கியம்
கேள்	“உங்க குடும்பத்தில் யாருக்குப் பாதுகாப்பு தேவை?”

கட்டம்	பயன்படும் வாக்கியம்
தெளிவாக்கு	“நீங்க சொல்வது ஆண்டு கட்டணமா, Hospital நேரச் செலவா?”
விளக்கு	“இதன் பொருள்... ஒரு எடுத்துக்காட்டைப் பார்ப்போம்.”
வரம்பைக் கூறு	“ஆனால் இந்த நிபந்தனையும் பொருந்தும்.”
புரிதலை உறுதிசெய்	“இந்தச் சூழலில் உங்க செலவு எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல முடியுமா?”
பதிவு செய்	“நாம் ஒப்புக்கொண்ட தேவைகளையும் நிலுவைக் கேள்விகளையும் அனுப்புகிறேன்.”

Customer கேட்கும் 30 கேள்விகள் பதில் சொல்லிப் பழகலாம்

1. “நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன்; இப்போது ஏன் காப்பீடு?”

“இப்போ health நல்லா இருப்பது நல்ல விஷயம். எதிர்பாராத medical expense வந்தால் எப்படி சமாளிப்பது, cover-ஐ எப்படி தொடர்ந்து வைத்திருப்பது என்று திட்டமிடலாம். உங்க family need-உம் budget-உம் பார்த்து முடிவு செய்வோம்.”

2. “எந்தத் திட்டம் சிறந்தது?”

“எல்லாருக்கும் ஒரே best plan இல்லை. உங்க குடும்பம், medical history, hospital preference, budget வைத்து இரண்டு பொருத்தமான options பார்க்கலாம். ஏன் அந்த option சொல்றேன், என்ன limits இருக்குன்னும் எழுதி விளக்குறேன்.”

3. “Premium என்பது என்ன?”

“Insurance cover-க்காக நீங்க கட்டும் amount-தான் premium. அது savings account-ல் சேரும் பணம் இல்லை. Premium எவ்வளவு என்பதோடு cover என்ன, claim நேரத்தில் உங்க செலவு என்ன என்பதையும் பார்க்கணும்.”

4. “Sum Insured முழுவதையும் எனக்குத் தருவார்களா?”

“Indemnity policy-ல் அது eligible medical expense-க்கான limit. செலவு குறைவாக இருந்தால் அதற்கேற்ற claim-தான் வரும். Fixed benefit policy-ல் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு நிர்ணயித்த amount தரும் முறை வேறு.”

5. “Family Floater-இல் ஒவ்வொருவருக்கும் ₹10 லட்சமா?”

“பொதுவாக family-ல் policy-ல் உள்ளவர்கள் ஒரே ₹10 லட்சத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வாங்க. ஒருத்தர் பயன்படுத்தினால் மற்றவர்களுக்கு மீதி குறையலாம். Restoration இருந்தால் அதன் rules-ஐயும் பார்ப்போம்.”

6. “Co-payment என்றால்?”

“Policy ஏற்கும் claim amount-ல் நீங்க கட்டும் percentage-தான் co-pay. Example-க்கு admissible amount ₹2 லட்சம், co-pay 10% என்றால் ₹20,000 உங்க பங்கு. Cover ஆகாத மற்ற expenses இருந்தால் அவையும் சேரலாம்.”

7. “Deductible-மும் Co-payment-மும் ஒன்றா?”

“இல்லை, ரெண்டும் வேறு. Deductible என்பது இந்த policy pay செய்வதற்கு முன் நீங்க அல்லது வேற cover மூலம் சமாளிக்க வேண்டிய threshold. Co-pay ஒரு percentage. ரெண்டும் இருந்தால் எந்த order-ல் கணக்கிடணும்னு policy பார்த்து விளக்குறேன்.”

8. “₹5 லட்சம் போதுமா?”

“உங்க hospital preference, family size, ஒரே வருடத்தில் பல claims வந்தால் என்ன ஆகும், savings என்ன என்று பார்க்கலாம். ₹5, ₹10, ₹20 லட்சத்தில் ஒரே sample expense-ஐ வைத்துக் கணக்கிட்டால் வித்தியாசம் புரியும்.”

9. “Cashless என்றால் பணமே தேவையில்லையா?”

“Cashless-ல் eligible செலவை company நேராக hospital-க்குக் கொடுக்கும். ஆனா co-pay, exclusions, limit-க்கு மேலான செலவு அல்லது deposit இருக்கலாம். Final breakup-ல்தான் உங்க செலவு தெளிவாகத் தெரியும்.”

10. “எந்த Hospital-யிலும் Cashless கிடைக்குமா?”

“Hospital-ன் சரியான branch-உம் தற்போதைய arrangement-உம் check செய்யணும். Non-network-ல் தனி arrangement இருக்கலாம்; முன்பே confirm செய்யாமல் Cashless கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது.”

11. “முன்பிருந்த நீரிழிவைச் சொல்ல வேண்டுமா?”

“ஆமாம். Form கேட்கும் medical details-ஐ முழுசாக உண்மையாகச் சொல்லணும். எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க, என்ன medicine, என்ன reports இருக்குன்னும் கேட்கலாம். Company மதிப்பிட்டு acceptance-உம் conditions-உம் சொல்லும்.”

12. “மருந்து நிறுத்திவிட்டேன்; பழைய நோயைச் சொல்ல வேண்டாமா?”

“Medicine நிறுத்தினாலும் old treatment history இருக்குமே. Form எந்தக் காலத்தைப் பற்றி என்ன கேட்குதோ அதற்குச் சரியான பதில் சொல்லணும். Doubt இருந்தால் எழுத்தில் disclose செய்து company clarification வாங்கலாம்.”

13. “மருத்துவப் பரிசோதனை செய்தால் எல்லா தகவலும் நிறுவனத்திற்குத் தெரிந்துவிடுமா?”

“Tests எல்லா பழைய treatment details-ஐயும் காட்டாது. நீங்க சொல்லும் medical history-உம் test results-உம் இரண்டுமே முக்கியம். Test எடுத்ததால் proposal-ல் details சொல்ல வேண்டாம்னு அர்த்தம் இல்லை.”

14. “Waiting Period முடிந்தால் எல்லா நோயும் வருமா?”

“அந்த waiting முடிந்திருக்கும். ஆனா exclusions, sub-limits, ஏற்றுக்கொண்ட medical conditions, available cover எல்லாம் தொடர்ந்து பொருந்தும். குறிப்பிட்ட treatment-க்கு எந்த clause என்று பார்க்கலாம்.”

15. “விபத்துக்கு முதல் நாளிலிருந்து பாதுகாப்பா?”

“பல policies-ல் initial illness waiting-க்கு accident exception இருக்கு. ஆனா accident policy period-க்குள் நடந்ததா, definition-க்கு பொருந்துதா, வேறு conditions இருக்கா என்பதையும் பார்க்கணும். உங்க plan-ல் என்ன rule என்று உறுதி செய்வோம்.”

16. “மகப்பேறுச் செலவு முழுவதும் வருமா?”

“முதலில் maternity benefit இருக்கா, base cover-லா add-on-லா, waiting எவ்வளவு, amount limit என்ன என்று பார்க்கணும். SI பெரியதாக இருந்தாலும் delivery-க்கு தனி சிறிய limit இருக்கலாம்.”

17. “பிறந்த குழந்தை தானாகச் சேருமா?”

“Newborn-க்கு ஆரம்ப cover-உம் அடுத்த renewal-ல் member-ஆகச் சேர்ப்பதும் வேறாக இருக்கலாம். எப்போ intimate செய்யணும், எப்படி add செய்யணும், premium என்ன என்று அந்த plan-ன் விதியைப் பார்ப்போம்.”

18. “Room Rent வரம்பு ஏன் முக்கியம்?”

“நீங்க எடுக்கக்கூடிய room category அல்லது daily amount limit அது. அதைவிட அதிக room எடுத்தால் room difference மட்டும் இல்லாமல் தொடர்புடைய சில charges-லும் deduction வரலாம். ICU rule, exceptions-ஐயும் தனியாகப் பார்க்கணும்.”

19. “Restoration இருந்தால் தொகை தீரவே தீராதா?”

“Restoration குறிப்பிட்ட conditions-ல் cover-ஐ மீண்டும் தரும் வசதி. அதே claim-க்கா, next admission-க்கா, அதே illness-க்கா என்று rules இருக்கலாம். முதல் claim-க்கே unlimited money கிடைக்கும் என்று நினைக்க வேண்டாம்.”

20. “No Claim Bonus பணமாகத் திரும்புமா?”

“Plan-ஐப் பொறுத்து extra SI அல்லது premium discount மாதிரி இருக்கலாம். எவ்வளவு சேரும், எப்போ கிடைக்கும், claim செய்தால் என்ன ஆகும் என்று பார்க்கணும். Premium பணமாகத் திரும்பும் என்று பொதுவாகச் சொல்ல முடியாது.”

21. “நிறுவனக் குழுக் காப்பீடு இருக்கு; தனியாக வேண்டுமா?”

“Office cover-ல் amount, members, வேலை மாறினால் end date, continuity options என்ன என்று பார்க்கலாம். அதில் இருக்கும் gap-உம் உங்க budget-உம் வைத்துதான் தனி policy தேவையா என்று முடிவு செய்யணும்.”

22. “எல்லா Consumables-மும் வருமா?”

“எந்த items list cover, எந்த option எடுத்திருக்கீங்க என்று பார்க்கணும். Consumables cover இருந்தால் எல்லா non-medical expense-உம் வந்துவிடாது. Bill item-உம் policy list-உம் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.”

23. “OPD மருந்துகளும் வருமா?”

“Hospital cover இருப்பதால் OPD automatic-ஆக cover ஆகாது. தனி OPD benefit இருந்தால் limit, eligible expenses, எப்படி use செய்யணும் என்று பார்க்கணும். Doctor prescription மட்டும் coverage-க்கு போதாது.”

24. “Claim செய்தால் அடுத்த ஆண்டு புதுப்பிக்க மறுப்பார்களா?”

“Claim செய்த காரணத்துக்காக மட்டும் renewal மறுக்கக் கூடாது. பொருந்தும் exceptions, product change process தனியாக இருக்கலாம். Premium மாறுமா என்பது வேற கேள்வி; official renewal notice பார்க்கணும்.”

25. “நிறுவனத்தை மாற்றினால் Waiting மீண்டும் தொடங்குமா?”

“Portability மூலம் eligible waiting credits மாற்றலாம். பழைய SI, increased SI, புதிய benefits-க்கு rules மாறலாம். என்ன credit accept செய்திருக்காங்க என்று எழுத்தில் உறுதி செய்வோம்.”

26. “ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எதையும் மறுக்க முடியாதா?”

“Moratorium முக்கியமான பாதுகாப்பு. ஆனா அது எல்லா exclusions-ஐயும் நீக்காது; established fraud exception-உம் இருக்கு. Continuous cover எவ்வளவு, SI எப்போ உயர்த்தினீங்க, எந்தப் பகுதிக்கு என்ன காலம் என்று records பார்த்துப் புரிஞ்சுக்கணும்.”

27. “Claim மறுத்தால் நீங்க என்ன செய்வீங்க?”

“முதலில் full letter, reason, policy clause, medical records பார்க்க உதவுவேன். தவறு அல்லது விடுபட்ட document இருந்தால் review கேட்கலாம். தேவைப்பட்டால் சரியான grievance route-ல் உதவலாம். Result-க்கு முன்கூட்டியே guarantee சொல்ல முடியாது.”

28. “என் மருத்துவத் தகவலை யாருடன் பகிர்வீர்கள்?”

“இந்த application அல்லது claim-க்கு தேவையான authorised team-க்கு, உங்க சம்மதத்துடன் மட்டுமே பகிரணும். என்ன details எதற்காக என்று சொல்லுறேன். பொதுவான groups-ல் reports பகிர வேண்டாம்.”

29. “இன்றே முடிவு செய்ய வேண்டுமா?”

“புரிஞ்சுக்கிட்டு முடிவு செய்யுங்க. உண்மையான renewal deadline அல்லது quote validity இருந்தால் சொல்றேன். Doubt இருந்தால் அதை முதலில் தெளிவுபடுத்தலாம்; பொய்யான urgency உருவாக்க வேண்டியதில்லை.”

30. “நீங்க சொன்னதை எழுத்தில் தருவீர்களா?”

“ஆமாம், முக்கிய benefits, limits, waiting, உங்க share, இன்னும் clarify செய்ய வேண்டிய points எல்லாம் எழுதி தரலாம். அதோடு applicable policy documents-உம் சேர்த்துப் பார்க்கணும்.”

Advisor-க்கான குறிப்புகள்

Answers-ஐ மனப்பாடமாக வாசிக்க வேண்டாம். Customer கேட்டதற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று வாக்கியத்தில் ஆரம்பிங்க. இன்னும் details வேணுமா என்று கேட்டுப் பொருத்தமான document காட்டுங்க. தெரியவில்லை என்றால் “சரிபார்த்து சொல்றேன்” என்று சொல்லலாம். எப்போது reply செய்வீங்க என்றும் note செய்யணும்.

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

நீண்ட English words சொல்லி customer-ஐ அமைதியாக்குவது, அவர் தலையாட்டியதால் புரிந்துவிட்டார் என்று நினைப்பது தவறு. Medical judgement சொல்லாதீங்க; evidence இல்லாமல் competitor-ஐ குறை சொல்லாதீங்க; “100%

Claim” என்று உறுதி தராதீங்க. Sample calculation-ஐ actual premium அல்லது approval amount என்று customer நினைக்கவில்லை என்பதை உறுதி செய்யுங்க.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

நல்ல உரையாடல் என்றால் நன்றாகக் கேட்பது, எளிமையாக விளக்குவது, limit-ஐ மறைக்காமல் சொல்வது, customer புரிந்ததா என்று பார்ப்பது, முக்கிய points பதிவு செய்வது. சரியான answer-உடன் மரியாதையான tone-உம் வேண்டும்.

பேசிப் பார்த்து பயிற்சி செய்யலாம்

ஒருவர் customer, ஒருவர் advisor ஆகப் பேசிப் பாருங்க. மேலுள்ள ஐந்து questions தேர்வு செய்து ஒவ்வொன்றுக்கும் 45 seconds-ல் பதில் சொல்லுங்க. Observer எளிமை, accuracy, limits விளக்கம் என்ற மூன்றையும் மதிப்பிடட்டும். “Any Room என்றால் எல்லாம் free” என்ற தவறான statement-ஐ சரியாக மாற்றுங்க.

விடைக் குறிப்பு: Room eligibility-யை Coverage முழுவதுடனும் குழப்பக்கூடாது; தொகை, விலக்கு மற்றும் சொந்தச் செலவுப் பங்கு தொடரும். சிறந்த பாத்திரப் பதில் Customer-ன் கவலையை முதலில் கேட்டு, ஒரு எளிய Example-டன் புரிதலை உறுதிசெய்யும்.

Advisor Checklist

• கேள்வியை முழுமையாகக் கேட்டேனா?

• ஒரு கருத்தை ஒரு நேரத்தில் விளக்கினேனா?

• எடுத்துக்காட்டின் அனுமானத்தையும் வரம்பையும் சொன்னேனா?

• Customer தனது சொற்களில் புரிதலைச் சொன்னாரா?

• நிலுவைக் கேள்விக்கும் எழுத்தில் உள்ளப் பதிலுக்கும் பொறுப்பு பதிவு செய்யப்பட்டதா?

ஆதாரம்: இந்த உரையாடல்கள் ஆசிரியர் உருவாக்கிய பயிற்சி மாதிரிகள். Regulatory கூற்றுகளுக்கு R01–R03; தயாரிப்பு விளக்கங்களுக்கு P01–P04 மற்றும் வழங்கப்படும் உண்மையான Policy ஆவணங்கள்.

அத்தியாயம் 16

Customer தயங்கினால் எப்படி பேசுவது

Objection Handling

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

“Premium அதிகம்”, “Claim கிடைக்குமா?”, “எனக்கு ஏற்கெனவே நோய் இருக்கு” என்று customer தயங்கலாம். அவருடன் வாதம் செய்யாமல் உண்மையான காரணத்தைக் கேட்கப் பழகலாம். Evidence-உடன் options சொல்லவும், முடிவு அவருடையது என்பதை மதிக்கவும் இந்த அத்தியாயம் உதவும்.

தயக்கம் ஒரு தகவல்

Customer “வேண்டாம்” என்றால் அவருக்குப் புரியவில்லை என்று நினைக்காதீங்க. Budget இல்லாமல் இருக்கலாம், நேரம் சரியில்லாமல் இருக்கலாம், வீட்டில் பேச வேண்டியிருக்கலாம், பழைய மோசமான அனுபவம் இருக்கலாம், plan பொருந்தாமலும் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு No-வையும் Yes ஆக்குவது நம்ம வேலை இல்லை. புரிந்துகொண்டு முடிவு செய்ய உதவுவதுதான் வேலை.

ஒரே கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் மீண்டும் pressure கொடுத்தால் trust குறையும். Contact வேண்டாம் என்றால் note செய்து மதிக்கணும். உண்மையான renewal date அல்லது quote expiry சொல்லலாம். இல்லாத deadline, இல்லாத premium hike உருவாக்காதீங்க.

சிம்பிளாக பதில் அமைப்பு

படி	செயல்	Example
கேள்	குறுக்கிடாமல் கவனித்தல்	“எந்தப் பகுதி உங்களுக்கு பொருத்தமில்லை?”
அங்கீகரி	கவலையை மதித்தல்	“ஆண்டு செலவைத் திட்டமிடுவது முக்கியம்.”
தெளிவாக்கு	உண்மையான தடையை அறிதல்	“கட்டணமா அல்லது Claim நேரச் செலவா?”

படி	செயல்	Example
ஆதாரம் கொடு	கணக்கு / ஆவணம் காட்டுதல்	“இரண்டு தேர்வுகளின் செலவுப் பங்கைக் காண்போம்.”
முடிவை மதித்து பதிவு செய்	அழுத்தமின்றி அடுத்த படி	“நீங்க விரும்பினால் நாளை குடும்பத்துடன் பேசலாம்.”

“Premium அதிகம்”

“எதனுடன் compare பண்ணுறீங்க?” என்று முதலில் கேளுங்க. SI, family, term, room, co-pay எல்லாம் ஒரே மாதிரியா? Budget தான் பிரச்சினை என்றால் பொருத்தமான குறைந்த base அல்லது வேறு அமைப்பு பார்க்கலாம். Premium குறைய பெரிய deductible எடுத்தால் அதன் பொறுப்பை மறைக்கக் கூடாது.

ஒரு கற்பனை comparison: A premium ₹24,000; B premium ₹20,000. B-ல் 20% co-pay, A-ல் இல்லை என்று வைத்துக்கலாம். ₹3 லட்சம் admissible claim வந்தால் B-ல் ₹60,000 customer share. வருடம் ₹4,000 saving மட்டும் காட்டினால் comparison முழுமை இல்லை. அதே நேரத்தில் claim கண்டிப்பாக வரும் என்றும் சொல்ல முடியாது. இவை actual quotes இல்லை.

“காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் Claim தருவதில்லை”

“எந்த case-ல் அப்படி நடந்தது?” என்று கேளுங்க. Rejection reason, policy rule, documents தெரியாமல் company-ஐ defend செய்யவோ குற்றம் சொல்லவோ வேண்டாம். “எல்லா claim-மும் வரும்” என்பது சரியான பதில் இல்லை. Waiting, disclosure, exclusions, grievance options பற்றி விளக்கலாம்.

“உங்களுக்கு என்ன experience நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க. Letter இருந்தால் reason பார்க்கலாம். புதிய plan பார்க்கும்போது என்ன cover ஆகாது என்பதையும் முன்பே எழுதி வைத்துக்கலாம்.”

“எனக்கு ஏற்கெனவே நோய் இருக்கு; பயனில்லை”

பழைய நோய் இருந்தால் எல்லா options-உம் முடிந்துவிட்டன என்று சொல்லாதீங்க. அதேபோல் automatic acceptance-உம் இல்லை. Full medical details-உடன் official assessment, waiting, co-pay, applicable options பார்க்கலாம். புதிய policy வாங்கினால் ஏற்கெனவே நடந்த medical expense திரும்பக் கிடைக்கும் என்று சொல்லக் கூடாது.

“காத்திருக்க வேண்டுமென்றால் இப்போது ஏன் வாங்க வேண்டும்?”

Waiting எந்த benefit-க்கு என்று முதலில் பிரிங்க. எல்லா covers-உம் ஒரே நாளில் தொடங்க வேண்டியதில்லை; எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே waiting-உம் இல்லை. Initial, PED, specified disease, maternity waiting வேறாக இருக்கலாம். தேவைக்கு ஏற்ற plan தேர்ந்தெடுத்து continuity வைத்திருக்கணும். உடனடிச் செலவுக்கு cover கிடைக்கும் என்று தவறாக உறுதி கொடுக்காதீங்க.

“Cashless இருந்தும் பணம் செலுத்தியவரைத் தெரியும்”

அந்த customer கட்டியது deposit-ஆ, co-pay-ஆ, sub-limit gap-ஆ, non-payable-ஆ என்று தெரியாமல் முடிவு சொல்ல வேண்டாம். Cashless பணம் செல்லும் முறை; எல்லா expense-க்கும் approval இல்லை. இப்போது பார்க்கும் plan-ல் இந்தச் செலவுகள் எப்படி இருக்கலாம் என்று விளக்குங்க.

“வேறு ஆலோசகர் அதிக நன்மை சொல்கிறார்”

அவர் சொன்ன benefit-க்கு official document பார்க்கலாம் என்று சொல்லுங்க. Same UIN, SI, options, family details வைத்து compare செய்யணும். மற்ற advisor-ஐப் பற்றி ஊகித்துக் குறை சொல்லாதீங்க. அவர் சொன்னது சரியாக இருந்தால் நம்ம விளக்கத்தைத் திருத்தலாம். ஆதாரம் இல்லையென்றால் “உறுதி செய்யணும்” என்று வையுங்க.

“ஆன்லைனில் மலிவு; உங்களிடம் ஏன்?”

Customer விரும்பும் authorised channel-ல் வாங்கலாம். நம்ம service என்ன என்று சொல்லலாம்: needs analysis, documents விளக்கம், application check, renewal support, claim coordination. “என்னிடம் வாங்கினால் அதிக claim” அல்லது “தனி approval” என்று சொல்லக் கூடாது. Price difference-க்கு actual reason official quote-ல் பார்க்கணும்.

Advisor-க்கான குறிப்புகள்

ஒரே சந்திப்பில் எல்லா doubts-உம் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முக்கிய pending question-க்கு source வாங்குங்க. வீட்டில் பேச வேண்டும் என்றால் customer அனுமதியுடன் short comparison கொடுக்கலாம். Medical details-ஐ family member-க்குக்கூட தானாக forward செய்ய வேண்டாம்.

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

பயம், குற்ற உணர்வு அல்லது குடும்பப் பொறுப்பை அழுத்தமாகப் பயன்படுத்துதல்; “இப்போது வாங்காவிட்டால் இனி கிடைக்காது” என்ற

ஆதாரமற்ற கூற்று; Co-payment-ஐ சிறிய விஷயமாகக் காட்டுதல்; Customer-ன் வருமானத்தைத் தீர்ப்பிடுதல்; அனுமதியின்றி தொடர்ந்து தொடர்புகொள்வது ஆகியவை தவறுகள். எந்த எதிர்ப்புக்கும் பதில் அளிக்கும்போது உண்மையான Policy நிபந்தனையை மாற்ற முடியாது.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

தயக்கத்தை எதிர்த்து ஜெயிக்க முயலாமல் அதன் காரணத்தைப் புரிஞ்சுக்கணும். Evidence, simple calculation, தேர்வு செய்யும் சுதந்திரம் இருந்தால்தான் trust வரும். எல்லாம் புரிந்த பிறகு “இப்போ வேண்டாம்” என்று முடிவு செய்வதும் செல்லுபடியான முடிவுதான்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. “Premium அதிகம்” என்றால் முதலில் என்ன கேட்பீங்க? 2. குறைந்த கட்டணத்துடன் அதிக செலவுப் பங்கை எப்படி விளக்குவீங்க? 3. மற்ற ஆலோசகர் கூறிய நன்மை உறுதியாகத் தெரியாவிட்டால் என்ன செய்வீங்க? 4. தொடர்பு வேண்டாம் என்ற Customer-ன் பதிவை எப்படி கையாள்வீர்கள்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: ஒப்பீட்டின் அடிப்படை மற்றும் செலவுத்திறனை அறிதல்; ஒரே கற்பனைக் Claim-ல் இரண்டு தேர்வுகளையும் கணக்கிடுதல்; அதிகாரப்பூர்வ ஆவணம் பெறுதல்; தொடர்புத் தடையைப் பதிவு செய்து மதித்தல். மதிப்பீட்டில் துல்லியம் மட்டுமல்ல, அழுத்தமற்ற தொனியும் முக்கியம்.

Advisor Checklist

- உண்மையான தயக்கத்தை Customer-ன் சொற்களில் பதிவு செய்தேனா?
- ஆதாரமற்ற உறுதிமொழி தவிர்க்கப்பட்டதா?
- மாற்றுத் தேர்வின் வரம்பும் செலவும் விளக்கப்பட்டனவா?
- அடுத்த தொடர்புக்குச் சம்மதம் உள்ளதா?
- Customer-ன் முடிவு மதிக்கப்பட்டதா?

ஆதாரம்: உரையாடல்கள் மற்றும் விலை எண்கள் கற்பனையான பயிற்சி மாதிரிகள். உண்மையான தயாரிப்புக் கூற்றுகள் P01–P04 மற்றும் தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வ மேற்கோளால் உறுதிசெய்யப்பட வேண்டும்.

அத்தியாயம் 17

15 Customer கதைகள் நீங்க என்ன செய்வீங்க

Realistic Customer Case Studies

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

இதுவரை கற்ற needs analysis, disclosure, கணக்கு, conversation, service எல்லாத்தையும் சேர்த்துப் பயன்படுத்திப் பார்ப்போம். Case-ல் இல்லாத தகவலை நாமே நிரப்பாதீங்க. என்ன கேட்கணும், ஏன் அந்த recommendation, அதன் limit என்ன என்று எழுதிப் பழகலாம்.

வழக்குகளைப் பயன்படுத்தும் முறை

இங்கே வரும் பெயர்கள், குடும்பங்கள், செலவுகள், சம்பவங்கள் எல்லாமே கற்பனை. Actual claim settlement அல்லது insurer acceptance என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஒவ்வொரு கதையிலும் மூன்று கேள்விகள் கேளுங்க: நமக்கு என்ன தெரியும்? இன்னும் என்ன தெரியணும்? அடுத்து என்ன செய்யலாம்? அதற்குப் பிறகுதான் plan அல்லது action தேர்வு செய்யணும்.

வழக்கு 1 — இளம் குடும்பத்தின் முதல் Policy

அருணுக்கு 31, லட்சுமிக்கு 28, குழந்தைக்கு 2 வயது. Office cover ₹3 லட்சம் இருக்கு. Private hospital செல்ல விருப்பம். Monthly budget-க்குள் தனி policy பார்க்கிறார்கள். ஆனால் வேலை மாறினால் office cover எப்போது முடியும், parents அதில் உள்ளார்களா என்ற details இன்னும் தெரியவில்லை.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Floater ₹5, ₹10, ₹20 லட்சம் options-உம் பொருத்தமான top-up அமைப்பும் ஒப்பிடுங்க. ஒரே வருடத்தில் இரண்டு claims வந்தால் shared cover எப்படி குறையும் என்று காட்டுங்க.

பேசிப் பாருங்க: “Office cover உதவும். ஆனா அது எப்போ வரை இருக்கும்னு முதலில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதற்குப் பிறகு தனி family cover-ல் என்ன gap நிரப்பணும்னு பார்ப்போம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: உடனே அதிகத் தொகையைத் திணிக்காமல் நிலையான Renewal-த் திறனைப் பார்க்கணும்.

வழக்கு 2 — இரண்டு மூத்த பெற்றோர்

சரவணன் 67, 63 வயதுள்ள பெற்றோருக்கு policy தேடுகிறார். ஒருவருக்கு BP; இன்னொருவருக்கு பழைய surgery. “ஒரே Floater எடுத்தால் cheap-ஆ இருக்குமே?” என்று நினைக்கிறார்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Full medical history, medicines, existing cover, hospital preference, claim நேரத்தில் செலுத்தக்கூடிய amount கேளுங்க. Separate policies-க்கும் shared cover-க்கும் உள்ள வித்தியாசம் காட்டுங்க. Entry eligibility மட்டும் போதாது; co-pay-உம் underwriting-உம் முக்கியம்.

பேசிப் பாருங்க: “Age eligible-ஆ இருந்தாலும் medical assessment தனியாக இருக்கும். Company written decision வந்த பிறகு final option முடிவு செய்வோம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: பெற்றோரின் மருத்துவத் தகவலை அவர்களுடைய சம்மதத்துடன் பெறணும்.

வழக்கு 3 — கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீரிழிவு

பிரகாஷ் 42 வயது. ஐந்து வருடமாக diabetes medicine எடுக்கிறார். “Sugar control-ல் இருக்கே; form-ல் சொல்ல வேண்டாம்” என்று நண்பர் சொல்லியிருக்கிறார்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Diagnosis date, medicines, tests, complications அனைத்தையும் உண்மையாகப் பதிவு செய்யுங்க. ஒரு special option பொருந்துமா என்பதை insurer மதிப்பிடட்டும். Ad-ல் இருக்கும் பெயரை வைத்து acceptance guarantee கொடுக்காதீங்க.

பேசிப் பாருங்க: “Sugar control-ல் இருப்பதை report-உடன் சொல்லலாம். ஆனா diabetes history-யை மறைக்கக் கூடாது. ரெண்டையும் சரியாகப் பதிவு செய்வோம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: மருத்துவப் பரிசோதனை செய்வது Proposal வெளிப்படுத்தலுக்கு மாற்றாகாது. எழுதப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் Waiting-ஐப் பார்க்கணும்.

வழக்கு 4 — தைராய்டு மருந்தை நிறுத்தியவர்

ரேவதி 35 வயது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் thyroid treatment எடுத்தார். இப்போது doctor advice-படி medicine இல்லை. Form-ல் “இப்போ நோய் இல்லை” என்று மட்டும் எழுத நினைக்கிறார்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Form கேள்வியை முழுவதும் காட்டுங்க. பழைய diagnosis, treatment, இப்போதைய status தனியாக எழுதுங்க. Doctor record இணைக்கலாம். “முழுசா குணமாகிவிட்டது” என்று advisor medical judgement எழுத வேண்டாம்.

பேசிப் பாருங்க: “இப்போ medicine இல்லை என்பதையும், முன்னாடி treatment எடுத்ததையும் ரெண்டையும் உண்மையாகச் சொல்வோம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: தேவையான தகவலைத் தெளிவுபடுத்துவது தேவையற்ற மறுப்பைத் தவிர்க்க உதவலாம்; ஏற்றுக்கொள்ளலை உறுதி செய்யாது.

வழக்கு 5 — ஆஸ்துமா மற்றும் அடிக்கடி OPD செலவு

குமார் 29 வயது. அவ்வப்போது inhaler பயன்படுத்துகிறார். Policy எடுத்தால் மாதந்தோறும் medicine வாங்கும் செலவு திரும்பக் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Hospital cover-க்கும் OPD benefit-க்கும் வித்தியாசம் சொல்லுங்க. ஒரு நோய்க்கு waiting குறைவாக இருந்தாலும் எல்லா மாத medicine செலவும் cover ஆகாது. Asthma treatment history-யும் disclose செய்யணும்.

பேசிப் பாருங்க: “மாத medicine expense-க்கு help வேணுமா, பெரிய hospital expense-க்கு cover வேணுமா? ரெண்டுக்கும் rules வேறாக இருக்கலாம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: Customer எதிர்பார்ப்பும் வாங்கப்படும் பாதுகாப்பும் பொருந்த வேண்டும்.

வழக்கு 6 — விரைவில் மகப்பேறு திட்டம்

திவ்யா 30, கணவர் 33. அடுத்த எட்டு மாதங்களில் குழந்தைத் திட்டம். Hospital estimate ₹1.8 லட்சம் என்று கற்பனையாக வைத்துக்கலாம்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: இப்போது pregnant-ஆ, எதிர்பார்க்கும் timeline என்ன, office cover இருக்கா என்று மரியாதையுடன் கேளுங்க. புதிய maternity waiting எட்டு மாதத்துக்குள் முடியாமல் இருக்கலாம். ₹50,000 sub-limit என்றால் ₹1.8 லட்சம் செலவு முழுவதற்கும் போதாது.

பேசிப் பாருங்க: “Waiting-உம் தனி amount limit-உம் இருக்கலாம். உடனே full delivery cover கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Savings எவ்வளவு தேவைப்படும்னும் சேர்த்துப் பார்ப்போம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: மகப்பேறு நன்மையைப் பயன்படுத்தி தவறான உடனடி வாக்குறுதி தரக்கூடாது.

வழக்கு 7 — பெரிய குடும்ப Floater

முரளி 40, மனைவி 37, இரண்டு குழந்தைகள், அம்மா 66. எல்லாரையும் ₹10 லட்சம் shared cover-ல் சேர்க்க விரும்புகிறார்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: ஒரே வருடத்தில் அம்மாவுக்கு ₹7 லட்சம், குழந்தைக்கு ₹5 லட்சம் admissible claims வந்தால் என்ன ஆகும்? Restoration இல்லாத கணக்கில் ₹2 லட்சம் gap. Restoration இருந்தால் அதன் rules பார்க்கணும். அம்மாவுக்குத் தனி cover option-ஐயும் compare செய்யுங்க.

பேசிப் பாருங்க: “ஒரே policy manage செய்ய easy-ஆ இருக்கலாம். ஆனா அந்த shared amount எல்லாருக்கும் போதுமா என்று இரண்டு claims வைத்து பார்க்கலாம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: உறுப்பினர் எண்ணிக்கை மட்டும் அல்ல, செலவுகளின் கூட்டுத் தாக்கமும் முக்கியம்.

வழக்கு 8 — வேலை மாற்றம்

நந்தினி 32 வயது. வேலைவிடும் நாளில் office cover முடிகிறது. புதிய வேலை மூன்று மாதங்கள் கழித்துத்தான். தனி policy இல்லை.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: இப்போதைய group insurer-ல் migration/individual continuity option இருக்கா என்று உடனே கேளுங்க. Application window, underwriting, credits, start date எழுத்தில் வாங்குங்க. புதிய வேலை கிடைத்துவிட்டது என்பதால் இந்த மூன்று மாத gap-ஐ விட்டுவிடாதீங்க.

பேசிப் பாருங்க: “இந்த மூன்று மாதத்தில் medical expense வந்தால் எந்த cover உதவும் என்பதைத்தான் முதலில் பார்க்கணும்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: குழுப் பாதுகாப்பைத் தனிப்பட்ட வாழ்நாள் பாதுகாப்பாகக் கருதக்கூடாது.

வழக்கு 9 — குறைந்த கட்டணத்திற்காக Portability

சேகர் 48. நான்கு வருட continuity இருக்கு. இன்னொரு insurer-ல் premium குறைவாக quote வந்திருக்கிறது. ஆனால் புதிய plan-ல் room limit குறைவு; co-pay அதிகம்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Same SI-ல் premium, room, co-pay, credits, hospitals ஒப்பிடுங்க. புதிய final acceptance வரும்முன் பழைய policy cancel செய்யாதீங்க.

பேசிப் பாருங்க: “Premium saving இருக்கலாம். அதோடு claim நேரத்தில் கூடும் உங்க செலவையும் சேர்த்துப் பார்த்தால்தான் சரியான comparison கிடைக்கும்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: Portability தானாக மேம்பாடு அல்ல. தேர்வின் காரணம் பதிவாக வேண்டும்.

வழக்கு 10 — Super Top-Up இடைவெளி

மோகனிடம் base cover ₹3 லட்சம். Super Top-Up-க்கு aggregate deductible ₹5 லட்சம். அந்த வருட admissible expense ₹9 லட்சம் என்று வைத்துக்கலாம்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Base ₹3 லட்சம், customer gap ₹2 லட்சம், Super Top-Up ₹4 லட்சம். இந்த example-ல் வேறு deductions இல்லை; top-up limit போதுமானது. நடுவிலுள்ள ₹2 லட்சத்தை உடனே சமாளிக்க முடியுமா என்று கேளுங்க.

பேசிப் பாருங்க: “Super Top-Up இருக்கு. ஆனா முதல் ₹5 லட்சத்துக்கு எந்த source இருக்குன்னு முதலில் கணக்கிடணும்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: Deductible-ஐச் செலுத்தும் ஆதாரம் தெளிவாக இருக்கணும்.

வழக்கு 11 — அறைத் தேர்வால் எதிர்பாராத செலவு

கலா 45 வயது. Policy-ல் தினம் ₹5,000 room limit என்ற கற்பனை நிலை. அவர் ₹8,000 room எடுத்திருக்கிறார்; ஐந்து நாள் admission.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Room difference மட்டும் ₹15,000. Associated charges-ல் proportionate deduction இருக்கா என்று wording பார்க்கணும். Bill முழுவதற்கும் ஒரே ratio போட்டு guess செய்யாதீங்க. Hospital room category record-உம் வேண்டும்.

பேசிப் பாருங்க: “Room difference மட்டும் இல்லாமல் வேற deduction இருக்கா என்று settlement letter-உடன் பார்க்கலாம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: அனுமதிக்கு முன் Room eligibility விளக்கம் முக்கியம்.

வழக்கு 12 — விடுவிப்பில் தாமதம்

ராஜன் 56 வயது. Doctor காலை 10 மணிக்கு discharge முடிவு செய்கிறார். Hospital final request மதியம் 1 மணிக்கு அனுப்புகிறது. மாலை 5 மணிக்கும் approval வரவில்லை.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Request 1 மணிக்கு அனுப்பியதும் insurer பெற்றதும் உறுதி செய்யுங்க. மூன்று மணி நேர விதிக்கான தொடக்கம் hospital request received time. Delay காரணமாக extra charge இருந்தால் bill-உம் proof-உம் சேமியுங்க.

பேசிப் பாருங்க: “Doctor discharge சொன்ன நேரம் வேறு; final request சென்ற நேரம் வேறு. சரியான timestamp-உடன் follow-up செய்து escalate செய்கிறேன்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: துல்லியமான நேரப் பதிவு பயனுள்ள குறைதீர்ப்பை உருவாக்கும்.

வழக்கு 13 — பழைய அறுவைச் சிகிச்சை விடுபட்டது

மாலதி 39 வயது. ஏழு வருடத்துக்கு முன் surgery நடந்தது. Proposal-ல் கேட்டிருந்தும் அந்த detail பதிவு ஆகவில்லை என்று இப்போதுதான் தெரிகிறது. இன்னும் claim எதுவும் இல்லை.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Actual proposal copy வாங்குங்க. யார் தவறு என்ற பேச்சில் மட்டும் நிற்காமல் insurer-டம் correction/additional disclosure process எழுத்தில் கேளுங்க. என்ன முடிவு வரும் என்று guarantee சொல்ல வேண்டாம்; medical proof-ஐ மாற்றவும் கூடாது.

பேசிப் பாருங்க: “இந்த விடுபட்ட detail-ஐ இப்போ உண்மையாகத் தெரிவித்து company official reply வாங்குவோம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: பிழையை மறைப்பதைவிட சரியான பதிவை உருவாக்குதல் முக்கியம்.

வழக்கு 14 — புற்றுநோய் வரலாறும் புதிய விண்ணப்பமும்

பாலா 51 வயது. முன்பு cancer treatment எடுத்தவர்; இப்போது follow-up-ல் இருக்கிறார். புதிய health cover தேடுகிறார்.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: சம்மதத்துடன் diagnosis, treatment completion, current follow-up, doctor records பெறுங்க. Insurer acceptance, postponement, extra conditions, decline என வேறு முடிவுகள் வரலாம். “ஐந்து வருடம் ஆனால் கட்டாயம் ஏற்கணும்” என்று இல்லாத rule சொல்லாதீங்க.

பேசிப் பாருங்க: “உங்க records வைத்து பொருத்தமான options-ஐ official-ஆக கேட்டுப் பார்ப்போம். Assessment வரும்முன் முடிவு சொல்ல முடியாது.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: மரியாதையும் தனியுரிமையும் மருத்துவத் துல்லியமும் அவசியம்.

வழக்கு 15 — Reimbursement கழிவில் சந்தேகம்

ஃபாத்திமா 44 வயது. Hospital-க்கு ₹2.5 லட்சம் கட்டினார். Reimbursement ₹1.9 லட்சம் வந்திருக்கிறது. சில deductions ஏன் என்று letter பார்த்தும் புரியவில்லை.

நீங்க செய்ய வேண்டியது: Itemised bill, paid receipt, settlement letter, schedule ஒப்பிடுங்க. ஒவ்வொரு deduction-க்கும் reason, clause கேளுங்க. Calculation error அல்லது கொடுத்த document விடுபட்டிருந்தால் proof-உடன் review கேளுங்க.

பேசிப் பாருங்க: “₹60,000 difference எல்லாமே ஒரே காரணத்தால் வந்ததுன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஒவ்வொரு deduction-ஆகப் பிரித்துப் பார்க்கலாம்.”

இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது: கோரிய தொகைக்கும் கிடைத்த தொகைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மட்டும் தவறான தீர்வுக்கான ஆதாரம் அல்ல; விளக்கமான ஆய்வு தேவை.

Advisor-க்கான குறிப்புகள் மற்றும் பொதுவான தவறுகள்

Case-ல் சொல்லாததை ஊகிப்பதுதான் பெரிய தவறு. நோயின் பெயர் தெரிந்ததும் acceptance சொல்லாதீங்க; SI தெரிந்ததும் full cover சொல்லாதீங்க; Cashless status தெரிந்ததும் final settlement சொல்லாதீங்க. Customer சொன்னது, document-ல் இருப்பது, நாம் வைத்த assumption மூன்றையும் பிரித்து எழுதுங்க. Actual policy conditions-தான் குறிப்பிட்ட case-க்கு பொருந்தும்.

வழக்கு ஆய்வுக்கான கருத்துப்படம்

அறிதல்	ஆய்வு	நடவடிக்கை	மறுபரிசீலனை
குடும்பம், தேவை, மருத்துவ வரலாறு	தொகை, Waiting, விலக்கு, சொந்தச் செலவுப் பங்கு	அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம், ஒப்பீடு, விண்ணப்பம்	Schedule, புரிதல், நிலுவைக் கேள்வி

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

சில cases-ல் உடனே பதில் சொல்வதைவிட சரியான அடுத்த கேள்வி கேட்பது முக்கியம். Family planning, medical disclosure, claim help எல்லாமே advisor service-ன் பகுதிகள்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

வழக்குகள் 3, 6, 9, 12, 15-இல் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு பக்க ஆலோசனைக் குறிப்பை எழுதுங்க. அதில் தெரிந்த தகவல், கூடுதல் கேள்விகள், சரிபார்க்க வேண்டிய பிரிவு, Customer-க்கான இரண்டு வாக்கிய விளக்கம் மற்றும் அடுத்த நடவடிக்கை இருக்கணும். வழக்கு 10-இல் அடிப்படை ₹5 லட்சமாக இருந்தால் இடைவெளி எப்படி மாறும்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: தகவல் ஊகிக்கப்படாமல் இருக்கணும்; சரிபார்ப்பு மற்றும் Customer சம்மதம் பதிவாக வேண்டும். வழக்கு 10-இன் எளிய மாதிரியில் அடிப்படை ₹5 லட்சம் முழுவதையும் ஏற்றால் Deductible இடைவெளி இல்லை; பிற கழிவுகள் தனியாக இருக்கலாம்.

Advisor Checklist

• வழக்கின் உண்மை மற்றும் Assumption பிரிக்கப்பட்டதா?

• விடுபட்ட தகவலுக்கான கேள்விகள் உள்ளனவா?

• குறிப்பிட்ட Policy விதி பார்க்கப்பட்டதா?

• Customer-க்கு முடிவும் வரம்பும் புரிந்ததா?

• அடுத்த நடவடிக்கை, பொறுப்பாளர், தேதி பதிவாகியுள்ளனவா?

ஆதாரம்: அனைத்து வழக்குகளும் ஆசிரியர் உருவாக்கிய கற்பனைகள். விதிகளுக்கான ஆதாரங்கள் R01–R03; தயாரிப்பு தொடர்பான முடிவுகளுக்கு உண்மையான Policy Wording, Schedule மற்றும் Endorsement அவசியம்.

அத்தியாயம் 18

நம்பிக்கையைப் பாதுகாக்கும் Advisor பழக்கங்கள்

Advisor Ethics & Compliance

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

உண்மையான medical details, சரியான product explanation, customer consent, privacy, நம்ம அதிகார வரம்பு எல்லாம் service-ன் அடிப்படை. தவறு தெரிந்தால் அதை மறைக்காமல் திருத்துவதையும் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம்.

நம்பிக்கை என்பது ஆவணத்திலும் தெரிய வேண்டும்

இனிமையாகப் பேசினால் மட்டும் trust வந்துவிடாது. Customer வாங்கும் cover-ன் limits சொல்லணும். புரியாத கேள்வியை விளக்கணும். Document படிக்க நேரம் கொடுக்கணும். அவர் சொன்ன details மாற்றாமல் பதிவு செய்யணும். இந்தச் செயல்களில்தான் நம்பிக்கை தெரியும்.

நமக்கு இருக்கும் official appointment/authorisation வரம்புக்குள்தான் வேலை செய்யணும். இந்தப் புத்தகம் படித்ததால் licence அல்லது appointment கிடைத்ததாகாது. நம்ம role, எந்த company சார்பில் பேசுகிறோம், service limit என்ன என்று உண்மையாகச் சொல்லணும். Medical decision doctor-க்கும் underwriting decision insurer-க்கும் உரியது.

சிம்பிளாக

Claim நேரத்தில் customer “இதை முன்னாடியே சொல்லவே இல்லையே” என்று சொல்லாத அளவுக்கு முக்கிய conditions விளக்கணும். எல்லா legal words-ஐயும் வாசிக்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் அவர் முடிவை மாற்றக்கூடிய limit-ஐ மறைக்கக் கூடாது.

Medical disclosure

Proposal questions-ஐ customer புரியும் மொழியில் விளக்குங்க. அவருக்குப் பதிலாக guess செய்யாதீங்க. பழைய treatment, tests, surgery, medicines பற்றி கேட்டால் உண்மையாகப் பதிவு செய்யணும். “இதைச் சொன்னா policy வராது” என்று மறைக்கச் சொல்லக் கூடாது.

Customer வாயில் சொன்ன detail form-ல் இருக்கிறதா என்று check செய்யுங்க. “என்னிடம் சொன்னீங்களே; போதும்” என்று சொல்ல முடியாது. Insurer-க்குச்

சென்ற record-உம் accepted conditions-உம் முக்கியம். Final answers பார்க்க customer-க்கு வாய்ப்பு கொடுங்க.

துல்லியமான விளக்கம்

தவறான கூற்று	தொழில்முறை மாற்று
“எல்லா Claim-மும் 100% வரும்”	“Policy-ன் Admissible expense மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கேற்ப முடிவு அமையும்.”
“இந்த நோயைச் சொல்ல வேண்டாம்”	“கேட்கப்பட்ட மருத்துவத் தகவலை உண்மையாகப் பதிவு செய்வோம்.”
“என்னிடம் வாங்கினால் அனுமதி உறுதி”	“விண்ணப்பம் மற்றும் சேவையில் உதவலாம்; முடிவு நிறுவனத்துடையது.”
“Premium இனி மாறாது”	“தற்போதைய Quote இது; Renewal விலை விதிகளைப் பார்க்கணும்.”
“இந்தப் பக்கத்தில் கையெழுத்திடுங்கள்; மற்றதை நான் நிரப்புகிறேன்”	“முழுமையாக நிரப்பிய தகவலைப் பார்த்து உறுதிசெய்த பிறகு ஒப்புதல் அளியுங்கள்.”

சம்மதமும் தகவல் பாதுகாப்பும்

எந்த detail எதற்காக வாங்குகிறோம், யாருடன் பகிர்வோம் என்று சொல்லணும். Training group-ல் report பகிர பெயரை மட்டும் அழித்தால் போதாமல் இருக்கலாம். Date, hospital, age சேர்ந்து நபர் யார் என்று தெரியலாம். Training-க்கு கற்பனைக் cases பயன்படுத்தலாம்.

OTP, password, blank signature image சேமித்து வைக்காதீங்க. Customer அறியாமல் அவர் consent கொடுத்ததாகச் செயல்பட வேண்டாம். தேவையானவர்களுக்கு மட்டுமே document access கொடுங்க. எவ்வளவு காலம் வைத்திருக்கணும், எப்போது நீக்கணும் என்பதை authorised record policy-படி செய்யணும். நாமே விருப்பப்படி நிரந்தரமாக வைப்பதும் உடனே அழிப்பதும் சரியல்ல.

பணம் மற்றும் ஆவண நேர்மை

Premium official channel-ல் போகணும்; proper receipt customer-க்கு கிடைக்கணும். Authorisation இல்லாமல் personal account-ல் வாங்குவது, உண்மையில்லாத discount சொல்வது, unofficial receipt தருவது தவறு. சட்டத்துக்கும் company rules-க்கும் எதிரான offer வைத்து sale செய்யாதீங்க.

Claim amount கூட்டிக் காட்டுவது, medical date மாற்றுவது, செய்யாத treatment item சேர்ப்பது, மற்றவருடைய document பயன்படுத்துவது தவறு. Customer கேட்டாலும் மரியாதையாக மறுத்து, actual expense-க்கான சரியான claim-க்கு உதவுங்க.

கற்பனைச் சூழல்: விண்ணப்பப் பிழை

Customer சொன்ன பழைய surgery-ஐ advisor பதிவு செய்ய மறந்துவிட்டார் என்று வைத்துக்கலாம். Policy வந்த பிறகு தெரிய வருகிறது. பிழையை மறைக்காமல் customer-க்கு சொல்லி insurer correction/additional disclosure process பின்பற்றணும். அனுப்பிய பதிவு, reply, மாற்றிய conditions எல்லாம் சேமிக்கணும். Insurer என்ன முடிவு எடுப்பார் என்று முன்பே உறுதி சொல்ல முடியாது.

உரையாடல்

Customer: “சிறிய பழைய நோய்தான்; அதை விடுங்கள்.”

Advisor: “அது சின்ன விஷயம்னு நானே முடிவு செய்ய முடியாது. Form கேட்கும் details சரியாக இருந்தால்தான் company மதிப்பிட முடியும். எந்த question புரியலையோ அதை விளக்குறேன்.”

Customer: “பில்லில் கொஞ்சம் கூடுதலாகச் சேர்க்க முடியுமா?”

Advisor: “உண்மையில் செலவான amount-க்குத்தான் claim submit செய்ய முடியும். சரியான bill-உம் documents-உம் ஒழுங்குபடுத்த உதவுறேன்.”

நெறிமுறை முடிவுக்கான கருத்துப்படம்

கேள்வி	இல்லை என்றால்
தகவல் உண்மையா?	திருத்தி உண்மை ஆதாரம் வாங்குங்க
Customer-க்குப் புரிந்துள்ளதா?	எளிய மொழியில் மீண்டும் விளக்குங்க
உரிய சம்மதம் உள்ளதா?	தேவையான அனுமதியைப் வாங்குங்க
என் அதிகார வரம்புக்குள் உள்ளதா?	உரிய அதிகாரியிடம் மாற்றுங்க
பின்னர் ஆவணத்துடன் விளக்க முடியுமா?	செயலையும் பதிவையும் மறுபரிசீலியுங்கள்

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

விற்பனை இலக்கிற்காக முக்கிய வரம்பை மறைத்தல், Customer-ன் அமைதியைச் சம்மதமாகக் கருதுதல், மருத்துவ ஆலோசனை வழங்குதல், பிழைக்குப் பிறகு

பதிவை மறைமுகமாக மாற்றுதல், தனிப்பட்ட தகவலை தேவையின்றி சேமித்தல் ஆகியவை தவறுகள். எந்தப் Policy நிபந்தனையையும் வாய்மொழி உறுதி மாற்றாது.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Ethics என்பது தனியாகப் படித்துவிட்டு மறக்கும் lesson இல்லை. முதல் enquiry-லிருந்து claim support வரை ஒவ்வொரு செயலிலும் இருக்கணும். உண்மை, புரிதல், சம்மதம், நம்ம வரம்பு, சரியான பதிவு இவை service-ன் அடிப்படை.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. Customer வாய்மொழியாகச் சொன்ன நோய் Proposal-இல் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்யணும்? 2. வெற்று விண்ணப்பத்தில் கையெழுத்து பெறுவது ஏன் தவறு? 3. பயிற்சிக்கான மருத்துவப் பதிவில் பெயரை மட்டும் நீக்குவது ஏன் போதாமல் இருக்கலாம்? 4. பிழை கண்டறிந்தபின் நல்ல திருத்தப் பதிவு என்ன கொண்டிருக்க வேண்டும்?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: நிறுவனத்துக்குச் சரியான வெளிப்படுத்தல்; தகவலறிந்த ஒப்புதல்; மறைமுக அடையாளக் குறிகள்; பிழை, உண்மைத் தகவல், சம்மதம், அனுப்பிய தேதி, நிறுவனப் பதில் மற்றும் திருத்த முடிவு ஆகியவை முக்கியம்.

Advisor Checklist

- தகவல் Customer-ஆல் உறுதிசெய்யப்பட்டதா?
- முக்கிய வரம்புகள் வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டனவா?
- சம்மதம், அணுகல் மற்றும் ஆவணப் பாதுகாப்பு உள்ளதா?
- கட்டணம் அதிகாரப்பூர்வ வழியில் சென்றதா?
- பிழை அல்லது நலன் முரண்பாடு உரிய முறையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டதா?

ஆதாரம்: R01–R03 Policyholder பாதுகாப்பு மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தொடர்பான விதிகள்; பணியாற்றும் நிறுவனத்தின் தற்போதைய அங்கீகாரம், சேவை மற்றும் தகவல் பாதுகாப்புக் கொள்கைகள் தனியாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

அத்தியாயம் 19

முதல் Enquiry முதல் Renewal வரை

Sales Consultation & Follow-up

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

Customer contact permission-லிருந்து needs analysis, comparison, decision, renewal வரை ஒரு தெளிவான process அமைக்கலாம். CRM note எப்படி சுருக்கமாகவும் பயன்படும்படியும் இருக்கணும், sales-ஐயும் service quality-யையும் எப்படி தனியாகப் பார்க்கணும் என்பதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம்.

முதல் தொடர்பின் நோக்கம்

முதல் call-லேயே policy close செய்யணும் என்று நினைக்காதீங்க. சரியான நபரா, பேச வசதியான நேரமா, என்ன help தேவை என்று கேளுங்க. Number எங்கிருந்து கிடைத்தது என்று சொல்லத் தெரியணும். Contact வேண்டாம் என்றால் மதிக்கணும்.

Lead qualification என்றால் income வைத்து நபரை மதிப்பிடுவது இல்லை. என்ன need, எப்போது முடிவு செய்ய நினைக்கிறார், family details, existing cover, நாம் உதவக்கூடிய scope என்ன என்று புரிந்துகொள்வது. முதல் call-லேயே முழு medical file கேட்க வேண்டாம். அடுத்த step-க்கு தேவையான details-ஐ consent-உடன் பெறுங்க.

சிம்பிளாக ஆலோசனைச் சுற்று

கட்டம்	நோக்கம்	வெளியீடு
தொடர்பு	அனுமதி மற்றும் நேரம்	சந்திப்பு ஒப்புதல்
Needs analysis	குடும்பம், பாதுகாப்பு, Budget	தேவைக் குறிப்பு
ஒப்பீடு	பொருத்தமான தேர்வுகள்	வரம்புகளுடன் ஒப்பீட்டு அட்டவணை
புரிதல்	கேள்விகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள்	நிலுவைக் கேள்விப் பட்டியல்
முடிவு	Customer தேர்வு	தேர்வுக்கான காரணம்
விண்ணப்பம்	உண்மைத் தகவல் மற்றும் சம்மதம்	உறுதிசெய்யப்பட்ட Proposal

கட்டம்	நோக்கம்	வெளியீடு
வழங்கல்	Schedule சரிபார்ப்பு	Policy ஒப்படைப்பு பதிவு
சேவை	Claim, மாற்றம், Renewal	செயல்படும் ஆண்டு சேவைத் திட்டம்

30 நிமிடச் சந்திப்பு மாதிரி

30 நிமிட training meeting வைத்துக்கலாம். முதல் 5 நிமிடம் நோக்கம், எதிர்பார்ப்பு. அடுத்த 10 நிமிடம் family, medical history, existing policy, hospital preference. அடுத்த 10 நிமிடம் இரண்டு பொருத்தமான options, முக்கிய limits. கடைசி 5 நிமிடம் questions, next step, reply date. இது பயிற்சிக்கான நேரப் பகிர்வு; customer-ஐ அவசரப்படுத்தும் விதி இல்லை.

சந்திப்பு முடிவில் “எந்த plan எடுக்கிறீங்க?” என்று மட்டும் கேட்காதீங்க. “எந்த difference இன்னும் clear ஆகலை?” என்று கேட்கலாம். Waiting, room, co-pay பற்றி customer தன் வார்த்தைகளில் சொன்னால் அவர் புரிந்துகொண்டாரா என்று தெரியும்.

ஒப்பீட்டுக் குறிப்பின் கட்டாயப் பகுதிகள்

Quote-ல் date, members, ages, SI, policy term, add-ons, official price source இருக்கணும். Benefits-க்கு அருகிலேயே முக்கிய limits-உம் காட்டுங்க. ஏன் இன்னொரு option குறைவாகப் பொருந்துகிறது என்று காரணம் எழுதலாம்; evidence இல்லாமல் போட்டித் திட்டத்தைக் குறை சொல்ல வேண்டாம்.

ஒரு குடும்பத்துக்கு Any Room முக்கியம். ஆனால் குறைந்த premium option Single Private Room மட்டும்தான் அனுமதிக்கிறது என்று வைத்துக்கலாம். Customer அந்த limit தெரிந்து ஏற்கிறாரா என்பதுதான் முக்கியம். Signature வாங்கியதால் மட்டும் புரிந்துவிட்டார் என்று ஆகாது.

CRM-இல் என்ன பதிவு செய்யணும்?

புலம்	பொருத்தமான பதிவு
தொடர்பு அனுமதி	விரும்பும் வழி, நேரம், தொடர்பு வேண்டாமென்ற Claim
தேவைக் குறிப்பு	குடும்பம், தற்போதைய பாதுகாப்பு, முக்கிய இடைவெளி
நிலை	Needs analysis / ஒப்பீடு / பதில் நிலுவை / முடிவு / சேவை

புலம்	பொருத்தமான பதிவு
அடுத்த செயல்	யார், என்ன, எந்த நாளில்
ஆவண இணைப்பு	அனுமதிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான சேமிப்பிட குறிப்பு
Customer முடிவு	தேர்வு மற்றும் ஏற்றுக்கொண்ட முக்கிய வரம்புகள்
Renewal	முடியும் தேதி, முன்கூட்டிய ஆய்வு நாள்

எல்லாரும் பார்க்கும் CRM note-ல் full medical report copy போடாதீங்க. தேவையான status-உம் பாதுகாப்பான document reference-உம் போதும். “Customer ரொம்ப difficult” என்று எழுதுவதற்கு பதிலாக, “Premium comparison வேண்டும்; வெள்ளிக்கிழமை பதில் எதிர்பார்ப்பு” என்று அடுத்த வேலைக்குப் பயன்படும் note எழுதுங்க.

Follow-up என்பது புதிய மதிப்பைக் கொடுக்க வேண்டும்

ஒவ்வொரு முறையும் “முடிவு பண்ணிட்டீங்களா?” என்று கேட்பது pressure ஆகலாம். Pending question-க்கு official answer, corrected comparison, கேட்ட document கொடுப்பது useful follow-up. ஒப்புக்கொண்ட நேரத்தில் தொடர்புகொள்ளுங்க. Reply இல்லை என்றால் company contact policy-உம் customer preference-உம் மதிக்கணும்.

Sample message: “வணக்கம். நேற்று கேட்ட room eligibility-க்கான official details அனுப்பியிருக்கேன். முக்கிய difference ... . நீங்க சொன்னபடி நாளை மாலை 6 மணிக்கு 10 நிமிடம் பேசலாமா? வேற நேரம் வசதின்னா சொல்லுங்க.” தொடர்புக்கான customer permission இருந்தால்தான் இந்த follow-up அனுப்பணும்.

Policy வழங்கியபின் சேவை

Policy வந்ததும் name, DOB, members, SI, term, nominee, medical conditions, selected options check செய்ய உதவுங்க. Free Look right, claim contact route விளக்குங்க. Policy documents எங்கே வைத்திருக்கிறார், emergency-ல் குடும்பத்தினர் எப்படி எடுத்துப் பார்ப்பார்கள் என்று பேசலாம். Medical details பகிர்வுக்கு உரிய consent வேண்டும்.

Renewal service-ஐ முன்பே ஆரம்பிங்க. புதிய குழந்தை, திருமணம், வேலை மாற்றம், hospital preference, SI change போன்ற details update செய்யுங்க. Sale முடிந்ததும் service முடிந்துவிடாது. தேவைப்படும் நேரத்தில் தெளிவாக உதவணும்.

தொழில்முறை உரையாடல்

Customer: “நான் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை.”

Advisor: “சரி. இன்னும் என்ன details வேணும்? அடுத்து எப்போ பேசலாம் என்று நீங்க சொல்லுங்க. அதற்குள் pending question-க்கு சரியான answer வாங்கி வைக்கிறேன்.”

இந்தத் தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்

Customer தேவைக்கு முன் தயாரிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தல், ஒரே விலை Quote-ஐ பல குடும்பங்களுக்கு அனுப்புதல், நிலுவை மருத்துவ மதிப்பீட்டை ஏற்றுக்கொள்ளலாகக் சொல்வது, ஆவணப் பிழையைப் பார்க்காமல் விற்பனை முடிந்ததாகக் கருதுதல், Renewal நாளில் மட்டும் நினைவூட்டுதல் ஆகியவை தவறுகள். ஒவ்வொரு தேர்வும் உண்மையான Policy நிபந்தனை மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ மேற்கோளுக்கு உட்பட்டது.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

Consultation customer தேவையிலிருந்து ஆரம்பித்து தொடர்ந்து service-ஆகப் போகிறது. CRM பெயர், number பட்டியல் மட்டும் இல்லை; அடுத்து சரியான வேலை செய்ய உதவும் பதிவு. Sales count-உடன் customer understanding, document accuracy, service quality-யும் பார்க்கணும்.

நீங்களே முயற்சி செய்யுங்க

1. முதல் தொடர்பில் எந்த மூன்று விஷயங்களை உறுதிசெய்வீங்க? 2. ஒப்பீட்டுக் குறிப்பில் விலைக்கு அப்பால் என்ன இருக்கணும்? 3. பயனுள்ள Follow-up செய்தியை எழுதுங்க. 4. Policy வழங்கிய பிறகு சரிபார்க்க வேண்டிய ஐந்து புலங்கள் என்ன?

பதில் சரியா பார்ப்போம்: சரியான நபர், அனுமதி, நேரம்; ஒரே குடும்ப / தொகை அடிப்படை, நன்மை மற்றும் வரம்பு; நிலுவைக் கேள்விக்குப் பதிலும் ஒப்புக்கொண்ட அடுத்த படியும்; பெயர், உறுப்பினர், காலம், தொகை, நிபந்தனை உள்ளிட்ட பொருத்தமான புலங்கள்.

Advisor Checklist

- தொடர்புக்கான அனுமதியும் தேவையும் பதிவு செய்யப்பட்டனவா?
- ஒப்பீடு ஒரே அடிப்படையில் உள்ளதா?
- Customer புரிதல் உறுதிசெய்யப்பட்டதா?
- அடுத்த செயலுக்கு பொறுப்பாளரும் தேதியும் உள்ளனவா?
- Policy ஒப்படைப்பு மற்றும் Renewal சேவைத் திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளதா?

ஆதாரம்: ஆசிரியர் உருவாக்கிய சேவைப் பயிற்சி அமைப்பு; Free Look மற்றும் Policyholder பாதுகாப்புகளுக்கு R01–R03. நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனை மற்றும் CRM நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

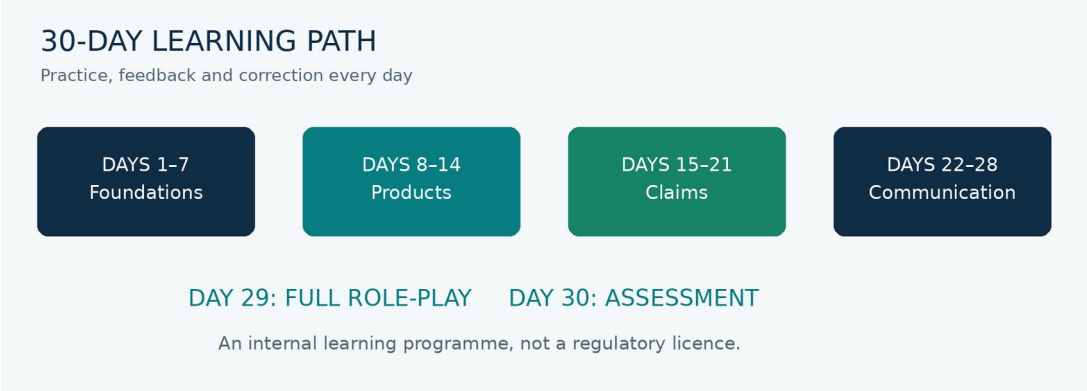
அத்தியாயம் 20

30 நாளில் படித்து பேசிப் பயிற்சி செய்யலாம்

30-Day Expert Advisor Training Programme

இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன கற்கலாம்

படிப்பது மட்டும் இல்லாமல், கணக்கு போடுவது, customer போலப் பேசிப் பார்ப்பது, source தேடுவது, தவறைத் திருத்துவது என தினசரி practice செய்யலாம். 30 நாட்களின் முடிவில் ஒரு full consultation நடத்திப் பார்க்கத் தயாராகுவதே நோக்கம்.



படம் 20.1 • முப்பது நாள் கற்றல் பாதை.

பயிற்சியின் அமைப்பு

தினமும் 60–90 நிமிடங்கள் ஒதுக்கலாம். உதாரணமாக வாசிப்பு 20 நிமிடம், செய்முறைப் பயிற்சி 20 நிமிடம், customer role-play 15 நிமிடம், quiz 10 நிமிடம்; மீதிநேரத்தில் திருத்தம் செய்யலாம். வேகமாக முடிப்பதைவிட சரியாகச் செய்வது முக்கியம். தினமும் ஒரு கணக்கு, comparison, conversation note அல்லது checklist தயாராகட்டும்.

இது உள் திறன் வளர்ப்புக்கான training plan. Licence, official exam, regulatory certificate-க்கு மாற்று இல்லை. உண்மையான customer medical details தேவையில்லை; இந்தப் புத்தகத்தின் கற்பனைக் cases-ஐ பயன்படுத்துங்க.

சிம்பிளாக கற்றல் சுற்று

படி	பயிற்சியாளர் செயல்
படி	கருத்தை வாசித்து முக்கிய வரம்பைக் குறித்தல்

படி	பயிற்சியாளர் செயல்
செய்	கணக்கு அல்லது ஆவணப் பயிற்சி முடித்தல்
சொல்	Customer-க்கு சிம்பிளாக விளக்குதல்
சோதி	Quiz மற்றும் பார்வையாளர் மதிப்பீடு
திருத்து	தவறை எழுதிப் புதிய பதிலை உருவாக்குதல்

முதல் வாரம்: அடித்தளம்

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
1	அத்தியாயம் 1; Risk Pooling-ஐ ஒரு பத்தியில் எழுதுக	Premium சேமிப்பா? இல்லை; பாதுகாப்புக்கான கட்டணம்
2	அத்தியாயம் 2; ஏழு காப்பீட்டு வகைகளை ஒப்பிடுக	Floater தொகை ஒவ்வொருவருக்குமா? பொதுவாகப் பகிர்ந்தது
3	அத்தியாயம் 3; இளம் குடும்பத்திற்கான Needs analysis	தயாரிப்பிற்கு முன் என்ன கேட்பீங்க? குடும்பம், பாதுகாப்பு, Budget
4	அத்தியாயம் 4; Co-payment மற்றும் Deductible கணக்கு	₹2 லட்சத்தில் 10% = ₹20,000
5	அத்தியாயம் 4; Room Rent மற்றும் Sub-limit விளக்கம்	அதிக Sum Insured Sub-limit-ஐ நீக்குமா? இல்லை

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
6	அத்தியாயம் 5; மூன்று Waiting காலவரிசைகள்	Accident விதிவிலக்கு எல்லா விலக்கையும் நீக்குமா? இல்லை
7	வார மறுபரிசீலனை; ஐந்து சொற்களை 60 வினாடிகளில் விளக்குக	பார்வையாளர் எளிமை, துல்லியம், வரம்பு மதிப்பிடுக

இந்த வார முடிவில் தயாராக வேண்டியது: ஒரு family needs note, இரண்டு calculations, ஒரு Waiting Period timeline. கணக்கு தவறா, “எல்லாம் cover” என்று எழுதியிருக்கீங்களா என்று பாருங்க. இருந்தால் அடுத்த வாரத்துக்கு முன் திருத்துங்க.

இரண்டாம் வாரம்: மருத்துவ மதிப்பீடும் தயாரிப்பும்

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
8	அத்தியாயம் 6; நீரிழிவு வழக்கின் தகவல் பட்டியல்	பரிசோதனை Proposal-க்கு மாற்றா? இல்லை
9	அத்தியாயம் 6; ஐந்து சாத்திய மதிப்பீட்டு முடிவுகள்	ஏற்றுக்கொள்ளலை யார் தீர்மானிக்கிறார்? நிறுவனம்
10	அத்தியாயம் 7; நான்கு UIN-களை ஆவணத்தில் கண்டறிக	கோப்புப் பெயரா UIN-ஆ முக்கியம்? ஆவணத்தின் UIN
11	அறை மற்றும் சொந்தச் செலவுப் பங்கு ஒப்பீடு	Health Assure ₹5 லட்சத்தில் 1% = ₹5,000 நாள்
12	Waiting மற்றும் மகப்பேறு ஒப்பீடு	தனி Sub-limit உள்ளதா? தயாரிப்பின்படி பார்க்கணும்

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
13	Super Star விருப்பங்களை அடிப்படையிலிருந்து பிரிக்கவும்	Quick Shield எல்லா PED-க்கும் முதல் நாளா? இல்லை
14	ஒரு குடும்பத்திற்கு இரண்டு தயாரிப்புப் பரிந்துரை	காரணம், வரம்பு, நிலுவைத் தகவல் ஆகியவற்றைச் சொல்லுக

இந்த வார முடிவில் official documents வைத்து product comparison தயாராகணும். ஒவ்வொரு number, rule-க்கும் source section எழுதுங்க. தெரியாததை “சரிபார்க்கணும்” என்று குறிக்கலாம்; guess செய்து நிரப்ப வேண்டாம்.

மூன்றாம் வாரம்: தொகையும் Claim-யும்

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
15	அத்தியாயம் 8; ₹5/₹10/₹20 லட்சம் ஒப்பீடு	₹14 லட்சம் செலவு, ₹10 லட்சம் வரம்பு: ₹4 லட்சம் பற்றாக்குறை
16	அத்தியாயம் 9; மூன்று Aggregate Claims கணக்கு	₹3 + ₹4 லட்சம், ₹5 லட்சம் Deductible: ₹2 லட்சம் கூடுதல் cover
17	அத்தியாயம் 10; Cashless செயல்முறை வரைபடம்	ஆரம்ப அனுமதி இறுதியா? இல்லை
18	அத்தியாயம் 10; விடுவிப்புத் தாமதக் காலவரிசை	3 மணி நேரத்தின் தொடக்கம்: Hospital Claim பெறுதல்
19	அத்தியாயம் 11; கற்பனை Claim-க் கோப்பை அமைக்கவும்	பிலும் ரசீதும் ஒரே ஆவணமா? இல்லை

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
20	அத்தியாயம் 12; மறுபரிசீலனைக் கடிதம் எழுதுக	கடிதத்தில் காரணமும் பிரிவும் தேவை
21	அத்தியாயம் 13; உரிமை மற்றும் தயாரிப்பு விதி பிரிப்பு	Moratorium எல்லா விலக்கையும் நீக்குமா? இல்லை

இந்த வார முடிவில் Cashless timeline, Reimbursement document index, evidence-உடன் review/grievance letter தயாராகணும். Doctor தரவேண்டிய medical reply-ஐ நாம உருவாக்கக் கூடாது. எந்த தகவல் தேவை என்று மட்டும் குறிப்பிடுங்க.

நான்காம் வாரம்: உரையாடலும் சேவையும்

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
22	அத்தியாயம் 14; Portability ஒப்பீடு	புதிய ஏற்றுக்கொள்ளலுக்கு முன் பழையதை ரத்து செய்யலாமா? வேண்டாம்
23	அத்தியாயம் 15; கேள்விகள் 1–10 பயிற்சி	ஒவ்வொரு பதிலும் ஒரு வரம்புடன் இருக்கட்டும்
24	அத்தியாயம் 15; கேள்விகள் 11–20 பயிற்சி	மருத்துவ வெளிப்படுத்தலை எளிமையாகச் சொல்லுக
25	அத்தியாயம் 15; கேள்விகள் 21–30 பயிற்சி	தெரியாததற்கு சரிபார்ப்பு நாள் கொடுக்கவும்
26	அத்தியாயம் 16; விலை மற்றும் Claim தயக்கப் பயிற்சி	Customer முடிவை மதிக்கிறீர்களா?

நாள்	பாடமும் செயல்பாடும்	உரையாடல் / **Quiz**
27	அத்தியாயம் 17; மூன்று வழக்குகளுக்கான குறிப்புகள்	உண்மை, Assumption, நிலுவைத் தகவல் பிரிக்கப்பட்டதா?
28	அத்தியாயங்கள் 18–19; CRM மற்றும் நெறிமுறை ஆய்வு	சம்மதம், அடுத்த செயல், பொறுப்பாளர் உள்ளனரா?

இறுதி இரண்டு நாட்கள்

நாள் 29: 20 நிமிட full consultation செய்து பாருங்க. Young family அல்லது senior parents case தேர்வு செய்யலாம். Needs analysis, இரண்டு options, ஒரு கணக்கு, முக்கிய limits, medical disclosure, next step எல்லாம் பேசணும். ஒருவர் customer, ஒருவர் observer ஆக இருக்கலாம். Actual customer details வேண்டாம்.

நாள் 30: கீழே உள்ள written questions, calculation, conversation assessment முடிங்க. Marks மட்டும் பார்க்காதீங்க; எங்கே தவறு, அதை எப்படித் திருத்தினீங்க என்பதும் முக்கியம். குழப்பமான topic-க்கு மீண்டும் reading, practice date வையுங்க.

இறுதி எழுத்துத் தேர்வு: 20 கேள்விகள்

ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 2 marks; மொத்தம் 40. சின்ன பதில் போதும். கணக்குக்கு assumption தேவைப்பட்டால் அதை எழுதுங்க.

1. Premium மற்றும் Sum Insured வேறுபாடு என்ன?

2. Indemnity மற்றும் Benefit Policy-களை ஒரு வாக்கியத்தில் வேறுபடுத்துங்கள்.

3. ₹4 லட்சம் ஏற்கத்தக்க Claim-ல் 10% Co-payment எவ்வளவு?

4. ₹5 லட்சம் Aggregate Deductible-இல் ₹2, ₹3, ₹4 லட்சம் Claims-க்கான கூடுதல் cover மொத்தம் என்ன?

5. அதே Claims-க்கு ஒவ்வொரு Claim-க்கும் ₹5 லட்சம் Deductible என்றால் என்ன?

6. Family Floater-இல் ₹10 லட்சம் என்றால் நான்கு பேருக்கும் தலா ₹10 லட்சமா?

7. மருத்துவப் பரிசோதனை செய்ததால் பழைய நோயைத் தெரிவிக்க வேண்டாமா?

8. தொடக்கக் Waiting-உம் PED Waiting-உம் எப்படி வேறுபடும்?

9. UIN ஏன் முக்கியம்?

10. Any Room என்பதற்கு எல்லா செலவும் ஏற்கப்படும் என்று பொருளா?

11. Cashless ஆரம்ப அனுமதி இறுதி தீர்வா?

12. விடுவிப்புக்கான மூன்று மணி நேர விதி எந்த நிகழ்விலிருந்து தொடங்குகிறது?

13. Claim அறிவிப்புக்குப் பிறகு Hospital ஆவணங்களைச் சேகரிக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு?

14. Claim Rejection letter-ல் என்ன இருக்கணும்?

15. Moratorium பொதுவாக எத்தனை தொடர்ச்சியான மாதங்கள்? முக்கிய விதிவிலக்கு என்ன?

16. Sum Insured உயர்த்தப்பட்ட பகுதிக்கான Moratorium எப்போது தொடங்கும்?

17. Portability மற்றும் Migration வேறுபாடு என்ன?

18. Grace Period-இல் தொடர்ச்சி பாதுகாக்கப்படுவது எல்லா இடைவெளிச் செலவையும் உறுதிசெய்கிறதா?

19. Customer தொடர்பு வேண்டாம் என்றால் என்ன செய்வீங்க?

20. தெரியாத தயாரிப்பு நன்மைக்கான தொழில்முறை பதில் என்ன?

பதில் சரியா பார்ப்போம்

1. பாதுகாப்புக்கான கட்டணம் / Admissible expense-க்கான ஒப்பந்த வரம்பு. 2. உண்மையான ஏற்கத்தக்க இழப்பை ஈடு செய்தல் / வரையறுக்கப்பட்ட நிகழ்வுக்கு நிர்ணயத் தொகை. 3. ₹40,000. 4. ₹4 லட்சம்; அனைத்தும் ஏற்கத்தக்கவை, ஒரே ஆண்டு, போதிய வரம்பு என்ற அனுமானத்தில். 5. ₹0. 6. இல்லை; பொதுவாகப் பகிர்ந்த தொகை. 7. இல்லை; Proposal உண்மைத் தகவல் அவசியம். 8. தொடக்க நோய்க் காலம் / முன்பிருந்த நோய்க்கான தனிக் காலம். 9. சரியான தயாரிப்புப் பதிப்பை அடையாளம் காண. 10. இல்லை; மற்ற விதிகள் தொடரும்.

11. இல்லை. 12. Hospital-ன் இறுதி அனுமதிக் Claim பெறப்பட்ட நேரம். 13. Insurer / TPA, R01 பத்தி 17(c). 14. காரணமும் குறிப்பிட்ட Policy-ப் பிரிவும். 15. 60 மாதங்கள்; நிறுவப்பட்ட மோசடி விதிவிலக்கு. 16. அதிகரிப்பு நாளிலிருந்து அந்தப் பகுதிக்கு. 17. வேறு நிறுவனம் / அதே நிறுவனம். 18. இல்லை; Coverage விதியைத் தனியாகப் பார்க்கணும். 19. விருப்பத்தைப் பதிவு செய்து மதிக்க வேண்டும். 20. அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரத்தைச் சரிபார்த்து குறிப்பிட்ட நாளில் பதிலளிப்பதாகக் சொல்வது.

கணக்குப் பயிற்சி: 20 மதிப்பெண்கள்

பகுதி A — 10 மதிப்பெண்கள்: கற்பனைப் பில் ₹4,20,000; Non-payable expense ₹20,000; பொருந்தும் Sub-limit-க் கழிவு ₹50,000; மீதிக்கு 10% Co-payment. எளிய வரிசையில் Insurer மற்றும் Customer தொகையைக் கணக்கிடுங்கள். விடை: ஏற்கத்தக்க அடிப்படை ₹3,50,000; Co-payment ₹35,000; Insurer ₹3,15,000; Customer ₹1,05,000. உண்மையான கழித்தல் வரிசை Policy-ப்படி சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

பகுதி B — 10 மதிப்பெண்கள்: ₹5 லட்சம் Deductible, ₹15 லட்சம் கூடுதல் cover வரம்பு; ஆண்டு Admissible expense ₹24 லட்சம். அடிப்படை முதல் ₹5 லட்சத்தை முழுமையாக ஏற்கிறது; பிற கழிவுகள் இல்லை. விடை: கூடுதல் cover ₹15 லட்சம்; சொந்தப் பற்றாக்குறை ₹4 லட்சம். ₹19 லட்சம் Deductible-க்கு மேலே இருந்தாலும் கூடுதல் cover வரம்பு ₹15 லட்சம் மட்டுமே.

உரையாடல் மற்றும் ஆவண நீங்க செய்ய வேண்டியது: 40 மதிப்பெண்கள்

திறன்	மதிப்பெண்	முழு மதிப்பெண்ணிற்கான அடையாளம்
Needs analysis	10	குடும்பம், தற்போதைய பாதுகாப்பு, Hospital, Budget கேட்கப்பட்டன
விளக்கம்	10	எளிய தமிழ், சரியான கணக்கு, வரம்பு விளக்கம்
ஆதாரம்	10	UIN, தற்போதைய ஆவணம், நிலுவைத் தகவல் தெளிவு
நெறிமுறை / பதிவு	10	உண்மைத் தகவல், சம்மதம், அழுத்தமின்மை, அடுத்த செயல் பதிவு

இந்த internal practice-க்கு 80/100-ஐ முன்னேற்ற இலக்காக வைத்துக்கலாம்; அது regulatory pass mark இல்லை. Disclosure மறைக்கச் சொல்வது, fake document, உறுதியில்லாத claim guarantee, consent இல்லாமல் medical details பகிர்வது போன்ற serious தவறு இருந்தால் marks இருந்தாலும் மறுபயிற்சி செய்யணும்.

Advisor-க்கான குறிப்புகள், தவறுகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

30 நாட்கள் முடித்துவிட்டோம் என்பதால் எல்லாம் தெரிந்துவிட்டது என்று நினைக்க வேண்டாம். சரியான source தேடவும், தவறை ஒப்புக்கொண்டு திருத்தவும், customer-க்கு limits விளக்கவும் தொடர்ந்து பழகணும். Product benefit மாறினால் training answer-உம் மாறணும். இங்குள்ள calculations கொடுத்த assumptions-க்குள் மட்டுமே பொருந்தும்.

நினைவில் வைத்துக்கலாம்

30 நாள் practice நல்ல ஆரம்பம். தொடர்ந்து official documents படிப்பது, cases பார்க்குவது, service quality review செய்வது, தவறுகளைத் திருத்துவதில்தான் திறமை வளர்கிறது.

சுயபரிசீலனைக் கேள்விகள்

இன்னும் எந்த மூன்று topics-ல் help தேவை? எங்கே உறுதியாகத் தெரியாததை உறுதியாகச் சொன்னீங்க? அடுத்த 30 நாளில் எந்த official document மீண்டும் படிக்கப் போறீங்க? பதில்களை எழுதுங்க. முன்னேற்றத்துக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட action தேர்வு செய்து date வையுங்க.

Advisor Checklist

• 30 நாள் வெளியீடுகள் மற்றும் திருத்தங்கள் சேமிக்கப்பட்டனவா?

• கணக்குகள் அனுமானத்துடன் சரியாக உள்ளனவா?

• குறைந்தது இரண்டு முழு ஆலோசனைப் பயிற்சிகள் முடிந்தனவா?

• ஆதாரப் பதிப்புகள் மற்றும் நிலுவைக் கேள்விகள் புதுப்பிக்கப்பட்டனவா?

• மறுபயிற்சி மற்றும் தொடர்ந்த கற்றல் நாள் குறிப்பிட்டதா?

ஆதாரம்: இந்த அத்தியாயம் ஆசிரியர் உருவாக்கிய பயிற்சி மற்றும் உள் மதிப்பீட்டு அமைப்பு. சட்ட மற்றும் தயாரிப்புப் பதில்களுக்கு அத்தியாயங்கள் 7, 13 மற்றும் R01–R03, P01–P04 ஆதாரங்களைப் பாருங்க.

ஆதாரப் பதிவு

இந்த நூலுக்குப் பயன்படுத்திய முக்கிய official sources கீழே உள்ளன. File name-ஐ மட்டும் நம்பாமல் உள்ளே இருக்கும் UIN-உம் customer policy version-உம் பார்க்கணும். இந்த மொழிநடைப் பதிப்பு புதிய regulatory verification அல்ல; தொடக்கத்தில் சொன்ன source limitations தொடர்ந்து பொருந்தும்.

R03 IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024, Schedule III; Gazette of India, 22 March 2024

https://financialservices.gov.in/sites/default/files/Act-Policies/2026-01/IRDAI--Insurance-Products--Regulations--2024.pdf

R01 IRDAI Master Circular on Health Insurance Business, 29 May 2024, IRDAI/HLT/CIR/PRO/84/5/2024

https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=4942918

R02 Council for Insurance Ombudsmen, Procedure to Lodge a Complaint

https://www.cioins.co.in/Procedure/Index

S00 Star Health official downloads and product list

https://www.starhealth.in/downloads/ | https://www.starhealth.in/list-products/

P01 Super Star — Policy Wording | UIN SHAHLIP27049V022627

https://d28c6jni2fmamz.cloudfront.net/Policy_Super_Star_V_3_80e5dd8988.pdf

P02 Star Comprehensive — Policy Wording | UIN SHAHLIP26044V092526

https://d28c6jni2fmamz.cloudfront.net/Policy_Star_Comprehensive_Insurance_Policy_V_21_3a414ab104.pdf

P03 Star Health Assure — Policy Wording | UIN SHAHLIP26048V032526

https://d28c6jni2fmamz.cloudfront.net/Policy_Star_Health_Assure_Insurance_Policy_V_9_c53663e68a.pdf

P04 Star Women Care — Policy Wording | UIN SHAHLIP23132V022223

https://d28c6jni2fmamz.cloudfront.net/Policy_Star_Women_Care_Insurance_Policy_V_10_df1ca05df6.pdf

முந்தைய ஆய்வுப் பதிவின்படி source retrieval date: 10 அக்டோபர் 2026. மொழிநடைப் பதிப்பு: 24 அக்டோபர் 2026. கணக்குகளும் customer கதைகளும் பயிற்சிக்கான கற்பனைகள்.

FUTURE SECURE PROVIDERS

தெளிவான விளக்கம். பொறுப்பான ஆலோசனை. தொடர்ந்த சேவை.

மருத்துவக் காப்பீட்டின் அடிப்படையிலிருந்து கோரிக்கை உதவி வரை, வாடிக்கையாளரின் தேவையைப் புரிந்துகொண்டு செயல்பட உதவும் தொழில்முறைப் பயிற்சி நூல்.

20 அத்தியாயங்கள் • 30 கேள்வி–பதில்கள் • 15 நடைமுறை வழக்குகள் • 30 நாள் பயிற்சி

உண்மைத் தகவல், தெளிவான வரம்புகள், ஆவண ஆதாரம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சம்மதம் ஆகியவற்றை ஒவ்வொரு ஆலோசனையிலும் முன்னிலைப்படுத்துங்கள்.

Future Secure Providers : Call 9585 905 905, 9363 705 905.

https://futuresecureproviders.com

இந்த நூலில் உள்ள வாடிக்கையாளர் நிகழ்வுகள் கற்பனையானவை. படங்கள் திட்டத்திற்காக AI மூலம் உருவாக்கப்பட்டவை. உண்மையான பாலிசியின் விதிகள், அட்டவணை மற்றும் இணைப்புத் திருத்தங்கள் பொருந்தும்.